

Хирургическое лечение

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПИЩЕВОДА

Арзыкулов Ж.А., Ижанов Е.Б., Есентаева С.Е., Турешева А.О., Ким В.Б., Абдрахманов Р.З.
КазНИИ онкологии и радиологии, Республика Казахстан, г.Алматы

Актуальность. Рак пищевода (РП) – наиболее неблагоприятная по течению злокачественная опухоль, на долю которого приходится около 6% от всех желудочно-кишечных новообразований.

В Республике Казахстан (РК) в общей структуре заболеваемости злокачественных новообразований РП занимает пятое ранговое место, составив в 2008 году 6,3%. Ежегодно по РК выявляются до 1700 больных РП, погибает от данного недуга до 1500 человек в год.

В этой связи особую актуальность приобретают исследования, направленные на поиск более эффективных методов лечения рака данной локализации.

В настоящее время в современной литературе возникло новое понятие – мультимодальная терапия, подразумевающая проведение различных вариантов неоадьювантной химио-, а также лучевой терапии ЛТ с последующим оперативным лечением, результаты которой еще не до конца изучены и представляют повышенный интерес для абдоминальной онкологии.

Применение двух методов лечения – лучевой и химиотерапии в дооперационном периоде преследует две цели: уменьшение размеров первоначальной опухоли и уничтожение распространившихся опухолевых клеток по организму, так называемых микрометастазов. Применение этих методов позволяет значительно улучшить результаты лечения.

Цель исследования: повышение эффективности лечения местно-распространенных форм рака пищевода

Материалы и методы: в предоперационном периоде пациентам исследуемой группы (28 больных) проводился курс неоадьювантной химиотерапии по схеме: гемцитабин 1000 мг/м² в/в 1,8 дни + цисплатин 75 мг/м² в/в 1-ый день, через 21 день повторяли курс химиотерапии в аналогичном режиме в сочетании с конформной лучевой терапией РОД-2,0 Гр; СОД-50Гр; 5 фракций в неделю.

Результаты: на фоне лечения в 40% (11/28) случаях получен субъективный эффект, который выражался в значительном улучшении общего состояния, оцениваемого 1-2 степенью активности по шкале Карновского, полном купировании дисфагии и болей в грудной клетке.

Объективный эффект достигнут в 67,9% (15/28) случаев, из них у 4 (14,3%) пациентов отмечена полная регрессия опухоли, у 15 (53,6%) больных – частичная резорбция. Стабилизация процесса прослежена у 9 (32,1%) больных.

Лейкопения I-II степени наблюдалась у 11 (39,3%) пациентов.

Летальных случаев в послеоперационном периоде отмечено не было.

Таким образом, предварительные результаты исследования показали клиническую эффективность предлагаемого режима химиолучевой терапии у больных раком пищевода, не сопровождающуюся увеличением лимитирующей токсичности и характеризующуюся улучшением качества жизни данной категории больных, неотягощая течение послеоперационного периода.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ОНКОЛОГИИ

Дарменов О.К., Оразбеков Н.И.,
Курбанов Ш.А., Избасаров Р.Ж.
Кафедра хирургии с курсом кардиохирургии,
анестезиологии-реанимации и УЗ-диагностики, КазНМУ
имени С.Д.Асфендиярова, г.Алматы

Опухоли кожи по частоте среди всех опухолевидных заболеваний кожи занимают IV место. По данным разных авторов, опухоли кожи встречается у 25% населения. Наиболее высокий рост среди заболеваемости кожи локализуется на открытых участках тела. Онкологическая настороженность, знание признаков, симптомов проявлений опухолевидных изменений, наличие современных средств и методов диагностики, в том числе морфологическая верификация позволяют избежать диагностических ошибок.

Несмотря на современные возможности пластической хирургии закрыть любой дефект, любой локализации, хирургическое лечение больших и гигантских образований кожи на сегодняшний день остается актуальной проблемой и требует комплексного подхода.

В большинстве случаев такие пациенты нуждаются в хирургическом лечении, которое должно учитывать не только функциональный, но так же и эстетический эффект.

Больной Ф, 27 лет. Диагноз – врожденная гемангиома височной области головы справа. Локализация – от границы роста волос височно-лобной части головы медиально до внутреннего края правой брови, включая верхнее и нижнее веко, основание спинки носа, вниз до дуги скуловой кости и латерально спереди ушной раковины до уровня козелка.

Вся правая половина лица деформирована, правый глаз не открывается, правый угол ротовой полости не закрывается. Выраженный лимфостаз нижней части лица, кожная складка свисает от уровня нижней челюсти на 3-4 см.

Мобилизованы края раны вверх и вниз кожно-жировые лоскуты с помощью дополнительных разрезов подняты над всей гемангиомой. Гемангиома удалена в пределах здоровых тканей, излишки кожи после выкройки по форме раны иссечены, раневая поверхность закрыта полностью.

Течение послеоперационного периода без особенностей. Больной в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное долечивание.

Повторный осмотр через 8 месяцев показал хороший результат. На отдельных участках умеренная гиперемия рубцов сохраняется, рубцы мягкие подвижные без признаков келоида. Пересаженные расщепленные аутоотрансплантаты на верхнем и нижнем веке прижились. Функциональный и эстетический результат хороший. Слабые признаки микростомии при оскале зубов в правом углу ротовой полости. Результатом выполненной операции больной вполне удовлетворен.

Преимущество применения современных методов пластической хирургии как дермобразия, использование сложных кожно-фасциальных и других лоскутов питающих на ножке, а также сложных лоскутов на микроанастомозах позволяет добиться хорошего функционального и эстетического результата, что отвечает требованиям современной пластической хирургии. Хирургическое лечение большой гемангиомы включало мобилизацию краев раны, перемещение лоскутов на ножке и пластику отдельных дефектов расщепленным трансплантатом.

Таким образом, благодаря методике удалось избежать

вторичного изменения пересаженного аутоотрансплантата и деформацию донорского участка. Мы рекомендуем данную методику как альтернативный вариант лечения при опухолевидных заболеваниях кожи.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Кулмаганбетова А. А.

Кызылординский областной онкологический центр.

За последнее время отмечается рост обращаемых больных с узловыми образованиями щитовидной железы. В 2005 г количество больных составляло 56 человек, в 2009 г 167 больных. Всем больным проводится комплекс диагностических мероприятий (УЗИ щитовидной железы, определение уровня гормонов щитовидной железы, тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ). Показаниями к оперативному лечению являются – злокачественный процесс, подозрение к злокачественному процессу, рост в динамике, компрессионный синдром, косметический дефект. Минимальный объем оперативного лечения является – гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка.

В течение 2006-2010 г.г. в областном онкологическом центре оперативное вмешательство проведено 132 больным с узловыми образованиями щитовидной железы. Гемитиреоидэктомия с удалением перешейка проведено в 107 случаях, из них в 5 случаях установлен рак щитовидной железы. Всем больным проведена повторная операция с удалением противоположной доли. Субтотальная резекция щитовидной железы проведена 12 больным. Операция в объеме тиреоидэктомия проведена 13 больным. Рак щитовидной железы установлен в 7 случаях.

Послеоперационное осложнение как повреждение возвратного нерва наблюдалось в 5 случаях (3,8%).

ӨКПЕ ІСІГІ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН РЕКОНСТРУКТИВТІ-ПЛАСТИКАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ.

Қарасаев М.И.

Қазақтың Онкология және Радиология Ғылыми Зерттеу Институты

Өкпе ісігінің трахеобронхиальді хирургиясы жылдам дамуда. Оперативті әдістің өзгеруі - кеңірдек пен бронхқа резекция жасау мүмкіншілігін кеңейтті. Бірмезгілде кеңейтілген лимфодиссекция жасау позициясын қарастыру - өкпе ісігінің хирургиялық емінің қазіргі нұсқасы болып отыр.

Кілттік сөздер: өкпе ісігі, трахеобронхиальді хирургия, лимфодиссекция.

Бронх және трахея, әсіресе оның бифуркациялық сегментінің резекциясы жоғарғы қауіп-қатер дәрежесіне, техникалық, анестезиологиялық қамтамасыздандыру қиындықтарына байланысты трахеобронхиальді хирургияда «күрделі» категорияға жатады (Б. В. Петровский, М. И. Перельман және соавт., 1978; В. П. Харченко және соавт., 1982 және басқалар). Операция техникалық орындалуы И. С. Колесников және соавторлары сипатталған әдіс бойынша лимфаденэктомиямен жаслады. Соңғы жылдары лимфогенді метастаздану ерекшелігін ескере отырып лимфаденэктомия терминінің орнына лимфодиссекция қолданылып жүр және оперативті араласудың жаңа нұсқалары қарастырылуда (М. И. Давыдов және соавт., 1994; Л.Н. Бисенков және соавт., 1998 және басқалар). Осыған байланысты реконструктивті-пластикалық операцияның радикалдығын қамтамасыз ететін хирургиялық әдістің принципіалді маңызды сұрақтарына қатысы бар жағдайлар өкпе ісігінде қажетті компонент болып табылатын кеңейтілген операция (лимфодиссекция) арнайы бағаны қажет етеді.

Зерттеу мақсаты: Лимфодиссекциясыз және лимфодиссекциямен жасалған реконструктивті-пластикалық операция-

ларын нәтижелееу.

Реконструктивті-пластикалық операцияның материалы, нұсқалары және нәтижелері.

171 науқасқа хирургиялық ем жасалған (ерлер - 141, әйел - 30; T2 - 112, T3 - 59; жалпақ жасушалы рак - 136, аденокарцинома - 35).

Реконструктивті-пластикалық операцияның көлемі: бөліктік резекция - 103, кеңірдектің кеуделік бөлімінің резекциясы - 7, пневмонэктомиямен жасалған кеңірдек бифуркациясының резекциясы - 61. Реконструктивті-пластикалық операцияның қолданылған нұсқалары: шеткілік (27), клиновидналық (52) және бронх пен кеңірдектің циркулярлы резекциясы (92).

Операция 1982 жылдан бері қолданыла бастаған. 1982-1987 жылдар аралығында 32 науқасқа лимфаденэктомиясыз реконструктивті-пластикалық операциясы жасалған.

1988-1998 жылдар аралығында 79 науқасқа лимфаденэктомиямен реконструктивті-пластикалық операция жасалған. 1998-2005 жылдар аралығында 59 науқасқа лимфодиссекциямен реконструктивті-пластикалық операциясы жасалған.

Реконструктивті-пластикалық операция жасау барысында өзіндік оперативті әдіс қолданылды: бронх пен кеңірдек диаметрінің сәйкессіздігінде анастомозға максимальді тартылу жүктемесін алдын алу мақсатында бронх пен кеңірдекке жалғанатын шеміршектің дистальді және проксимальді соңын тілмей және провизорлы тігіс салмай мембранозды қабырғасына клиновидті тігіс салынды.

Лимфаденэктомия И.С. Колесников бойынша жасалынды. Әдеби мәліметтерді ескере отырып, кеңірдек пен ірі бронхтың кең медиастенальді лимфаденэктомиясы мен «скелетизациясын» жасау оның жазылуына қолайсыз жағдай жасайды және тігістің тұрақсыздығының дамуына әкеледі (И. С. Колесников, С. Н. Соколов, 1960; Н.А. Жаворонков, 1987 және басқалар), негізінен трахеобронхиальді лимфа түйіндері алынды.

Лимфодиссекция жалпы қолданылған нұсқалар бойынша этаппен жүргізілді: трахеобронхиальді жоғарғы, төменгі (бифуркациялық), трахеальді, жоғарғы және төменгі кеудеаралық, сонымен қатар алдыңғы және артқы кеуде аралық лимфа түйіндері мен теріасты шелмай қабаты алынды.

Соңғы жылдары біздің клиникада лимфодиссекция кеудеішілік лимфа түйіндерінің процеске қатысы болған не болмаған жағдайда барлық топтарын алумен аяқталған.

Реконструктивті-пластикалық операциялардың нәтижелерінің анализі: әдісті қалыптастырудың алғашқы кезеңінде және операцияны клиникаға енгізу барысында плевра ішілік қан кету (5 науқас) және анастомоздың тұрақсыздығы (7 науқас) сияқты асқынулар болды. 1988-1998 жыл аралығында жасалған реконструктивті-пластикалық операцияларды жасау кезінде көрсетілген асқынулар айтарлықтай азайды. Соңғы жылдары плевра ішілік қан кету және анастомоздың тұрақсыздығы сияқты қатерлі асқынулар 1,9 %-ға азайды. Алдын алу шараларының жасалуына қарамастан, бұрынғыдай өкпе артериясының тромбозынан науқастардың өлімі жалғаса берді. Тромбоэмболиялық асқынуларға, аяқтың варикозды кеңеюіне көңіл бөлінді және гиперкоагуляцияның болу - болмауына қарамастан антикоагулянтты терапия жүргізілді: тренталмен реополиглюкин, рефортан, гепарин немесе фраксипарин.

Бір жағдайда операцияның келесі күні хилоторакстың клиникасы диагностикаланды. Хилоторакстың даму себебі - кеуде ішілік лимфа түйіндеріне араласумен шақырылған тарамдалған кеуделік лимфатикалық жолдың зақымдалуы.

Консервативті шаралармен (өзіндік әдіс бойынша плевра қуысына резектелі дренаж арқылы 1% метилен көгінің сулы ерітіндісін енгізу) операциядан кейін 14 тәулікте хилоторакс жойылды.

Институтта лимфодиссекциямен жасалатын реконструктивті-пластикалық операцияны енгізу (1988-2005) аралығында операциядан кейінгі асқынулар 16,4 %,

летальдік - 10,5% болды.

Осылайша, зерттеу нәтижелері реконструктивті-пластикалық операцияларды орындауға мүмкіншілік беруді сипаттайды. Қазіргі кезде, өкпе ісігінде қолданылатын «кеңейтілген операциялар» түсінігіне лимфодиссекциямен қосарланған реконструктивті-пластикалық операция енгізілуі қажет.

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА

Боромбаев У.Т.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар

Актуальность: за последние 30 лет заболеваемость раком желудка в развитых странах снижается, вместе с тем общее число ежегодно заболевших остается значительным. По данным ВОЗ и американских исследователей в мире ежегодно регистрируется 755 тыс. новых случаев рака желудка (чаще регистрируется только рак легкого).

Цель работы: проанализировать эффективность видов лечения рака желудка за 3 года в Павлодарском областном онкологическом диспансере.

Материалы и методы: истории болезни, амбулаторные карты пациентов за 2007 – 2009 г.г., пролеченных с диагнозом: рак желудка.

Из общего числа выявленных больных I - II стадия болезни диагностирована у 108 пациентов (19,6%). Только у этой категории больных может идти речь об излечивании после хирургического вмешательства (проведение радикальной операции), III стадия выставлена 184 (33,8%) больным. 259 человек (47,1%) – это больные с IV стадией заболевания. При рассмотрении вопросов заболеваемости раком желудка отметим ряд важных моментов. За 3 года нам удалось снизить показатель запущенности с 56,2% в 2003г. до 47,1% в 2009, несмотря на неуклонный рост онкологической заболеваемости. Примерно в 50% случаев наших наблюдений рак желудка встречался в антральном отделе, в 30% - в теле желудка, в 8% - в кардиальном отделе и в 12% наблюдалось поражение двух и более отделов желудка. Преобладающей формой роста явился инфильтративный, который не имеет специфической клинической картины. В наших наблюдениях распространение опухоли на пищевод наблюдалось в 34 случаях, прорастание в поджелудочную железу - в 27, прорастание в кишечник - в 15 наблюдениях. Наиболее часто отдаленные метастазы обнаруживались в печени - 40%, в забрюшинных лимфоузлах - 12%, в легких - 8%, метастазы Вирхова, Крукенберга, Щницлера - в 3%, а также в костях, в головном мозге.

Основным методом лечения является оперативный. Радикальное хирургическое лечение возможно только у небольшого количества пациентов. Оптимальным объемом оперативного пособия на первичном очаге считают операции: тотальная и субтотальная гастрэктомия, резекция кардиального отдела желудка. За 3 года нами было выполнено 150 операций при раке желудка, из них радикальных - 68, что составило 45% от общего количества оперированных (гастрэктомии - 31, субтотальные резекции - 37), паллиативных операций проведено 44 (29%), которые выполнялись при осложненном раке желудка (кровотечения, стеноз), в отдельных случаях - даже при метастазах в печень. В 23% случаев операции носили эксплоративный характер (диагностический). 4 пациента оперированы в экстренном порядке ввиду наличия осложнений основного заболевания. Показатель операбельности составил - 46,8%, резектабельности - 29,2%. Умерло после операции 3 больных. Процент послеоперационной летальности составил 1,9%. Причинами смерти у больных явилась несостоятельность анастомоза после гастрэктомии - 1 случай, перитонит - 1 случай, сердечно-легочная недостаточность после резекции желудка,

осложненная двухсторонней нижнедолевой гнойной пневмонией - 1 случай. Процент послеоперационных осложнений составил - 2,9%. Противопоказаний к оперативному лечению было 11, что составило 3,7%, отказов больных от операции - 31 (10,9%). 57% больных получили только хирургическое лечение, комбинированное и комплексное - 31%, только лекарственное - 2%. По нашим данным, из числа пролеченных до 1 года жили 56,7%, от 1 до 2-х лет - 20,3%, более 2-х лет - 23%. Из числа проживших более 2-х лет основной процент приходится на больных, получивших комбинированное и комплексное лечение.

Выводы и заключение: проблема своевременной диагностики и эффективного лечения рака желудка остается до конца нерешенной. Низкие показатели раннего выявления больных требуют комплексного и комбинированного подходов к лечению. Паллиативная хирургическая помощь в сочетании с химиотерапией позволяет улучшить результаты лечения, в конечном итоге влияя на продолжительность и качество жизни онкобольных.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПИЩЕВОДА

Оспанов Ш.Е.

Кызылординский областной онкологический центр.

Ежегодно выявляют около 120-130 больных с данной патологией. Однако хирургическому лечению подвергаются около 10% (10-12) больных. Основными причинами отказа в хирургическом лечении является распространенность опухолевого процесса в связи с поздним обращением больного, наличие сопутствующей декомпенсированной патологии.

Хирургическое лечение проведено 42 больным. Из них мужчин 17, женщин 24. Возраст больных от 34 лет до 68 лет. У 11 больных опухоль располагалась в н/3 пищевода. У 32 больных в с/3 пищевода.

Радикальные операции выполнены 27 больным, из них 3 больным экстирпация пищевода с колопластикой. Паллиативно-шунтирующие операции проведены 3 больным. В 14 случаях произведены эксплоративные операции. Осложнения в послеоперационном периоде наблюдались у 8-х больных: Частичная несостоятельность анастомоза по типу дивертикула - 1. Несостоятельность швов культи желудка - 2. Несостоятельность дистальной культи пищевода - 1. Дыхательная недостаточность - 4. Частичная несостоятельность анастомоза по типу дивертикула выявлено в послеоперационном периоде при контрольной рентгеноскопии, консервативным методом лечения удалось добиться заживления дефекта. Несостоятельность швов культи желудка возникло у 2-х больных с последующим развитием эмпиемы плевральной полости. На фоне консервативного лечения заживление дефекта желудка достигнуто через 56 и 63 сутки. В раннем послеоперационном периоде умерло 4 больных от острой дыхательной недостаточности.

Таким образом, ведущим методом лечения рака пищевода является оперативное вмешательство, позволяющее улучшить качество жизни и продлить выживаемость больных.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА

Оспанов Ш.Е.

Кызылординский областной онкологический центр.

Рак желудка в Кызылординской области занимает одно из ведущих мест в рейтинге заболеваемости злокачественными опухолями. Около 25-30 процентах случаях выявляется в распространенной форме.

В промежуток 2004-2010г.г. 76 больным первичным раком желудка проведено оперативное лечение. Комбинированные операции проведены 14 случаях (18,5%).

- расширенная гастроплеаноэктомия с резекцией поперечно-ободочной кишки - 2

- расширенная гастроспленозэктомия с корпорокаудальной резекцией поджелудочной железы - 4
 - расширенная гастроспленозэктомия, корпорокаудальная резекция поджелудочной железы, резекция левой доли печени - 1.
 - расширенная гастроспленозэктомия с корпорокаудальной резекцией поджелудочной железы, резекцией поперечно-ободочной кишки - 2.
 - расширенная гастроспленозэктомия с резекцией диафрагмы - 1.
 - расширенная субтотальная резекция желудка с резекцией поперечно - ободочной кишки - 4.
- Осложнения наблюдались в 4 случаях.
 Дыхательная недостаточность - 2.
 Сердечно-сосудистая недостаточность - 2.

Несмотря на некоторые успехи комбинированных методов лечения, именно хирургический метод является «золотым» стандартом при радикальном лечении распространенного рака желудка, позволяющим надеяться на полное выздоровление.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКОГО

Оспанов Ш.Е.

Кызылординский областной онкологический центр.

Хирургическое лечение рака легкого является единственным эффективным методом. По данным разных авторов, операбельным является только 10-30% больных. Несмотря на постоянное совершенствование оперативной техники пятилетняя выживаемость колеблется в пределах 25-0%.

В течение 2006-2010г.г. в областном онкологическом центре произведено 76 оперативных вмешательств при раке легкого. Возраст больных составил от 23 до 76 лет. I-II ст – 12 больных, III ст – 29 больных, IIIB ст – 35 больных. Мужчин 35, женщин 41. Радикальные операции произведены 52 больным. Прецизионная резекция легкого – 7, расширенная лобэктомия – 27, расширенная билобэктомия – 7, расширенная пневмонэктомия - 11. Комбинированные операции проведены в 16 случаях (30,8%). Диагностическая торакотомия – 24 (31,6%).

В 13 (17,1%) случаях в послеоперационном периоде наблюдались осложнения, представлены следующим образом: ДВС – 1, внутриплевральное кровотечение – 5, послеоперационная пневмония - 2, частичная несостоятельность культи бронха – 2, вывих сердца - 1, транзиторное нарушение мозгового кровообращения - 2, острая сердечно-сосудистая недостаточность – 1. Послеоперационная летальность составила 5,2% (4).

USE OF BRACHYTHERAPY IN CERVIX CANCER

Saidova K. O., Mansurova G. B., Sabirdjanova Z. R.

National oncological centre of the Public Health Ministry of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Nowadays cervix cancer is one of most often tumours of female genitals. The basic method of treatment of local spread cervix cancer is combined radial therapy and chemotherapy. However local spread cervix cancer becomes frequently complicated with acute bleeding and pain. In consequence of these complications fast developing anemia sharply burdens patient's condition and carrying out of chemo- and radial therapy becomes impossible. One of the effective methods to control bleeding in cervix cancer patients is endovascular embolization of internal iliac and uterine arteries. But at contra-indications to this method and patient's refusal, intracavitary brachytherapy is becoming an alternative method to control bleeding.

Aim of the inquiry: to assess the direct results of intracavitary brachytherapy in cervix cancer, complicated with hemorrhage.

Materials and methods: 37 women with local spread cervix cancer complicated with chronic bleeding were examined. The

mean age was 40±4,2 years (range, 32 – 45 yr). In 15 patients (40,5%) was anemia of I stage, in 20 (54,1%) – II and in 2 (5,4%) patients was determined anemia of III stage. Patients were categorized depending on cervix cancer stages. In 8 (21,6%) patients was defined II stage of cervix cancer (T2bNoMo), in 27 patients (72,9%) – III stage (T3aNxMo) and in 2 (5,4%) – IV stage (T4NxMo). All patients received conservative haemostatic therapy with the purpose of stopping of bleeding from tumour, increasing of haematological indicators, prevention of infectious complications, knocking over of a painful syndrome, strengthening of protective forces of patients. Brachytherapy on the apparatus Gammamed-plus with the source of radiation iridium-192 was applied in inefficiency of haemostatic therapy. Radiation dose reached the target with use of cylinder applicators Varian.

Results: direct results of intracavitary brachytherapy in cervix cancer patients, complicated with bleeding were showed in the first days and expressed in hemostasis. After stop of bleeding and correction of homeostatic disorders combined radial therapy was carried out. The irradiation was carried out on the device "Teratron - 780E" with a source of radiation cobalt 60. Thus, carrying out of intracavitary brachytherapy has allowed to stop in the shortest time bleeding from tumour, improve the general condition and haematological indicators in cervix cancer patients.

ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДНО-КИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ У БОЛЬНЫХ, РАДИКАЛЬНО ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА

Альгожин Т.Б.

Павлодарский областной онкологический диспансер

Актуальность - гастрэктомия в большинстве наблюдений выполняется по поводу распространенного опухолевого процесса желудка и по данным различных авторов в 0,5–50% случаев приводит к рубцовым сужениям пищеводно-кишечного анастомоза, проблема профилактики и лечения которых остается актуальной.

Цель исследования – изучить влияние комплексного лечения рубцовых стенозов пищеводно-кишечных анастомозов, сформировавшихся после радикальных операций по поводу рака желудка в послеоперационном периоде на непосредственные и отдаленные результаты лечения на региональном уровне без применения высокотехнологических методов лечения.

Материал и методы. В ПООД за период 2000 – 2009 г.г. прослежено 24 пациента с рубцовыми стенозами пищеводно-кишечных анастомозов, сформировавшимися после радикальных операций по поводу рака желудка в послеоперационном периоде. Курс комплексного лечения включал эндоскопическое рассечение рубцовой стриктуры, сеансы бужирования с помощью бужей и эндоскопов различных диаметров и применение интенсивной консервативной рассасывающей терапии.

Результат после курса лечения считался «отличным» при расширении анастомоза более 13 мм, при этом дисфагии не отмечалось, пациенты питались любой пищей, практически ни в чем себе не отказывая. Таких пациентов оказалось 9 (37,5 %). Результат оценивали как «хороший» при диаметре анастомоза от 10 до 13 мм, при этом отмечалась эпизодически возникающая дисфагия, связанная с нарушением диеты. Данный эффект был достигнут у 7 пациентов (29,2 %). «Удовлетворительным» был признан результат при диаметре соустья до 10 мм, когда анастомоз по сравнению с первоначальным был расширен, однако больные отмечали эпизодическую дисфагию, связанную с приемом грубой пищи. Подобный результат был получен у 5 (20,8 %). Результат считали «неудовлетворительным» при любом диаметре анастомоза, когда не было какого-либо эффекта после эндоскопического

лечения. Неудовлетворительный результат был у 3 (12,5 %), у которых дисфагия была связана с продолженным ростом опухоли, выявленным при эндоскопическом исследовании, подтвержденном через 6 месяцев после операции биопсийным материалом. Противовоспалительный эффект комплексной терапии подтвержден морфологическими исследованиями гастриобоптатов. У больных после курса лечения в 70 % случаев отмечалась нормализация процессов регенерации и пролиферации в слизистой оболочке зоны анастомоза в течение 10 дней.

Результаты и выводы. Комплексное лечение с применением малоинвазивной хирургии позволяет предотвратить повторное стенозирование зоны пищевода анастомоза в 87,5 % случаев, избежать повторного оперативного вмешательства и повысить уровень качества жизни пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ТОРАКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Абдрахманова М.М.

Акмолинский областной онкологический диспансер

Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств на органах грудной клетки является одной из наиболее сложных анестезиологических проблем и имеет ряд своих особенностей. При выборе способа интубации дыхательных путей следует исходить из необходимости поддержания адекватной вентиляции при нарушении герметичности дыхательных путей оперируемого легкого, проведения независимой вентиляции каждого из легких, изоляции пораженного легкого от здорового для предотвращения попадания в последнее патологического содержимого. С этой целью используется метод раздельной интубации главных бронхов и одноклоночной интубации. Максимальная глубина анестезии необходима в процессе расширения межреберного промежутка. При негерметичной грудной клетке в отсутствие присасывающего отрицательного внутригрудного давления уменьшается венозный возврат. При операциях на легких инфузия жидкости строго ограничивается, восполняются только базальные потребности организма в жидкости и кровопотеря. С целью профилактики развития послеоперационной пневмонии уже интраоперационно, перед вводным наркозом начинается антибиотикотерапия. В конце операции культя бронха или оставшаяся легочная ткань проверяется на герметичность под водой и проводится обязательное расправление всей оставшейся легочной ткани. Нарушения газообмена и гемодинамики в следствии пневмоторакса, искусственной вентиляции легких, удаления части легочной ткани могут привести к грозным осложнениям. Правильная подготовка к операции, грамотное ведение анестезии с учетом всех особенностей и рациональный послеоперационный период позволяют снизить частоту осложнений, что и является целью данного исследования. За период 2008- первую половину 2010 гг. в Акмолинском областном онкологическом диспансере прооперированы 62 пациента торакального профиля. Мужчин- 46, женщин- 16. Возраст больных от 13 до 69 лет. У 56% из них имелись клинически значимые сопутствующие заболевания – ишемическая болезнь сердца у 15, постинфарктный кардиосклероз-1, артериальная гипертензия – 7, хронический бронхит 8, сахарный диабет- 1, варикозное расширение вен нижних конечностей-3, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки-2. Достаточная компенсация функций внешнего дыхания с нормальными и незначительными отклонениями была отмечена у 39 больных (63%), у 21 (34%) – нарушения легочной вентиляции были умеренными. У 2 пациентов (3%) отмечалось весьма значительное снижение жизненной емкости легких (60% и ниже). В 16 случаях операции закончились пульмонэктомией, 18- лобэктомией, 15- резекцией сегмента легкого, 7- удалением опухоли средостения, 6- пробной

торакотомией с биопсией. Продолжительность операции составила от 35 минут до 4 часов 40 минут, в среднем 2 часа 15 минут. Кровопотеря от 100 до 1300 мл, в среднем 450 мл. У 9 (14,5%) пациентов послеоперационный период осложнился развитием пневмонии, у 1 (1,6%) – инфаркта миокарда, еще 1 (1,6%) – нарушением ритма по типу фибрилляции предсердий. Наиболее грозным осложнением является внутриплевральное кровотечение. Оно наблюдалось в 2(3,2%) случаях. Из 62 прооперированных больных умерло 5 (8%), 4 после пульмонэктомии, 1-удаления опухоли средостения. Причина смерти в 2случаях-острая сердечно-сосудистая недостаточность, 2-пневмония единственного легкого, дыхательная недостаточность, интоксикация, 1-кровотечение. Дальнейшее улучшение результатов хирургического лечения больных с торакальной патологией возможно при более тщательной подготовке сердечно-сосудистой и дыхательной систем до операции, рациональном ведении больного в послеоперационном периоде, совершенствовании техники операции, анестезиологического и реанимационного обеспечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЛЬЮИСА.

Абдрахманова М.М.

Акмолинский областной онкологический диспансер

По Акмолинской области в структуре онкопатологии рак пищевода занимает 9 место. За период 2006- 2010гг. заболевание выявлено у 277пациентов. С 2006 года на базе нашего диспансера начато оперативное лечение больных с раком нижней и средней трети грудного отдела пищевода. Внедрена операция Льюиса. За это время прооперировано 16 пациентов, что составило 5,7% - 11 мужчин и 5женщин в возрасте от 41 года до 74 лет. Сопутствующая патология выявлена у 13 больных. Ишемической болезнью сердца страдали 11 человек, артериальной гипертензией – 2, хроническим пиелонефритом - 2. Пять пациентов являлись злостными курильщиками. Локализация была среднегрудной у 3, нижегрудной у 10 пациентов. В 3 случаях в опухолевый процесс был вовлечен кардиальный жом желудка. Два прооперированных больных со второй стадией заболевания, остальные с третьей стадией.

Одной из важных задач, стоящих перед анестезиологической и хирургической бригадами, является решение вопроса, связанного с функциональной операбельностью. Тщательное исследование функциональных резервов организма в сопоставлении с предполагаемой травматичностью операции позволяет уменьшить количество послеоперационных осложнений и летальность. Операция Льюиса относится к одной из самых травматичных хирургических вмешательств. Продолжительность операции составила в среднем 3 час 30 мин +- 35 мин. В среднем на 6-7 сутки после операции больным проводился рентгенологический контроль для оценки функционального состояния перемещенного желудка, легочной ткани. Примерно в эти же сроки начинали зондовое питание. Послеоперационные осложнения были зарегистрированы у 12 больных (75%). Пневмония- 4(25%), инфаркт миокарда-1(6,2%), острая сердечно-сосудистая недостаточность-3(18,7%), внутриплевральное кровотечение-1(6,2%), несостоятельность анастомоза-4(25%). Послеоперационная летальность составила 25 %. Наиболее грозным осложнением после операции Льюиса является не состоятельность швов внутригрудного пищевода-желудочного анастомоза. В 4 наблюдениях этого осложнения умерло 2 больных. Причиной смерти еще 2 пациентов стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Другая серьезная проблема послеоперационного периода - легочно-плевральные осложнения. Как правило, они являются следствием неблагоприятного фонового состояния трахеоброн-

хиального дерева, а также односторонней вентиляции или в отсутствие раздельной интубации бронхов - гиповентиляции и вынужденного «сдавливания» правого легкого при выполнении торакального этапа операции. И здесь важный момент – оценка состояния легкого перед ушиванием торакотомной раны. К этому моменту не должно оставаться ателектазов, повреждений легочной ткани. К профилактике развития легочных осложнений также относятся ранняя активизация больных, стимуляция самостоятельного откашливания мокроты с выполнением ингаляций, вибромассаж грудной клетки, коррекция гиперкоагуляции. В наших наблюдениях пневмония констатирована у 4 больных. Исход благоприятный. Прогностическим для развития легочных осложнений является и фактор кровопотери, как интраоперационной, так и послеоперационной. С целью определения адекватности хирургического гемостаза и профилактики послеоперационных кровотечений ревизию средостения и плевральной полости необходимо проводить в условиях умеренной гипертензии, так как осуществление ее в условиях гипотензии не гарантирует правильную оценку гемостаза. Мы наблюдали 1 послеоперационное внутриплевральное кровотечение. Больной был взят на реторакотомию, кровотечение остановлено.

Безусловно, операция Льюиса сложна и не прощает ошибок. Но именно хирургическое вмешательство остается максимально эффективным и составляет основу комбинированного и комплексного лечения. Далеко не все резервы данного вмешательства исчерпаны, что определяет целесообразность совершенствования технических, анестезиологических, реанимационных аспектов.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДНА ПОЛОСТИ РТА 3-Й СТАДИИ

Абдурахимов О.Н., Юсупов Б.Ю.

Республиканский научный центр онкологии МЗ РУз.

Цель: Оценить достоверность клинко-инструментальных исследований и пункционной биопсии при определении метастазов в регионарные лимфатические узлы.

Материалы и методы. В своей работе мы проанализировали достоверность до операционных методов исследований с результатами послеоперационных гистологических исследований шейных регионарных лимфатических узлов.

32 пациентам до операции проведена химиолучевая терапия с препаратами фторурацил, цисплатин и дистанционная гамматерапия СОД-40 грей (РОД по 3 Гр) на первичный очаг с захватом зоны регионарных лимфатических узлов шеи. Через три недели всем пациентам произведено хирургическое лечение с удалением опухоли и регионарных лимфатических узлов.

По данным гистологических исследований удаленных шейных лимфатических узлов установлено, что из 32 пациентов метастазы обнаружены у 29 (90,6%). У 12 больных установлено поражение 1го уровня лимфатических узлов. У 9 (41,3%) отмечалось поражение 2-3 уровня лимфатических узлов. У 8 (27,5%) отмечалось поражение 1,2,3,4,5 уровней лимфатических узлов. Функциональная лимфодиссекция с двух сторон выполнялась у 6 (20,6%) пациентов. У 4-х пациентов объем операции оценивался как радикальная лимфодиссекция. Из 29 пациентов у 7 (24,1%) метастатические узлы были неподвижные, с прорастанием узлов на внутреннюю яремную вену и на мышцы шеи. Осложнение в виде вторичного заживления раны на шеи отмечена в 3-х случаях.

Таким образом, при раке слизистой оболочки дна полости рта 3 стадии, по нашим данным отмечалось поражение шейных лимфатических узлов у 90% случаев, следовательно, выполнение одномоментной лимфодиссекции

улучшает результаты комплексного лечения.

ОЦЕНКА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО- ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Адылханов Т.А., Коровников А.Г., Чайжунусова Н.Ж.

Государственный медицинский университет г. Семей

Региональный онкологический диспансер г. Семей

*Научно-исследовательский институт радиационной
медицины и экологии г. Семей*

Актуальность: Важной проблемой современной онкологии является повышение качества жизни (КЖ) больных раком молочной железы (РМЖ) после радикальных операций. Для проведения эффективного восстановительного лечения необходимо определить реабилитационный потенциал (РП) пациентки на основе комплексной оценки КЖ. Ранее РП в онкологической практике не использовался, встречались единичные упоминания в научной литературе.

Цель работы: Оценка РП больных РМЖ после радикальных операций как основа для проведения лечебно-восстановительных мероприятий.

Материалы и методы: Проведены лечебно-восстановительные мероприятия с учётом РП у 60 больных РМЖ, перенесших радикальное оперативное лечение. Пациентки были разделены на три группы по 20 человек в зависимости от уровня РП: 1) с высоким РП; 2) со средним РП; 3) с низким РП.

Эффективность терапии оценивалась клинически и при помощи госпитальной шкалы тревоги и депрессии и опросника депрессии Бека.

В первой группе тревожно-депрессивные нарушения отсутствовали либо были выражены умеренно и легко поддавались краткосрочной психофармакотерапии (ПФТ) малыми дозами транквилизаторов (до 2-х недель) или антидепрессантов (от 4-х недель). Проводились психопрофилактические беседы или экспресс-психотерапия (1-5 сеансов).

Во второй группе отмечались выраженные тревожно-депрессивные реакции, для коррекции которых требовался более длительный приём антидепрессантов (флувоксамин) в средних дозах в сочетании с мультимодальной психотерапией (6-10 сеансов).

В третьей группе отмечались стойкие тревожно-депрессивные расстройства, требующие длительного приёма антидепрессантов в средних и высоких дозах в сочетании с прерывистыми курсами транквилизаторов и длительной поддерживающей мультимодальной психотерапией.

Результаты: Через 3 мес. выраженный эффект ПФТ отмечался у 95 % больных первой группы, 80 % пациенток второй группы и 60 % больных третьей группы.

Выводы: Таким образом, нами показано, что определение РП способствует индивидуализации и эффективности лечебно-восстановительных мероприятий, направленных на повышение КЖ у больных РМЖ после радикальных операций.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА БҮЙРЕК РАГЫН ЕМДЕУ ЖӘНЕ АНЫҚТАУ ЖАҒДАЙЛАРЫ.

Балтабеков Н.Т., Аманбеков Н.А.

*С.Ж.Аспендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қалалық
онкодиспансері.*

Алматы қалалық онкологиялық диспансерінде 2010 жылы бүйрек рагына шалдыққан 542 науқас тіркелген. Олардың ішінде 83 науқасқа диагноз алғаш рет қойылған.

2010 жылы анықталған науқастардың арасында 60,2±5,3%

ісіктік процесстің І-II даму сатысында, $30,1 \pm 5,2\%$ ІІІ даму сатысында, $9,6 \pm 5,1\%$ ІV даму сатысында тіркелді.

Алғашқы рет анықталған 83 науқастың 4-не өмірлік маңызды ағзалар тарапынан ауыр дәрежедегі ауруы болғандықтан ем жүргізілмеді, науқастардың 7-і ұсынылған емнен бас тартты. 83 науқастың 47-не жеке хирургиялық ем жасалынды, ол $56,2 \pm 5,1\%$ құрады, сәулелік ем қолданылмады және 25 науқасқа хирургиялық еммен қабаттасқан иммунды терапия (α -интерферон) жүргізілді ($30,1 \pm 5,1\%$).

2010 жылы 7 ай ішінде анықталған 83 науқастың 12-сі алғашқы 6-ай ішінде қайтыс болды. Олардың 8-де $66,7 \pm 5,1\%$ ісіктік процесстің ІV даму сатысында, 3 науқас (25%) ІІІ даму сатысында және ісіктік процесстің І даму сатысындағы 1 науқас хирургиялық емнің асқынуынан қайтыс болды.

Қорытынды: сонымен Алматы қаласында бүйрек рагының ерте даму сатысындағы шалдыққан науқастар $60,2 \pm 5,3\%$ жағдайда анықталады. Асқынған даму сатысындағылар $9,6 \pm 5,1\%$ құрайды.

Бүйрек рагына шалдыққан науқастарды еммен қамту $86,1 \pm 5,1\%$ құраса, ал 1 жылдық өлім көрсеткіші $14,5 \pm 3,5\%$ құрады.

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.

Онгарбаев Б. Т.

КазНИИОиР, отделение онкоурологии

Рак мочевого пузыря является достаточно частой патологией: среди злокачественных заболеваний органов мочеполовой системы после опухолей почек находится на втором месте. Его встречаемость составляет 3,8 на 100 тыс населения нашей страны. На сегодняшний день, стандартом лечения инвазивного рака мочевого пузыря, признанного во всем мире, является радикальная цистэктомия.

Целью нашего исследования явилось определение тактики оперативного лечения при выявлении инвазивной формы рака мочевого пузыря.

Материалы и методы. С 2006 по 2009 годы и первое полугодие 2010 г в отделении онкоурологии КазНИИОиР находилось на лечении 560 больных раком мочевого пузыря, из них 155 больных прооперированы по поводу инвазивного рака мочевого пузыря: 30 больным проведена резекция мочевого пузыря, 135 больным – радикальная цистэктомия.

В зависимости от местного распространения опухоли больные распределены следующим образом. У пациентов с резекцией мочевого пузыря – у 24 пациентов заболевание было ограничено стенкой мочевого пузыря (Т2а-б), у 4 имела микроинвазия в перивезикальную клетчатку, у 1 больного опухоль распространялась на перивезикальную клетчатку. Для пациентов с радикальной цистэктомией у 61 больных отмечено прорастание мышечной оболочки, у 26 – прорастание в перивезикальную клетчатку и у 10 – опухоль распространялась на предстательную железу.

Во всех случаях гистологически был верифицирован переходо-клеточный рак.

Обращает на себя внимание уменьшение количества больных, которым проведена резекция мочевого пузыря (14 больных в 2006 году и 4 больных в 2009-2010 гг), и наоборот возрастание числа больных, которым произведена радикальная цистэктомия (в 2005 – 3, в 2006 году – 11, в 2009-2010- 71).

Больным после радикальной цистэктомии, у которых опухоль ограничена мышечной стенкой (Т2) и высокодифференцированными опухолями -G1 в послеоперационном периоде лечение не назначалось, всем остальным пациентам (Т≥2, G2-4, N+) назначались курсы ПХТ.

Результаты. Больные, которым мы провели резекцию

мочевого пузыря, это люди пожилые, с массой сопутствующей патологией со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, анемией тяжелой степени, которым проведение оперативного лечения в объеме радикальной цистэктомии было сопряжено с высоким риском. У всех этих пациентов опухоль располагалась на подвижных стенках, не превышала 5 см в диаметре и была ограничена мышечной стенкой мочевого пузыря. Также этим пациентам проводилась регионарная лимфодиссекция с одноименной стороны с диагностической целью. В 8 случаях опухоль закрывала устье мочеточника с нарушением эвакуаторной функции почки и была произведена резекция с уретероцистостомией. Все пациенты в послеоперационном периоде находились под наблюдением. На фоне проведенного лечения у 5 больных выявлен рецидив заболевания и 2 больных умерли от прогрессирования процесса.

В послеоперационном периоде у пациентов после радикальной цистэктомии по различным причинам умерло 12 человек, из них в раннем послеоперационном периоде 3 больных. Анализ летальности в двух случаях выявил разлитой перитонит вследствие несостоятельности тонко-тонкокишечного анастомоза, в одном – развитие тромбоза боули легочной артерии.

Выводы. Таким образом, при инвазивном раке мочевого пузыря на сегодняшний день стандартом лечения является проведение радикальной цистэктомии при условии достаточной дооперационной подготовки больных и послеоперационного ведения больных.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА.

Баймаханов Б.Б., Тулеутайұлы К., Оспанов Ш.Е.

Кызылординский областной онкологический центр.

Ежегодно по Кызылординской области выявляется от 100 до 110 больных с первичным раком желудка. К сожалению, в связи с отсутствием скрининга рака желудка у 70-88% первично выявленных больных заболевание диагностируется в III-IV стадии, что предопределяет неудовлетворительные результаты лечения. Частота обнаружения ранних форм рака желудка не превышает 10-15%.

Целью исследования явилось изучение возможности оперативного лечения рака желудка в течение 6 лет (2004-2010 гг) в Кызылординском областном онкологическом центре.

Материалы и методы: был проведен анализ оперативного лечения 64 больным первичным раком желудка.

При анализе оперативного лечения 64 больным первичным раком желудка расширенная гастропленозектомия проведена 12 пациентам, расширенная гастрозектомия с лимфодиссекцией ворот селезенки – 4, расширенная субтотальная резекция желудка – 12, комбинированная гастропленозектомия – 5:

- расширенная гастропленозектомия с резекцией поперечно-ободочной кишки
- расширенная гастропленозектомия с корпорокаудальной резекцией поджелудочной железы -3
- расширенная гастропленозектомия с корпорокаудальной резекцией поджелудочной железы, резекцией поперечно-ободочной кишки

Комбинированная субтотальная резекция желудка – 5:

- расширенная субтотальная резекция желудка с корпорокаудальной резекцией поджелудочной железы.
- расширенная субтотальная резекция желудка с резекцией поперечно-ободочной кишки – 4.

Экстирпация культи желудка с расширенной лимфодиссекцией – 2.

Обходной гастроэнтероанастомоз – 13.

Эксплоративная лапаротомия – 11.

Осложнения наблюдались в 11 случаях:

Дыхательная недостаточность – 6 (9,3%).

Сердечно-сосудистая недостаточность – 3 (4,6%).

Несостоятельность швов анастомоза – 2 (3,1%).

Летальность наблюдалась в двух случаях (3,1%) при несостоятельности швов анастомоза.

Несмотря на некоторые успехи комбинированных методов лечения, именно хирургический метод является «золотым» стандартом при радикальном лечении рака желудка, позволяющим надеяться на полное выздоровление.

СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА (ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)

*Баспаева М.Б., Дюсембеков С.Т., Жолмухамедова Д.А.
Медицинский Центр ЗКГМУ им. М. Оспанова, Актюбе*

Большинство операций при раке желудка выполняются в третьей стадии онкологического процесса и должны рассматриваться как условно радикальные. Показатель 5 летней выживаемости по данным подавляющего большинства исследователей не превышает 25-35%. Больные погибают от рецидивов и метастазов опухоли в течении 2-3 лет после операции. Необходим поиск дополнительных и одновременно совершенствование имеющихся методов лечения, в частности, химиотерапии.

Приводим пример пациентки Ф. 1950г.р. раком желудка 111 стадии T3N2Mo, состоящей на учете с 02.2007г (3 года 6 месяцев). После выполнения 6.02.2007г операции, гастрэктомии с лимфодиссекцией Д1 (гистология № 2837-51 от 15.02 – низкодифференцированная аденокарцинома с прорастанием мышечного слоя, стенки желудка и мтс в лимфоузлы малой кривизны; № 2837-54 – в лимфоузле а. sinuistica – мтс аденокарциномы, прорастает капсулу узла), учитывая циторедуктивность, гистологию и стадию заболевания было проведено 3 курса химиотерапии, которую закончила в июне 2007г. В марте 2009г выявлено прогрессирование – мтс в лимфоузлы шеи (цитология № 1736-7 от 30.03 – железистый рак) и парааортальные лимфоузлы (КТ). Проведено 3 курса химиотерапии (онкоплатин, 5фторурацил) с регрессией до 90%. В 10.09г вновь увеличение шейных лимфоузлов (цитология № 6298-9 от 20.10 – железистый рак). Проведено 4 курса химиотерапии (1 – онкоплатин, КАМПТО, кселода; 2 и 3 курсы – онкоплатин, кселода), 4 – оксалиплатин, кселода). Отмечена положительная динамика в виде регрессии лимфоузлов шеи до 80-90%. Находится на диспансерном наблюдении, состояние больной удовлетворительное.

Планируемая тактика – проведение химиотерапии при последующих рецидивах заболевания с использованием препаратов последующих поколений, их комбинаций; достижений при этом более длительных регрессий, что соотносится с современными тенденциями о переводе онкологических заболеваний в разряд хронических болезней.

ЦИРКУЛЯРНЫЕ РЕЗЕКЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ЛЕГКОГО И ТРАХЕИ

Бейсебаев А. А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

С применением технически наиболее сложного вида органосохраняющей операции – циркулярной резекции и пластики бронхов и бифуркации трахеи, а также грудного отдела трахеи прооперированы 68 больных раком легкого в возрасте 21-73 лет (мужчин 59, женщин 9). Из них у 41 больного операция была в объеме долевых резекций с циркулярной резекцией главного и промежуточного или долевого бронхов, у 12 – правосторонняя пневмонэктомия с циркулярной резекцией нижней трети трахеи, левого главного бронха, у 15 – резекция грудного отдела трахеи.

Осложнения после операции диагностированы у 29,2% (2 случая хилоторакс, несостоятельность анастомоза у 13, внутриплевральное кровотечение – 3, острая дыхательно-

сердечная недостаточность – 5). Летальность 11,8%. Huang Jian, Wang Mao-sheng (2004) осложнения после подобных операций наблюдали в 37,5% случаев, Nawa Haroshi et al. (1999) – 26,8% случаев.

Важным условием внедрения этих операций в клинику – необходимы адекватное обеспечение анестезиологического пособия и высокая техника оперирования.

РАСШИРЕННЫЕ И РАСШИРЕННО-КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА.

*Бекмухамбетов Е.Ж., Дюсембеков С.Т.,
Бегунов В.В., Жолмухамедова Д.А.*

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР – болезней, г.Актюбе.

Актуальность. Заболеваемость колоректальным раком во всех возрастных группах неуклонно увеличивается, особенно в экономически развитых государствах. В Актюбинской области заболеваемость колоректальным раком не возрастает, но при этом количество запущенных случаев и смертность остается высокой. В связи, с чем возникает необходимость выполнения расширенных и расширенно-комбинированных операций, при этом приходится резецировать несколько сегментов как тонкой, так и ободочной кишки, соседних органов и структур, после которых увеличивается число послеоперационных осложнений, которое по литературным данным составляет 11,3-65,6 %, операции часто заканчиваются наложением колостомы, что приводит к ухудшению качества жизни больных.

Материалы исследования. В медицинском центре ЗКГМУ им.Марата Оспанова с 2001 по 2007 гг. 29 пациентам выполнены расширенные и расширенно-комбинированные операции при колоректальном раке с первичным восстановлением кишечной трубки. Показаниями к выполнению подобных операций явились: инвазия опухоли и ее метастазов в смежные органы и системы; первично-множественный рак ободочной кишки, с локализацией в других органах ЖКТ и органов брюшной полости; метастазы колоректального рака в печень.

Результаты. После проведенных операции отмечались следующие виды осложнения: нагноение послеоперационной раны – 3 (10,3 %), послеоперационный тотальный панкреонекроз – 1 (3,4 %), нижнедолевая пневмония слева – 1 (3,4 %), длительное желчеотделение – 1 (3,4 %). В послеоперационном периоде умер 1 больной (3,4 %), причиной которого явился панкреонекроз.

Выводы. Таким образом, тщательная предоперационная подготовка, правильный, дифференцированный подход к проведению подобного рода объемам операции позволяет снизить число стомированных больных и улучшить качество их жизни.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ ПИЩЕВОДНОГО СОУСТЬЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА.

*Букенов А.М., Рахманова Б. А., Мадыкенов Р. О.
Кафедра онкологии, лучевой терапии с курсами общей хирургии, травматологии и ортопедии ФНПР КГМУ.
Карагандинский областной онкодиспансер.*

Причины возникновения несостоятельности швов пищевода различны. Одни [Бондарь Г.В., Байдалин Ю.Д., 1971] хирурги считают основной причиной чрезмерную мобилизацию пищевода, другие [Ганул Л.В., Шевчук А.С., 1979] – снижение репаративной способности ткани пищевода, в связи с гнилостными процессами, развивающимися в пищеводе выше места обтурации. Не менее важным

считают уровень резекции пищевода [Кулаевская В.Г., 1980, Странадо Е.Ф., 1980], резекция пищевода на расстоянии близком к опухоли может привести к несостоятельности швов пищеводного соустья.

По мнению Русанова А. А. [1973] главной причиной возникновения несостоятельности пищеводного анастомоза являются технические погрешности, допущенные при формировании анастомоза, т.е. недостаточная квалификация хирурга. Поэтому изучение частоты несостоятельности швов пищеводного соустья в зависимости от способа наложения анастомоза является одной из актуальных задач клинической онкологии.

Цель исследования – уменьшить частоту несостоятельности швов пищеводного соустья при хирургическом лечении рака желудка.

Материалы и методы.

Анализируются истории болезни 287 больных, находившихся на обследовании и лечении с диагнозом: Рак проксимального отдела и тела желудка за период с 1990-2004г.г. Послеоперационная летальность на 287 операций составила $17,1 \pm 2,2\%$ (умерло 49).

Независимо от оперативного доступа и объема операций ведущей причиной летальности явилась несостоятельность пищеводного соустья $44,8 \pm 5,6\%$ (35 из 287 операций) среди всех осложнений. Летальность при чресплевральном и чрезбрюшинном доступе составила соответственно $23,5 \pm 3,6\%$ (32 из 136 операций) и $11,3 \pm 2,6\%$ (17 на 151 операцию), статистически разница существенна ($p < 0,05$).

Обсуждение результатов.

Послеоперационная летальность от недостаточности швов пищеводного соустья значительно ниже при использовании анастомоза по способу Сапожкова - Юдина – $13,3 \pm 6,0\%$ (умерло 6), по сравнению с летальностью при использовании способа Гиляровича - Грэхема – $27,3 \pm 7,7\%$ (умерло 9), разница статистически существенна ($p < 0,05$). Значительного снижения летальности не было отмечено при использовании инвагинационного анастомоза с расширяющим швом Блохина, которая составила $24,4 \pm 6,4\%$, разница статистически не достоверна ($p > 0,05$) по сравнению с выше названными способами (из-за небольшого количества наблюдений). Нами разработан способ формирования погружного пищеводного соустья (авт. свидетельство № 45123, авторы Нам Э. Н., Букенов А. М.). Послеоперационная летальность от несостоятельности пищеводного соустья сведена до минимума за счет внедрения усовершенствованного погружного анастомоза, при котором не наблюдалось данного осложнения. При муфтообразном анастомозе по Г. В. Бондарю отмечено в $5,6 \pm 2,4\%$ (5 осложнений на 90 операций) случаев несостоятельности пищеводного соустья, а среди всех осложнений она составила $33,3 \pm 12,6\%$ (5 случаев на 15 осложнений). Из пяти больных с несостоятельностью пищеводного соустья при муфтообразном анастомозе погибли $3,3 \pm 1,9\%$ (умерло 3) пациента.

Сравнительный анализ частоты несостоятельности пищевода и ее летальности убеждает нас в правомерности выбора погружного анастомоза при хирургическом лечении рака желудка.

ВЫБОР ОБЪЕМА ЛИМФОДИСSEKЦИИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА

Джураев М.Д., Эшонов А.К.

Онкологический научный центр Узбекистана

Цель исследования: Улучшить результаты хирургического лечения рака желудка путем оптимизации объема лимфодиссекции.

Материалы и методы: Исследования проводились у 82 больных раком желудка в стадии Т3-4N3M0. В зависимости от объема лимфодиссекции больные распределены на 2

группы:

1. Стандартная радикальная гастрэктомия с лимфодиссекцией в объеме Д2, $n=50$ больных.
2. Расширенно-радикальная гастрэктомия в объеме Д3, $n=32$ больных.

Поражение № 3 группы лимфоузлов во всех случаях подтверждено гистологически. В данную группу исследования включены больные только с гистологически верифицированным поражением № 3 группы лимфоузлов. В1 группе больных после СРГ с лимфодиссекцией в объеме Д2, с учетом, что имеется поражение № 3 группы лимфоузлов, проводилось 2 курса эндоартериальной химиотерапии препаратом Фторурацил ОД 5 гр, Цисплатин 100 мг в течение 120 часов непрерывно на фоне системного введения 150 мг Лейковорина. Во 2 группе после РРГ предусматривающей лимфодиссекцию в объеме Д3 при той же схеме химиотерапии, проводилось 2 курса системно. Так как на наш взгляд именно установление эндоваскулярного катетера в просвет аорты на уровне диафрагмы и капельное введение препарата равномерно обеспечивает распределение химиопрепаратов по висцеральным ветвям брюшной аорты.

Результаты: Послеоперационные осложнения в 1 группе составили 18%, умерли 2 больных от тромбоэмболии легочной артерии и другой от острого инфаркта миокарда. Послеоперационная летальность составила 4%. Во 2 группе общие осложнения составили 25%. Среди них превалировал послеоперационный панкреатит. Умер 1 больной от несостоятельности эзофагоэнтоанастомоза. Послеоперационная летальность составила 3,1% ($P1-2 > 0,05$). Осложнения, связанные с введением химиопрепаратов и от методов лечения в обеих группах не наблюдались. Одногодичная выживаемость составила 88% в 1 группе и 84,9% во 2 группе. Трехлетняя выживаемость соответственно 64% и 62,5%. Пятилетняя 28% и 27,2% соответственно. Медиана выживаемости в обеих группах оказалась практически одинаковой $36,2 \pm 0,4$ и $35,4 \pm 0,3$ ($P > 0,05$).

Вывод: При поражении № 3 группы лимфоузлов применение радикально расширенной гастрэктомии с лимфодиссекцией в объеме Д2 с последующим проведением 2 курса эндоартериальной химиотерапии является альтернативным методом, так как отдаленные результаты метода достоверно не отличаются от результатов РРГ.

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТГАСТРЕКТОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Джураев М.Д., Худояров С.С., Эгамбердиев Д.М.

Онкологический научный центр Узбекистана, г.Ташкент

Цель исследования: Предотвратить возможные функциональные осложнения, путем создания желудка заменяющего резервуара.

Материалы и методы: В отделении абдоминальной хирургии в период 2004-2007 г.г. 25 пациентам раком желудка в стадии Т3N1-2M0 произведена расширенная гастрэктомия в объеме Д2 с созданием желудка заменяющего резервуара. Для сравнительного исследования в контрольной группе 30 пациентам произведена расширенная гастрэктомия без формирования резервуара. Больные были в возрасте от 13 до 60 лет. Гистологически у 44 (80,0%) пациентов выявлена аденокарцинома и 11 (20,0%) пациентов другие разновидности. Резервуар формировался из петель тонкого кишечника отступая 10 см от Трейцевой связки и включал в себя последовательное выполнение 4 анастомозов: эзофагорезервуар анастомоз, дуоденоэнто анастомоз конец в конец, энтеро-энтеро анастомоз бок в бок длиной до 18 см и энтеро-энтеро анастомоз конец в бок. Сравнительные исследования проводили в течение 6 месяцев по следующим критериям: 1)

Рефлюкс эзофагит; 2) Демпинг синдром; 3) Дискомфортное состояние после еды.

Результаты: В основной группе из 25 пациентов слабо выраженный рефлюкс эзофагит наблюдался у 2 (8,0%) пациентов спустя 1,5 месяца после операции, который быстро ликвидировали после консервативной терапии. В контрольной группе этот вид осложнения развился у 18 (60,0%) пациентов, из них слабо выраженный у 4 (13,3%) пациентов, умеренный у 5 (16,6%) и у 9 (30,0%) пациентов сильно выраженный рефлюкс эзофагит. Частота встречаемости демпинг синдрома в основной группе составила 0%, а в контрольной группе у 30,0% пациентов. Дискомфортное состояние после еды в основной группе не наблюдалось ни у кого, в то время в контрольной группе пациентов составила 49,9% пациентов.

Вывод: Формирование резервуара после расширенной гастрэктомии является оригинальным хирургическим способом, предотвращающим возможные функциональные осложнения.

РОЛЬ *HELICOBACTERI PYLORI* В ВОЗНИКНОВЕНИИ РАКА ЖЕЛУДКА У ЛИЦ УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Джураев Ф.М.

Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент

Актуальность проблемы: *Helicobacteri pylori* в 1994 г. официально признан канцерогенным агентом номер один. Частота инфицирования в развитых странах не превышает 15%, в то время в менее развитых странах до 100%. В тех популяциях, где снизилась зараженность *Helicobacteri pylori*, так же снизился показатель заболеваемости раком желудка.

Цель: Изучение роли *Helicobacteri pylori* в возникновении рака желудка у коренных жителей республики.

Материалы и методы: С этой целью проведено эндоскопическое исследование желудка у 540 больных при неонкологической патологии и у 360 больных раком желудка, у лиц узбекской популяции, с биопсией из 6 точек пилорического канала. В основной группе диагноз рак желудка установлен на основании комплексных данных. По локализации опухоль тела и антрального отдела желудка у 101 (28,1%) и опухоль антрального отдела у 259 (71,9%) больных. Высокодифференцированная аденокарцинома – 136 (37,7%), умереннодифференцированная аденокарцинома – 98 (27,2%), низкодифференцированная аденокарцинома – 126 (35,0%). Исследование *Helicobacteri pylori* проводилось морфологическим и бактериологическим методом.

Результаты: При эндоскопическом исследовании 540 больных выявлено наличие *Helicobacteri pylori* у 379 больных, инфицированность составила 70,2%. Из пациентов у которых выявлено присутствие бактерий обнаружен выраженный атрофический гастрит у 115 (30,3%), гиператрофический гастрит у 102 (26,9%), язвенная болезнь луковицы 12-перстной кишки у 22 (5,8%), выраженный гастродуоденит у 112 (29,5%) и без изменений у 19 (5,1%). Исследование показало, что из 360 больных, которым производили оперативное вмешательство у 270 больных выявлено наличие *Helicobacteri pylori*, у 90 (25,0%) больных *Helicobacteri pylori* не выявлено. Инфицирование составило 75,0%. Хотя во многих исследованиях *Helicobacteri pylori* является канцерогенным агентом номер один, но в наших наблюдениях несмотря на то, что у лиц узбекской популяции составляет 75,0%, встречаемость рака антрального отдела от общего числа составляет не более 12,1%.

Вывод: Исходя из вышеизложенного, вопрос является ли *Helicobacteri pylori* канцерогеном номер один для лиц узбекской популяции вызывает большое сомнение. Мы думаем, что данный вопрос с учетом обычаев, быта и менталитета требует более углубленного изучения.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Сейсембаев М.А., Баймаханов Б.Б., Рамазанов М.Е., Наржанов Б.А., Сахипов М.М., Токсанбаев Д.С., Ибекенов О.Т., Исламбетов А.С.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова

Актуальность: Опухоли проксимальных желчных протоков (ПЖП) остается актуальной проблемой клинической онкологии и составляет 10,5-26,5% от всех злокачественных поражений желчных протоков. Эффективность дооперационной диагностики опухолей печени колеблется от 3 до 97%. Без хирургического лечения большинство больных умирают в течение 4-6 месяцев после установления диагноза.

Цель: Улучшить диагностику и результаты хирургического лечения больных с опухолями ПЖП.

Материал и методы: Анализ подвергнуты результаты хирургического лечения 39 больных с опухолями ПЖП в возрасте от 21 до 76 лет. Преобладали пациенты старше 45 лет (74,3%), чаще мужчины (69,2%). Диагноз опухолевого поражения ПЖП устанавливали на основании комплексного клинического, лабораторного и инструментального исследований.

Клиническим проявлением заболевания явилась желтуха (100%), кожный зуд (84,6%), холангит (43,5%), боли в подреберье (30,7%), потеря в весе (61,5%). По классификации Bismuth-Corlette; тип I наблюдался у 6 (15,4%), тип II - у 7 (17,9%), тип IIIa – у 5 (12,8%), тип IIIb у 11 (28,2%) и тип IV - у 10 (25,7%) больных. С диагностической целью и последующей декомпрессией билиарного тракта перед возможной радикальной операцией в 19 (59,4%) случаях произвели ЧЧХГ и ЧЧХС.

Результаты: Радикальные оперативные вмешательства с лимфаденэктомией выполнены 17 (43,6%). В 13 случаях была произведена резекция гепатикохоледоха, в 4 случаях резекция гепатикохоледоха сочеталась с резекцией печени: 3 правостороннюю, 1 левостороннюю гемигепатэктомию с резекцией воротной вены и I сегмента печени. В 6 наблюдениях в анастомоз были включены от 3 до 5 сегментарных протоков.

Паллиативные операции выполнены 22 (56,4%); реканализация и наружное дренирование-4, резекция опухоли с билиодигестивным анастомозом-12, при неоперабельных опухолях выполнена холангиостомия-6 больным. При этом летальность отмечено в 3-х случаях.

Выводы: Современные методы исследования как, УЗИ, МРХПГ и КТ, а также прямое контрастирование желчных протоков: ЧЧХГ и ЭРХПГ, и высокое качество обследования больных позволяют выработать рациональную лечебную тактику. Выполнение двухэтапных операции с предварительной декомпрессией желчных протоков, снизит риск операции и количество возможных осложнений.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПАДАЮЩЕГОСЯ И ИНФИЛЬТРАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мадалиходжаев Р.С., Сыздыков К.З., Сарсенбаев А.У. ООД, МКТУ, г.Шымкент

Актуальность. Особенности развития и течения отечно-инфильтративного и распадающегося рака молочной железы (РМЖ) нередко делают хирургическое лечение весьма проблематичным. Цель работы. Повысить качество хирургического лечения распадающегося и отечно-инфильтративного РМЖ с использованием местных тканей. Материал и методы. При распадающемся РМЖ с одной стороны происходит нарастание раковой (эндогенной интоксикации), а с другой-

кровотечение из опухоли. И поэтому обычно производится гигиеническая мастэктомия без санации лимфатического коллектора регионарных областей. Инфильтративная форма РМЖ подразделяется на: первичную и вторичную. 1- характеризуется инфильтрацией молочной железы (раковые эмболы), но без наличия первичной, четко определяемой опухоли. При этом, кожа железы отечна, уплотнена и имеет вид «лимонной корки». В ряде случаев клиническая картина может напоминать мастит или рожистое воспаление. Во втором случае, отек железы чаще связан с нарушением транскапиллярной диффузии жидкости из-за фактора повышенной чувствительности тканей окружающих первичную опухоль непосредственно к самой опухоли и продуктам ее жизнедеятельности. А при имбиции капиллярной сети и лимфатических узлов раковыми клетками наступает блокировка лимфатической сети, что в свою очередь также усугубляет отечно-инфильтративный процесс и не дает возможности четко определить границу здоровой и пораженной зоны, а следовательно линия разреза заведомо окажется нерадикальной. Лечение в таких случаях -исключительно консервативное. Однако, в настоящее время, возможности комбинированной терапии с использованием высокоэффективных химиопрепаратов могут оказаться столь значимыми, что зона явного злокачественного процесса четко отграничивается, и как следствие, разрез можно производить радикально т.е. в пределах здоровой ткани. Исходя из этого, нами была разработана модификация радикальных операций, которые отличаются тем, что мы проводим расширенную радикальную мастэктомию с сохранением и большой и малой грудных мышц. Окаймляющий молочную железу разрез обязательно проводится электроножом отступая не менее 3 – 5 см от реально видимой или предполагаемой демаркационной линии. Производится сепаровка кожных лоскутов с удалением подключично-подмышечной и подлопаточной клетчатки. После операции образуется очень большой дефект кожи, который закрыть полностью остается проблематичным при каждой подобной операции. В нашем случае, для закрытия дефекта мы продолжаем увеличивать сепаровку кожных лоскутов и прошиваем их наводящими «толстыми» шелковыми лигатурами и определяем величину оставшегося кожного дефекта. Для покрытия оставшегося тканевого дефекта мы формируем трапецевидно образный кожно-подкожный лоскут из латеральной части грудной клетки, который формируется путем проведения продольных разрезов из углов раны в латеральном или латерально-верхнем направлении. После этого, подтягиваем образовавшийся трапецевидный лоскут к верхнему краю раны и накладываем обычные лигатуры с одновременным удалением наводящих лигатур. Результаты. По нашей методике пролечено 28 больных раком молочной железы. Из них: 9 с отечно-инфильтративной формой и 19 с распадающимся раком молочной железы. Заживление послеоперационной раны было в среднем за 15, 8 дней. Из осложнений- поверхностный ограниченный некроз медиального конца кожного лоскута был отмечен в 14,3%. Других осложнений не наблюдалось. Выводы. Предлагаемый нами модифицированный метод радикальной по объему операции может быть методом выбора при лечении инфильтративных и распадающихся формах рака молочной железы.

МЯГКОТКАННЫЙ ЛОСКУТ НА ПИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОТЕЧНО- ИНФИЛЬТРАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Сыздыков К.З., Мадалиходжаев Р.С., Джумагалиев Д.Ж.
Областной онкологический диспансер, МКТУ, г. Шымкент*

Актуальность. В мире и в Республике Казахстан заболеваемость Раком Молочной Железы (РМЖ) продолжает увеличиваться и составила 19,5. В структуре заболеваемости женского населения Казахстана РМЖ занимает доминирующее место. При этом, в Южно-Казахстанской Области (ЮКО)

в 2004 году РМЖ занимал второе, а за первое полугодие 2005 года, в 2009 году и в первом квартале 2010 года продолжает занимать первое место.

Наряду с этим, часть больных поступает в клинику с самой тяжелой формой РМЖ, это инфильтративной формой болезни когда хирургическое лечение всегда сопряжено с большими трудностями, а зачастую просто не показано.

Цель работы. Усовершенствовать оперативные подходы для улучшения качества жизни больных при инфильтративном РМЖ путем выкраивания кожного лоскута и ротация его на питающей ножке.

Материалы и методы. При инфильтративной форме, как правило, первичная опухоль не имеет четкого определения. При этом, кожа молочной железы резко отечна, уплотнена и чаще представлена в виде «лимонной корки». В других случаях имеет место мастит подобная или рожисто подобная форма. Наличие выраженного отека молочной железы не дает возможности четко определить границу здоровой и пораженной зоны, а это означает, что линия разреза заведомо окажется нерадикальной. Лечение в таких случаях -исключительно консервативное. Однако, в настоящее время, с появлением высокоэффективных лекарственных препаратов комбинированное лечение оказывается столь существенным, что при лечении отечно-инфильтративного РМЖ нередко на границе злокачественного процесса и здоровой ткани четко обозначается демаркационная линия. А это позволяет правильно выбрать линию радикального разреза. Разработанная нами модифицированная операция выполнена 26 больным с T4N0M0 стадией после 4-6 курсов неоадьювантной полихимиотерапии на фоне антиэстрогенного гормонотерапии и отличается от традиционных операций тем, что окаймляющий молочную железу разрез в обязательном порядке проводится электроножом отступая на 3 – 5 см от реально видимой *ad oculum* или предполагаемой демаркационной линии. После этого, производится сепаровка кожных лоскутов с удалением подключично-подмышечной и подлопаточной клетчатки. В итоге, образуется очень большой кожный дефект для покрытия которого из кожи дорзальной части грудной клетки выкраивается лоскут на питательной ножке. После вентральной ротации лоскута производится ушивание операционной раны.

Результаты. Исследования в течение 2 лет показали, что сразу же после операции и на протяжении всего времени наблюдения психо-эмоциональный статус всегда находился на достаточно высоком уровне. При этом, умерло 11,5% больных или 3 человека. Рецидивы возникли у 13 больных или в 50,0%. Время заживления раны составил 15 – 18 дней, при этом поверхностный ограниченный некроз краев кожи отмечен в 38,5% или у 10 больных. Других осложнений не было.

Выводы. Предлагаемый нами метод расширенной операции с использованием вентральной ротации кожно-мышечного лоскута может быть методом выбора при лечении отечно-инфильтративных форм РМЖ, что несомненно улучшит качество жизни.

БРОНХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

*Енин Е.А., Адильгиреева Л.Х., Пюрова Л.П.,
Елеубаева Ж.Б., Решетина Н.В.*

*Лаборатория патоморфологии с цитологией и
электронной микроскопией ННЦХ им. А.Н.Сызганова.*

Научно-практические публикации по вопросам онкологии в торакальной хирургии свидетельствуют о неуклонном росте показателей заболеваемости раком легкого во всех странах мира.

Целью: исследования было установление клинко-анатомической формы процесса, морфологическая вери-

фикация диагноза с установлением структуры опухоли и степени анаплазии.

Материалом: для исследования послужили 2799 (28%) больных, у которых эндоскопически был установлен или подтвержден диагноз новообразования легких и у 62 (0,6%) больных, оперированных по поводу опухолевого процесса, не верифицированного эндоскопически. Взятый материал фиксировали в 10% забуференном растворе формалина. Проводка проводилась рутинным методом на аппарате Leica TP 1020 (Германия). В проводке кусочки заливались в парафин. Готовые парафиновые блоки нарезались на микротоме Leica SM 2000R (Германия) одноразовыми ножами толщиной 4-5 микрон. Готовые стеклопрепараты окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, проводилась Шифф-реакция. Полутонкие срезы окрашивали метиленовым синим, азуром-2 и основным фуксином (С. Humphrey, F. Pittman, 1974). Препараты просматривались на световом микроскопе «Leica» DMLS 4000B с цифровой камерой Leica DFC 320 (Германия).

Результаты: центральная локализация опухоли была у 1715 (61,2%) больных, периферическая у 853 (30,5%), диффузный милиарный канцероматоз у 231 (8,3%). Соотношение центрального и периферического рака легкого у мужчин и женщин было 7:1. По данным гистологического и цитологического исследования прямой биопсии бронхов выявлены: аденокарцинома (3%), плоскоклеточный рак (22%), мелкоклеточный рак (11%), низкодифференцированный рак (4%), недифференцированный рак (5%), раковый лимфангоит (18%), различные элементы воспалительных деструктивных изменений (27%), безрезультативный материал (некротическая ткань, обрывки ткани, материал растворился) составил 10%. Наиболее трудной задачей в диагностическом плане представляли периферические округлые новообразования в легком. Бронхофиброскопия проведена 182 больным с подобной рентгенологической картиной. При этом предварительный диагноз рака легкого был установлен у 36 больных, из них у 2 больных обнаружена центральная локализация процесса (видимая в бронхах). У 24 больных с помощью гистологического исследования биоптата из периферической опухоли диагноз рака подтвержден, у 2 больных на операции обнаружено нагноительное заболевание, у 4 выявлен рак плевры, у 4 опухоль средостения.

Трансбронхиальная биопсия легкого у этой категории больных установила рак легкого в 123 случаях: плоскоклеточный рак – 11, недифференцированный рак – 13, раковый лимфангоит – 99. На операции рак легкого подтвержден только в 75 случаях, у других оказались заболевания хронического неспецифического нагноительного процесса.

У 62 больных, поступивших с предварительным диагнозом различных нагноительных заболеваний и кист легких, на операции центральный рак обнаружен в 3 случаях, периферический рак в 59 случаях (эндоскопически не установленный).

При исследовании операционного материала у 134 больных с периферической локализацией онкологического процесса, аденокарцинома получена в 13 случаях, плоскоклеточный рак в 26 случаях, мелкоклеточный рак в 14, низкодифференцированный рак в 16, недифференцированный рак в 24 случаях, смешанный рак в 41 случае.

Выводы: полученные данные морфологической верификации неопластических процессов в легких в дооперационном периоде на начальных этапах развития заболевания диктуют необходимость разработки и усовершенствования способов эндоскопической диагностики в условиях современного процесса техники и медицины.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Жумадуллаев Б.М.

Казахский научно-исследовательский институт
онкологии и радиологии, г.Алматы

Актуальность. В республике Казахстан ежегодно регистрируется около 50 первичных случаев заболевания опухолей головного мозга (ОГМ) у детей, что составляет 18-25% среди всех солидных новообразований. Злокачественные глиомы (ЗГ) – составляют от 7 до 11% среди всех опухолей центральной нервной системы (ЦНС) у детей. Отмечается рост заболеваемости с опухолями ЦНС у детей. Так в 2000 году заболеваемость с ОГМ составила 18,2%, в 2006 году – 24,8% и в 2009 году – 20,2%. Общепринятым лечением ЗГ является максимальное удаление опухоли, проведение постоперационной лучевой терапии (ЛТ) и применение различных схем химиотерапии.

Цель: изучение эффективности Темодала в лечении ЗГ головного мозга у детей.

Объект и методы исследования: в исследование были включены 31 детей с ЗГМ в возрасте от 3 до 17 лет, мальчики – 18 (58,1%), девочки – 13 (41,9%). Объем хирургических вмешательств: 8 больным «тотальное», 19 пациентам субтотальное удаление опухоли и 4 – биопсия опухоли. Гистологическая структура опухоли: анапластическая астроцитомы – 20, глиобластома – 11 больных. До начала терапии качества жизни больных по шкале Карновского от 30 до 60%. Перед началом лечения и после каждого этапа терапии, а так же после завершения лечения в сроки 6, 12 и 18, 24, 30 мес. проводилась МРТ головного мозга с контрастным усилением (КУ). При оценке ответа на терапию использовали стандартные критерии: CR – полное отсутствие опухоли, PR – уменьшение размера опухоли более 50%, SD – уменьшение размера опухоли менее 50%, PD – увеличение размеров опухоли более 25% или появление новых очагов. Перед началом лечения и после каждого этапа терапии выполнялись клинический, неврологический и офтальмологический осмотры.

Лечение: Операция → ЛТ + ХТ (темозоломид + ломустин = 1 цикл) → 6 циклов ПХТ (темозоломид + ломустин). ЛТ проводился на линейном ускорителе, на 14-21 дни после операции, до СД= 50- 55 Гр., РД= 1,8 Гр. Одновременно с ЛТ в первую неделю облучения проводился цикл ХТ: темозоломид – 150 мг/м² – 1-5 дни; Ломустин – 120 мг/м² – 1 день + гормональная терапия. В дальнейшем 6 циклов ХТ по выше указанной схеме с интервалами в 6 нед. + сопроводительная терапия.

Результаты: У 2 (6,5%) пациентов с МГБ в процессе ХЛЛ отмечены ухудшение состояния и были исключены из исследования. В процессе и после завершения ХЛЛ этапа терапии у 29 (93,5%) больных значительно купированы патологические неврологические симптомы, отмечены улучшения качества жизни: по шкале Карновского: 50-100%. Общие токсические проявления отмечены в основном II-III ст., и на фоне сопроводительной терапии были легко купируемые. Гематологическая токсичность: лейкопения II-III ст. наблюдалась у 12 (38,7%) больных, тромбоцитопения II степени – у 8 (25,8%) пациентов, в основном после первого этапа терапии. Признаков органной и кумулятивной токсичности не наблюдалось. 26 больным проведены и завершены все этапы терапии. По данным контрольного МРТ головного мозга с КУ, после ХЛЛ у 3 (10,3%) больных отмечены увеличение размеров опухоли, а у 26 детей (89,6%) достигнуто объективный ответ: CR- 7 (24,1%), PR- 14 (48,3%) SD- 5 (17,3%). В процессе цикловой ХТ 3 больных из-за прогрессирования заболевания переведены

на симптоматическую терапию. После завершения протокола лечения по данным контрольного МРТ головного мозга с КУ у 7 (26,9%) пациентов достигнута – CR, PR- у 9 (34,6%) SD - у 6 (23,1%) и у 4 (15,4%) больных - CR. Одногодичная выживаемость составила 83,9±6,6%, безрецидивная – 71±8,3%. 3-летняя выживаемость составила 57,7±9,9%, безрецидивная – 46,2±9,9%. 5-летняя выживаемость – 42,3±9,9%, безрецидивная – 34,6±9,5%.

Выводы: Применение темодала и ломустина на фоне и после ЛТ в лечении ЗГГМ у детей показало удовлетворительную эффективность без выраженных токсических симптомов и достигнуто улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения.

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ.

Ижанов М.Т. Жетибаева Г.К.

Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) одна из наиболее распространенных форм злокачественных опухолей у женщин во всем мире. За последние 30 лет заболеваемость РМЖ возросла в 2,8 раза и имеет постоянную тенденцию к увеличению, но не смотря на это благодаря определенному улучшению ранней диагностики заболевания и клинических исследований проведение органосохраняющих операций при раке молочной железы на сегодняшний день становится все более популярным. Размер первичной опухоли один из сильных факторов прогноза течения рака молочной железы. Увеличение размера первичной опухоли прямо коррелирует с поражением регионарных лимфатических узлов, и тем самым влияет на снижение общей и безрецидивной выживаемости. Минимальный рак (опухоль менее 1 см в диаметре) характеризуется благоприятным течением после органосохраняющих операций. При размере опухоли до 1 см 20-летняя выживаемость достигает 90%, а риск развития рецидива не превышает 10%. При опухолях от 1 см до 2 см имеется уже 25% риск развития рецидива, а при T2N0M0 подобный риск достигает 30-35%. Наличие метастазов в лимфатических узлах, степень злокачественности, мультицентричность и мультифокальность опухоли «позитивные» хирургические края все это говорит об актуальности исследований, касающихся органосохраняющего лечения РМЖ и его прогноза.

Цель исследования: изучить факторы риска возникновения рецидивов при раке молочной железы после проведения органосохраняющих операций.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением было 95 женщин с T1-2N0-1M0 стадией РМЖ. Из них с 1 стадией заболевания было 32 (33,6%), со 2 стадией 63 (66,3%) пациенток. Возраст больных колебался в пределах 35-70 лет. Из них в возрасте 35-39 лет 11 (11,5 %) больных, 40-49 лет 32 (33,6%) пациенток, 50-59 лет - 38 (40%) больных, более 60 лет - 9 (9,4%) больных. Средний возраст больных - 49,5 года. Заболевание левой молочной железы наблюдалось у 52 (54,7%) больных, правой молочной железы - у 43 (45,2%) пациенток. Следует отметить, что у 73 (76,8%) больных опухоль локализовалась в верхне-наружных квадрантах молочной железы, у 22 (23,1%) больных в других квадрантах.

Результаты. Размер опухоли, - это один из наиболее весомых факторов при выполнении органосохраняющих операций. При размере опухоли от 0,5 до 2,0 см частота развития рецидивов не превышала 12%, тогда как при размере опухоли более 2,0 см этот показатель достигал 19,8%. Следует отметить, что при длительном наблюдении (5-10 лет) за больными, подвергшимися органосохраняющему

лечению, отмечается снижение показателей выживаемости по мере увеличения размера опухоли. В группах больных с pN0 и pN1 абсолютное отличие в 5-летней выживаемости равнялось 22% (89% против 67%).

Различия в выживаемости прослеживались и в общей 5-летней выживаемости. Для G1, G2, G3, 5-летняя общая выживаемость равнялась 91%, 83%, 78%.

Выводы. Таким образом размер опухоли больше 2 см, высокая степень гистологической злокачественности, пораженные метастазами лимфатические узлы, мультицентричность, «позитивные» края опухоли увеличивают риск развития местно-регионарных рецидивов на 10-15% после органосохраняющих операций рака молочной железы.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ РАННИХ, МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ И ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ижанов М.Т., Сарсембаев А.А.,

Игликов М.К., Бимаганбетова Н.Б.

Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер г. Шымкент

Актуальность. Рак молочной железы наиболее частая форма рака у женщин, и в ближайшие 10 лет ожидается, что этим заболеванием будут страдать около 5 млн. женщин в мире. (В.И. Тарутинов 2003г.) В Республике Казахстан это форма опухоли находится на первом месте в структуре заболеваемости у женщин (19,1%), а частота ее неизменно растет.

Цель работы: на основе изучения отдаленных результатов лечения рака молочной железы в зависимости от стадии предположить в практику наиболее эффективные методы лечебных воздействий.

Материалы и методы исследования: нами ретроспективно прослежена пятилетняя выживаемость 1047 больных раком молочной железы, леченных чисто операцией (425) больных, комбинированное лечение (38) больных, комплексное лечение (584) больных.

Хирургическое лечение было в различных вариантах: радикальная резекция по Блохину, радикальная мастэктомия по Маддену, до радикальной мастэктомии по Холстеду.

Результаты: На эффективность методов проведенного лечения при раке

молочной железы оказывали следующие факторы:

Размеры опухоли и ее взаимоотношение с окружающими тканями молочной железы.

Морфология и степень злокачественности опухоли.

Возраст и состояние иммунитета организма больных.

Чувствительность опухоли к лучевой терапии, а также к химио- и гормонотерапии.

Выводы: При раннем раке (T1N0M0) на сегодняшний день эффективным способом лечения является хирургический метод лечения. (Широкая секторальная резекция с лимфодиссекцией подмышечных лимфоузлов на стороне поражения) При этом пятилетняя выживаемость составила (90%). При (11а-11б) лечебный эффект достигнуто от комплексной терапии (РМЭ + хл-терапия + лл-терапия). Более 5-ти лет живут (75-80% при 11а ст. и 70-75% при 11б ст.) При 111-1V ст. провели (НАПХТ 4-6 курсов в комбинации с лучевой и гормоно-терапией + РМЭ по Холстеду) Пятилетняя выживаемость составила (58-65%).

Усовершенствование схем применения новых химиопрепаратов с учетом биоритма и гормонального статуса организма, а также включение в эту схему лечения радикальных операций в сравнительном аспекте дает хорошие отдаленные результаты.

ОРГАНОСОХРАННЫЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА КОЖИ ВЕК.

Исламов З.С., Султанова Ш.Ш.
РОНЦ МЗ РУ, г. Ташкент, Узбекистан

Цель работы: разработка новых методов реконструктивно-пластических операций при раке кожи века.

Материалы и методы: в онкоофтальмологическом отделении проведено 32 реконструктивно— пластических операций у больных с раком кожи век 3-4ст. Возраст больных варьировал от 52 до 78 лет. Мужчин было 18 (56%), женщин 14 (44%). У 13 больных (40,6%) был плоскоклеточный рак, у 19 (59,4%) — базальноклеточный рак. У 8 больных (25%) опухоль была коже верхнего века, 10 больных (31%) — нижнего века, 14 больных (44%) нижнего века с распространением на интермаргинальный край. После удаления опухоли век, для закрытия дефекта нами разработаны реконструктивно-пластические операции на сосудистой ножке, с выкраиванием лоскута с верхнего или нижнего века, височной области, внутреннего угла глаза. При распространении опухолевого процесса на интермаргинальный край используются операции с иссечением опухоли и пластикой местными тканями с области щеки.

Результаты: у всех больных пересаженный лоскут прижился первичным натяжением, грубых рубцов не отмечалось, косметических дефектов век не наблюдалось. Срок наблюдения от 1 до 2 лет.

Рецидивы не отмечались. Из осложнений — у 2 больных отмечался вторичный конъюнктивит. Им была назначена противовоспалительная терапия.

Выводы: внедрение в практику офтальмологии новых реконструктивно-пластических операций позволяет избежать грубых рубцов, косметических дефектов лица, а также улучшить качество жизни больных с этой патологией.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ РЕКТО-АБДОМИНАЛЬНОГО ЛОСКУТА ПРИ ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Исмаилов А.Х., Ванесян А.С.
Кафедра онкологии и хирургии Казанской
государственной медицинской академии, Казань

Актуальность: При локализации рака в центральных или медиальных квадрантах молочной железы, помимо аксиллярного пути метастазирования, также возрастает роль парастерального коллектора. Поэтому, кроме радикальной операции по показаниям, необходимо также выполнить видеоторакоскопическую парастеральную лимфодиссекцию.

Цель: В данной работе рассматриваются недостатки сочетания радикальных операций на молочной железе с локализацией опухоли в центральной и медиальной зонах, с видеоторакоскопической парастеральной лимфодиссекцией и с различными способами одномоментных реконструктивно-пластических операций и пути их преодоления.

Материалы и методы: С 1996 - 2010гг. в отделении маммологии КОД МЗ РТ выполнено 515 реконструктивно-пластических операций по поводу РМЖ, из которых 459 были одномоментные реконструкции. Были выделены две группы пациентов, в первую из которых были включены больные, которым были выполнены одномоментные реконструкции в сочетании с парастеральной лимфодиссекцией (173), во вторую группу были включены больные с одномоментной реконструкцией без парастеральной лимфодиссекции (286).

Результаты и обсуждение: При анализе ранних послеоперационных осложнений достоверная разница ($p < 0.005$) была обнаружена только при сравнении групп с пластикой

лоскутом- TRAM и парастеральной лимфодиссекцией и без парастеральной лимфодиссекции. В первой группе больше количество послеоперационных осложнений (33,1% по сравнению с 28,2% в группе без парастеральной лимфодиссекции), в основном за счет наличия краевых некрозов (17,9% по сравнению с 10,4% в группе без парастеральной лимфодиссекции), что связано с невозможностью забора лоскута на обеих прямых мышцах живота при больших объемах переносимых тканей. Выходом из создавшегося ситуации является дополнительная васкуляризация лоскута-TRAM.

Выводы: Невозможность использования ипсилатеральной прямой мышцы живота при сочетании видеоторакоскопической парастеральной лимфодиссекции с одномоментной реконструкцией лоскутом TRAM решается за счет дополнительной васкуляризации контралатеральной мышцы путем наложения микрососудистого анастомоза между нижними надчревными и внутренними грудными сосудами (с видеоторакоскопической мобилизацией последних).

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Исмаилов А.Х., Ванесян А.С.
Кафедра онкологии и хирургии Казанской
государственной медицинской академии, Казань

Актуальность: Реконструкция молочной железы играет важную роль в физическом, эмоциональном и психологическом восстановлении женщин с раком молочной железы после перенесенной радикальной операции.

Цель: Целью данного исследования являлось изучение влияния одномоментных реконструктивных операций на качество жизни пациентов с раком молочной железы при помощи опросника MOS SF-36 (Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey).

Материалы и методы: На вопросы опросника SF-36 самостоятельно ответили 36 пациента, 20 из которых была выполнена немедленная реконструкция молочной железы в сочетании с мастэктомией (средний возраст 42; границы 30-63), а 16 пациентам была выполнена только мастэктомия без реконструкции (средний возраст 55; границы 39-70).

Результаты: По результатам опроса выявлено, что по параметрам физическое функционирование (PF), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE), интенсивность боли (BP), общее состояние здоровья (GH), жизненная активность (VT) и психическое здоровье (MH) у больных с реконструкцией показатели намного выше, чем у больных без реконструкции ($p < 0,05$). Наиболее значимая разница наблюдалась по параметрам ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE), среднее значение в группе с пластикой превосходит среднее значение в группе без пластики на 38,9%, а также по показателям физическое функционирование и интенсивность боли (37,7% и 34,6% соответственно). По показателям социальное функционирование и ролевое функционирование, обусловленное физическим здоровьем статистически значимой разницы между группами не выявлено ($p > 0,05$).

Заключение: Одномоментная реконструкция молочной железы у больных раком молочной железы улучшает физическое и ролевое-эмоциональное функционирование пациентов, общее состояние здоровья и психическое здоровье. Благодаря реконструктивным операциям увеличивается жизнеспособность пациентов и они чувствуют боль менее интенсивно, чем пациенты, которым была выполнена мастэктомия.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: НАСКОЛЬКО ОПРАВДАНО ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Исмаилов А.Х., Гимранов А.М., Овчинникова И.В., Ванесян А.С.

Республиканский клинический онкологический диспансер, г. Казань

Введение: В подавляющем большинстве случаев неотъемлемым компонентом лечения рака молочной железы остается радикальная мастэктомия, следовательно, вместе с ростом выживаемости, растет и число глубоко инвалидизированных в ходе радикального лечения женщин. Утрата молочной железы для большинства из этих больных является огромной психологической травмой и часто заставляет серьезно менять привычный образ жизни, одновременно поддерживая воспоминания о перенесенном лечении по поводу рака. Признано, что восстановление молочной железы является главным средством психо-социальной адаптации женщины к перенесенной мастэктомии.

Цель: Целью данного исследования являлось изучение отдаленных результатов хирургического лечения рака молочной железы, при сочетании радикальных операций с одномоментными реконструктивно-пластическими операциями.

Материалы и методы: Нами ретроспективно проведен сравнительный анализ отдаленных результатов хирургического лечения 811 больных раком молочной железы, прооперированных в отделении маммологии КОД МЗ РТ с 1983 по 2009гг. Выделены две группы пациентов. В первую группу были включены больные, которым были выполнены одномоментные реконструктивно-пластические операции (406), из которых 160 больным была выполнена реконструкция лоскутом TRAM, 88 больным - реконструкция перманентным экспандер-имплантатом Беккера, и 158 больным была выполнена реконструкция лоскутом ТДЛ. Вторую группу составили пациенты, которым была выполнена только радикальная операция без реконструкции (405).

Результаты: В первой группе 5-летний срок преодолели 95,3±2,1 пациента I стадии. При IIA стадии показатель пятилетней выживаемости составил 86,4±2,1, при IIB – 84,7±2,1, при IIIA и IIIB соответственно 71,4±2,2 и 66,6±2,3. Во второй группе показатели распределились следующим образом: I - 96,9±2,6, IIA - 90,0±2,8, IIB - 87,9±2,7, при IIIA и IIIB соответственно 78,0±3,1 и 63,2±3,6.

Выводы: При сравнении этих данных, очевидно, что статистически значимой разницы не наблюдается между двумя группами, т.е. восстановление молочной железы не ухудшает онкологических результатов, так как не изменяет объем хирургического вмешательства и не влияет на общий план лечения.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА

Кайдаров Б.К., Хожаев А.А., Балтаев Н.А., Ким А.В., Шатковская О.В., Тумабаева Х.Т., Кайдарова А.Б., Шапаева У.К., Тасбулатов З.О., Кленин В.В. (ст)

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Городской онкологический диспансер, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Рак желудка (РЖ) занимает одно из лидирующих мест в структуре онкозаболеваемости населения нашей республики. При этом удельный вес IV стадии заболевания составил в 2008 году 29,7% (среднереспубликанский показатель), занимая первое место среди всех локализаций. В связи с этим повышение эффективности паллиативного лечения и качества жизни (КЖ) больных РЖ является одной из насущных проблем клинической онкологии.

Цель работы: повышение эффективности паллиативного

лечения и определение основных показателей КЖ у больных РЖ IV стадии.

Материал и методы. В исследование включено 62 пациента РЖ IV стадии, находившихся на лечении в Городском онкологическом диспансере г. Алматы в 2008-2009 г.г. В соответствии с задачами исследования пациенты составили следующие группы: I (основная) группа – пациенты, получившие паллиативное комбинированное лечение: циторедуктивная гастрэктомия и послеоперационные курсы ПХТ согласно стандартам лечения (23 больных); II (контрольная) группа – больные, которым проведено паллиативное терапевтическое лечение – курсы ПХТ + симптоматическая терапия (39 пациентов). Оценка КЖ проводилась посредством модульного опросника оценки функций в онкологии – FACT-Ga (version 4), включающего 27 вопросов, которые формируют 4 шкалы: физического, социального (включая семейное), эмоционального функционирования, благополучия в повседневной жизни и специфического модуля, содержащего 19 вопросов. В 1-й точке исследования КЖ (до начала лечения) показатели шкал опросника FACT-Ga в исследуемых группах не имели достоверных отличий ($p>0,05$).

Результаты. Сравнительная оценка КЖ в основной группе по отношению к контрольной показала, что статистически значимые различия ($p<0,05$) по среднему баллу шкал опросника FACT-Ga были выявлены по всем 4 базовым шкалам и дополнительно модулю во всех точках исследования после начала лечения. При этом медиана выживаемости составила в основной группе 13,6 мес, а в контрольной – 6,2 мес ($p<0,05$).

Выводы. Выполнение циторедуктивной гастрэктомии при IV стадии РЖ позволяет улучшить отдаленные результаты лечения и КЖ больных.

РАННЕЕ ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ В ОНКОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ ОПЕРИРОВАННЫХ НА ОРГАНАХ ЖКТ.

Кайрашева С.Е.

Региональный онкологический диспансер, г. Семей.

Интерес к энтеральному зондовому питанию (ЭЗП) больных после операции связано с представлениями о кишечнике как метаболическом, эндокринном, иммунном органе, барьере перед микробной инвазией, органе, обеспечивающем постоянство внутренней среды организма.

Цель исследования: Оптимизация терапии ЭЗП больных оперированных на органах ЖКТ на фоне изучения центральной гемодинамики.

Материалы и методы. В хирургическом отделении онкологического диспансера г. Семей ЭЗП в раннем послеоперационном периоде проводилось у 28 больных в возрасте от 38 до 72 лет (16 женщин, 12 мужчин) в том числе раком желудка – 23, рак пищевода – 5.

В качестве зонда для питания использовали зонд собственной конструкции с мягкой оливой на конце плотно прилегающей к просвету внешнего зонда. Для оценки исходного трофического статуса пациентов и эффективности проводимой нутритивной поддержки определяли массу тела (МТ) и ее отношение к "идеальной" массе тела (ИМТ), рассчитанной по формуле Брока. С 1 суток после операции исследовали содержание альбумина плазмы, суточную экскрецию креатинина и мочевины с мочой.

Результаты исследования: Из 28 больных до операции у 24 больных (85,9%) имели нормальные показатели питательного статуса или умеренную недостаточность, остальные 4 (14,1%) больных – выраженную или предельную недостаточность питания. При выписке из стационара у 25 больных (90,2%) были нормальные показатели питания, а выраженная недостаточность отмечалась у 3 больных (9,8%). Исходные величины антропометрических показателей свидетельствовали об истощении больных, а уровень альбумина ($35,1\pm0,78$) – о значительной потере плазменных белков. На 3 сутки после

операции показатели МТ, МТ/ИМТ, ТМТ, КРИ, и альбумина незначительно уменьшались. Азотный баланс составлял $2,97 \pm 1,13$. Но уже на 5 сутки послеоперационного периода наблюдалась четкая тенденция к увеличению антропометрических показателей, уровня альбумина плазмы.

Выводы: Таким образом, нутритивная поддержка смесью «Унипит» в раннем послеоперационном периоде обеспечивает быстрое и эффективное уменьшение катаболизма и формирование анаболических процессов, ограничит полное парентеральное питание в период инфузионной терапии.

ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ ПРИ РАСШИРЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ОНКОХИРУРГИИ

Кайрашова С.Е.

Региональный онкологический диспансер, г. Семей

Поражение печени лекарственными препаратами составляют около 10% всех побочных реакций организма больного, связанных с применением фармакологических препаратов.

Цель исследования: Прогнозирование и профилактика гепатопатии на фоне изучения печеночных показателей при расширенных операциях в онкологии.

Материалы и методы. Профилактика и лечение печеночной дисфункции было проведено 34 оперированным больным, со злокачественными новообразованиями в возрасте от 31 до 69 лет. Мужчин было 19, женщин-15. Объемные расширенные операции проводились при раке желудка-25 больным, раке пищевода-9. Всем им лабораторными тестами определяли функциональное состояние и степень дисфункции печени. В зависимости от этого проводилась защита и гепатопротекция препаратом гептрал. Препарат в дозе 0,4гр. включали в аутоэритроциты больного путем гипоосмотического гемолиза и вводили внутривенно в до-, интра- и послеоперационном периодах.

Результаты исследования: Высокая клинико-лабораторная эффективность метода определена результатами исследования, которые показали, что после 3-х введений гепатопротектора гептрала в/в улучшились биохимические лабораторные показатели крови (таблица).

Таблица. Динамика функциональных показателей печени.

Показатели	Сроки наблюдения			
	Контр. группа	До операции (1 введение)	Во время операции (2 введение)	После операции (3 введение)
Общий билирубин	$21,3 \pm 0,7$	$23,4 \pm 0,9^*$	$21,7 \pm 0,8$	$21,0 \pm 0,5$
Холестерин	$5,6 \pm 0,35$	$4,5 \pm 0,29^*$	$4,8 \pm 0,30$	$5,1 \pm 0,32$
АлАТ	$0,75 \pm 0,049$	$1,2 \pm 0,087^*$	$0,97 \pm 0,066$	$0,70 \pm 0,052$
АсАТ	$0,53 \pm 0,023$	$0,56 \pm 0,028^*$	$0,50 \pm 0,022$	$0,46 \pm 0,020^*$
Гамма-глобулин	$16 \pm 0,48$	$15 \pm 0,43$	$15 \pm 0,43$	$17 \pm 0,49$
Тимоловая проба	$3,0 \pm 0,20$	$5,3 \pm 0,33^*$	$4,5 \pm 0,29$	$4,0 \pm 0,25$

Примечание: * - достоверность различий по сравнению с контрольной группой $p < 0,05$.

Лабораторные анализы показали положительную динамику биохимических показателей, характеризующих синдром холестаза и цитолиза (АЛТ, АСТ, ЩФ, билирубина) Улучшились и клинические данные у больных основной группы: уменьшились боли, дискомфорт и чувство тяжести в правом подреберье, исчезла тошнота, улучшилось общее самочувствие.

Выводы: гептрал может применяться как система «доставки» его в печень для непосредственной реализации своего терапевтического действия, а также многофункциональность гептрала делает его препаратом выбора для защиты и лечения дисфункции печени у онкологических больных.

РОЛЬ ПАЛЛИАТИВНЫХ НЕФРЕКТОМИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ С ОТДАЛЕННЫМИ МЕТАСТАЗАМИ

Койшыбаев А. К.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР-болезней, г.Актобе.

Цель исследования: Улучшение отдаленных результатов комбинированного лечения и качества жизни пациентов раком почки с отдаленными метастазами.

Материал и методы исследования: Причиной смерти больных раком почки с отдаленными метастазами часто являются осложнения со стороны основной опухоли в виде кровотечения, сдавления жизненно важных органов, сосудов, разрыва опухоли и т.д.

На период с 2005 года по 2009 год 18 пациентам раком почки, имеющим отдаленные метастазы, произведены циторедуктивные нефруретерэктомии.

Пациентам в предоперационном периоде проводилось комплексное обследование с включением УЗИ, КТ-графии, МРТ, выделительной урографии, исследование азотистого обмена, с целью выяснения резектабельности опухоли и функциональных способностей контрлатеральной почки. У всех больных выявлены отдаленные метастазы: у 8-и больных – в лёгком, из них у 3-х имело место двухстороннее поражение, поражение костей скелета – 5 больных, из них у 2-х имело место множественное поражение скелета с патологическими переломами, метастазы в печени – у 4-х, в мягкие ткани брюшной стенки – у 1-го. У всех больных имело место осложнения опухолевого процесса в виде микро-макрогематурии. У 1-го пациента имело место патологические переломы CV и DIX позвонков.

Определяющими факторами, при наличии отдаленных метастазов, были нормальная функция противоположной почки и функциональная операбельность пациентов.

6-и больным производили, наряду с нефруретерэктомией, резекцию соседних органов (печень – 2 случая, дистальная резекция поджелудочной железы и спленэктомия - 1, спленэктомия в связи синвазией опухоли – 1, резекция ободочной кишки – 2).

Доступ при этих операциях - широкая срединная лапаротомия. Во время нефруретерэктомии выполняли парааортальную лимфодиссекцию по обе стороны аорты.

Результаты: В послеоперационном периоде у 2-х больных развились осложнения: у 1-го кровотечение, что потребовало выполнение релапаротомии, остановки кровотечения, у 1-го пациента развился панкреатический свищ, который закрылся самостоятельно. Послеоперационной летальности не было. Всем больным в последующем проводились курсы химиотерапии. В течение года живы все пациенты. Медиана выживаемости составила 24 месяца. У пациентов улучшилось самочувствие, показатели крови, уменьшился болевой синдром, исчезли симптомы интоксикации. У некоторых пациентов отмечена стабилизация и регрессия легочных метастазов. У больных, имевших скелетные метастазы, исчезли боли.

Выводы: 1. Паллиативная циторедуктивная нефруретерэктомия при раке почки с отдаленными метастазами, позволяет улучшить качество жизни пациентов и создает благоприятные условия для проведения дополнительной специальной терапии, предупреждает осложнения со стороны первичной опухоли и позволяет надеяться на улучшение отдаленных результатов комбинированного лечения.

2. Её следует выполнять всегда, если пациент функционально операбелен.

ПОКАЗАНИЯ К СИМУЛЬТАННЫМ ОПЕРАЦИЯМ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ.

Койшыбаев А.К., Дюсембеков С.Т.,

Бегунов В.В., Зайцева Л.С., Уразаев О.Н.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, кафедра онкологии с курсом лучевой терапии, лучевой диагностики и ЛОР-болезней, г.Актобе.

Актуальность. Современные возможности хирургии и анестезиологии позволяют расширить диапазон сочетанных операции, что позволяет избавить пациентов от повторных операции и эмоциональных стрессов, а также предупреждает возможности обострений и осложнений от сопутствующих заболеваний.

Симультанными операциями считаются те, которые выполняются одновременно при двух или более хирургических заболеваниях на разных органах. При сочетанных операциях различают основной и симультанные зоны, когда основным направлением является удаление наиболее опасного патологического процесса.

При выборе показаний выделяют абсолютные – когда оба заболевания взаимосвязаны друг с другом и отягощают состояние, превентивные показания по поводу заболевания, которые в будущем могут обусловить осложнения, рецидивы.

Цель исследования. Определение показаний к проведению симультанных операции при колоректальном раке, объёме предоперационной подготовки, обоснование хирургического доступа, анестезиологического пособия, улучшения качества жизни больных.

Материал и методы исследования. В медицинском центре ЗКГМУ им.Марата Оспанова в период с 2005 по 2009 г. оперированы 16 больных с опухолями ободочной, прямой кишки и сопутствующей хирургической патологией, которым были показаны симультанные операции. Из них у 6 больных основной сопутствующей патологией был калькулезный холецист (произведены холецистэктомия), у 4 больных имелась опухолевая патология желудка – произведены моноблочная симультанная гастропленэктомия с лимфодиссекцией в объёме D2 и право-или левосторонняя гемиколэктомии. В остальных 6 случаях имелись патология органов гениталия и мочевыделительной систем.

Результаты исследования. Количество послеоперационных составило 2 случая (12,5 %) в виде нагноения послеоперационной раны и длительного желчеотделения в 1 случае. Летальности не наблюдалось.

Выводы. Таким образом, приведенные данные говорят о необходимости проведения симультанных операции у больных колоректальным раком при наличии сопутствующей хирургической патологией и соблюдении онкологических принципов при выявлении первично-множественных опухолей, т.е. моноблочности и абластичности.

ОПЫТ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА

Кротов Н.Ф., Расулов А.Э., Имамов О.А., Алмардонов Р.Б.,

Мадияров Б.Т., Воротников В.В., Бердикулов Д.И.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз, г.Ташкент. Узбекистан.

Цель исследования. Анализ результатов реконструктивно-восстановительных операций (РВО) при раке грудного отдела пищевода (РГОП).

Материалы и методы. С 2000 по 2009гг. в торакальном отделении РОНЦ МЗ РУз выполнено 306 РВО при РГОП. Мужчин было – 147 (48,1%), женщин – 159 (51,9%). Возраст больных колебался от 24 до 77 лет (средний возраст 51,3 лет). Распределение больных по стадиям заболевания: II – 23 (7,5%), III – 283 (92,5%). Локализация опухоли в верхнегрудном отделе (ВГОП) пищевода у 35 (11,4%) больных,

среднегрудном (СГОП) у 159 (51,9%) и у 112 (36,6%) в нижнегрудном (НГОП).

При локализации опухолевого процесса в ВГОП (35 (11,4%) больных) выполнялась трехдоступная эзофагэктомия - операция McKeown с наложением цервикального ЭГА. При локализации опухоли в СГОП и НГОП выполнялись следующие виды операций: операция Ивор-Льюиса выполнена 71 (23,2%) больному с более высокими функциональными показателями, трансхиатальная эзофагэктомия (ТХЭ) 200 (65,3%) пациентам, с более низкими функциональными показателями. Из 200 пациентов у 120 мобилизация СГОП и ВГОП, медиастинальная лимфодиссекция выполнена видеоассистированием. 124 больным цервикальный ЭГА наложен по предложенной нами методике.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде осложненное течение отмечено после операции McKeown у 19 (54,3%) больных, после операции Ивор-Льюиса у 42 (59,1%) и после ТХЭ у 43 (21,5%). Общая послеоперационная летальность составила 6,8% (21 больной), при этом: после операции McKeown - 2 (5,7%), после операции Ивор-Льюиса - 7 (9,8%) и после ТХЭ – 12 (6%). Наиболее частым поздним осложнением явилось рубцовое сужение ЭГА, что отмечено у 25 больных: после операции McKeown – 3 (8,5%), операции Льюиса – 9 (12,6%) и ТХЭ – 19 (9,5%). Наложение антирефлюксного цервикального ЭГА по нашей методике позволило снизить рубцовое сужение с 33 до 5%, а случаи аспирационной пневмонии с 9,8 до 1,5%.

Выводы. Правильный выбор оперативного доступа с учетом локализации опухолевого процесса на пищеводе, применение видеоассистирования при ТХЭ позволят уменьшить число интра- и послеоперационных осложнений. Формирование цервикального ЭГА по разработанной нами методике позволит практически избежать грозных осложнений РВО на пищеводе, свести до минимума частоту стенозов, избежать в отдаленном периоде выраженного желудочно-пищеводного рефлюкса.

ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ

Кротов Н.Ф., Расулов А.Э., Имамов О.А., Чернышева Т.В.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз, г.Ташкент. Узбекистан.

Цель исследования. Анализ результатов видеоторакоскопических операций (ВТО), выполненных при периферических образованиях легких (ПОЛ).

Материалы и методы. С 2000 по 2008 гг. в торакальном отделении РОНЦ МЗ РУз выполнено - 40 ВТО при ПОЛ. Возраст больных колебался от 15 до 63 лет, среди них мужчин - 26(65%), женщин 14(35%). Предоперационные комплексные обследования не позволили диагностировать гистологическую структуру образований. Использование ВТО позволило определить характер и распространенность патологического процесса, объём оперативного вмешательства. ВТО в основном выполнялись при периферической, субплевральной локализации образований.

Результаты. У 20 (50%) пациентов - наличие субплеврального округлого образования, без вовлечения в процесс окружающей легочной паренхимы. Произведено прецизионное удаление. Гистология: гамартохондрома – 15, хондрома в – 5 случаях. У 13 (32,5%) выявлена картина перифокального воспаления, выполнена атипичная резекция легочной ткани с опухолью. Гистология: туберкулема - 9; фиброма – 4. У 2 (5%) при ревизии диагностирован симптом стягивания висцеральной плевры и перифокальной легочной ткани в опухоль, наличие увеличенных лимфоузлов. Произведена анатомическая резекция пораженной доли. Гистология: низкодифференцированная аденокарцинома. У 5 (12,5%) - пери-

ферическая опухоль с диссеминацией по плевре. Операция окончена биопсией. Гистология: аденокарцинома. Каких-либо осложнений, связанных с проведением ВТО не отмечено.

Выводы. ВТО являются завершающим этапом диагностики ПОЛ, позволяют установить точный диагноз, выполнить необходимый объем операции, при необходимости перейти на стандартную торакотомию.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОНКОКОЛОПРОКТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С КОЛОСТОМАМИ

Кусаинов Е. Т.

*Восточно-Казахстанский областной онкологический
диспансер*

Восстановление непрерывности толстой кишки приобретает решающее значение для социально-трудовой и моральной реабилитации этого контингента больных. Успех восстановительных операции зависят от выбора оптимального срока для их выполнения, общего состояния больных, отсутствия рецидивов, метастазов, наличие периколостомических осложнений. В период 2000 - 2010гг выполнено 49 операции по ликвидации различных видов колостом. Наибольшее количество восстановительных операции выполнялись после операции Гартмана - 80 %, остальные с цекастомой, трансверзостомой, илеостомой.

Одноствольные колостомы после операции Гартмана закрывались через 10-12 месяцев. У наших пациентов в зависимости от вида колостом, состояния больных сроки восстановительных операции колебались от 3 месяцев до 3-х лет. Основными методами восстановительных операции были наложения сигмаректоанастомоза конец в бок, конец в конец, внебрюшинные устрания колостом у 5 больных, илеотрансверзоанастомоз с ликвидацией илеостомы, а также производились операции с левостомией, гемиколэктомией в 3-х случаях, передняя резекция прямой кишки с ликвидацией рецидива в области колостомы и в области культи дистального отрезка прямой кишки.

Выводы:

1. У больных с 2-х ствольной колостомой при восстановлении толстокишечной проходимости предпочтение следует отдавать внутрибрюшному методу, так как он более радикален и дает меньшее число послеоперационных осложнений.
2. Внебрюшинный метод закрытия лучше проводить при неосложненных пристеночных или петлевых колостомах с податливой шпорой и при отсутствии воспалительно-рубцовых изменений в области колостом.
3. При закрытии колостом оптимальным сроком восстановительных операции следует считать от 9- 12 месяцев.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ОРОФАРЕНГИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Кыдырбаева Г.Ж.

*Казахский научно-исследовательский институт
онкологии и радиологии г.Алматы*

Проблема лечения пациентов с данной патологией остается актуальной. Проводимые радикальные оперативные вмешательства ухудшают качество жизни пациента в связи с косметическими и функциональными нарушениями. Для решения этой проблемы решаются вопросы реконструктивной и эстетической реабилитации, разработка новых способов операций и технологий.

Цель работы: Оценить возможности пластической хирургии для восстановления жизненно-важных функций.

Проведен анализ 350 больных местно-распространенным раком полости рта и глотки 111-1У стадии. В 80% случаях реконструктивно-пластические операции выполнялись при

первичной комбинированной пластике и в 20% случаях при отсроченной.

Хорошие косметические и функциональные результаты получены при использовании торако-дорсального лоскута. Так полное приживление лоскута отмечено у 65% больных, краевой или частичный некроз в следствии нарушения кровоснабжения в питающей ножке наблюдался у 35% пациентов.

При использовании кожно-мышечного лоскута с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы, торако-дорсального и дельтопекторального лоскутов в 90%, в 75% и 60% соответственно с отмечалось полное приживление лоскута. Применение кожно-мышечного лоскута с включением трапецевидной мышцы для создания внутренней выстилки оправдан в 86,6%.

С развитием микрохирургической аутоотрансплантацией нами был внедрен лучевой лоскут с помощью микрососудистых анастомозов. При использовании данного вида микрохирургической пластики в 72% случаев мы отмечали полное приживление тканей.

При применении отсроченной комбинированной пластики использовались кожно-мышечные лоскуты в сочетании с кожно-мышечными, кожно-жировыми и свободной кожной пластикой для формирования внутренней выстилки и наружной кожной выстилки.

Реконструктивные операции сопровождались ранними и поздними послеоперационными осложнениями. У 15% больных образовывались оро-фарингостомы, в следствии чего проводилась отсроченная пластика. Послеоперационные кровотечения наблюдались у 5% больных. У 1 больного развилась тромбоэмболия легочной артерии и у 1 пациента развилась пневмония.

Качество жизни больных мы оценивали по степени сохранения функции – самостоятельного питания, глотания и речи (85%). Применение первичных и отсроченных реконструктивно-пластических операций проведенных больным со злокачественными новообразованиями не увеличивают рецидивы и не ухудшают прогноз заболевания.

Выводы. Оптимизация и разработка методов реконструктивно-пластической хирургии способствует улучшению качества жизни пациента и сократить сроки реабилитации пациента.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Нурғалиев Н.С., Онғарбаев Б.Т.,

Кенжебаев Б.Ж., Ишкинин Е.И.

КазНИИОиР, отделение онкоурологии

Опухоли надпочечников относятся к относительно редким заболеваниям, составляя не более 0,6% от всех злокачественных новообразований. В большинстве случаев эти новообразования являются опухолями, исходящими либо из коркового, либо из мозгового слоя. Иногда эти образования являются метастазами опухолей другой локализации. Известно, что большинство опухолей надпочечников сопровождается артериальной гипертонией, нередко злокачественного характера, исчезающей после удаления опухоли. В этой связи проблема опухоли надпочечников, помимо ее онкологической направленности, приобретает совершенно новое значение, так как гипертония, являясь одним из ранних проявлений опухолевого страдания, должна учитываться для ранней диагностики новообразования.

Основным методом лечения опухолей надпочечников в настоящее время является хирургический. Успех хирургического лечения во многом зависит от предоперационной подготовки, адекватности обезболивания, правильности ведения послеоперационного периода. Предоперационную подготовку следует проводить с учетом степени гормональной активности опухоли, проявлений заболевания, его осложне-

ний и сопутствующей патологии. Обязательным является исследование уровня гормонов надпочечников – минералоглюкокортикоидов, кортикостероидов. В предоперационном периоде с целью коррекции состояния, ведение больного во время операции и послеоперационном периоде, необходимо координировать действия эндокринологов-терапевтов, урологов (хирургов) и анестезиологов.

Радикальным методом лечения является удаление опухоли (надпочечника), при необходимости с последующей заместительной терапией глюко-минералокортикоидов. Во время операции при гормонально-активных опухолях можно столкнуться с различными трудностями. Как правило, на начальном этапе ревизии и выделения надпочечника происходит массивный выброс гормонов, сопровождающийся тахикардией и гипертензией (частота сердечных сокращений повышается до 100-150 ударов в минуту, систолическое АД – до 200-280 мм.рт.ст.), в связи с чем для уменьшения нежелательных последствий необходимо использовать «управляемую гипотонию» – инфузию растворов нитроглицерина, пентамин и т.д. Необходимо стремиться быстрее перевязать основную вену надпочечника. Наоборот, после удаления железы наблюдается резкое снижение гемодинамики, что требует дополнительного введения гормональных средств (дексаметазон, адреналин, мезатон, полиглюкина).

В нашей клинике с 2006 года прооперировано 17 больных с опухолями надпочечников, в 5 случаях из которых гистологически выявлены аденома надпочечника, в остальных рак (в 1 случае метастаз рака легкого в надпочечник). На результатах нашего небольшого опыта можно высказать следующее заключение: 1. обязательно осмотр эндокринолога для решения вопроса о необходимости операции на данном этапе и коррекция гормонального статуса предоперационного и послеоперационного периода; 2. осмотр анестезиолога, для необходимости подготовки больного к операции, иметь возможность подготовиться самому анестезиологу к возможным скачкам АД во время операции; 3. стремиться максимально раньше перевязать основную надпочечниковую вену. На наш взгляд, при наличии достаточно квалифицированной службы анестезиологии-реаниматологии, подобные операции могут с успехом выполняться.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ

Балтабеков Н.Т., Абисатов Х.А.

*Алматинский городской онкологический диспансер.
Казахстанско – Российский медицинский университет*

Актуальность. Несмотря на то, меланома кожи относится к визуально доступным локализациям опухоли, среди впервые выявленных больных удельный вес поздних стадии (III – IV) колеблется в пределах 30 – 47% (Арзыкулов Ж.А. с соавт., 2007, Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2008.). Поэтому совершенствование существующих и разработка новых методов диагностики ее является актуальной задачей.

Цель исследования. Изучить состояние диагностики меланомы кожи в поликлиниках г.Алматы по отчетам 2004 года. Внедрить в практику современных методов уточняющей диагностики, таких как дерматоскопия аппаратом «Скиноскоп» фирмы «Менард» (Япония), газоразрядный визуализации (электронно – полевой топоческой томографии, определение иммунного статуса больных).

Методы исследования. Материалом для исследования послужили данные о 633 больных, которым наряду с рутинными методами применялись вышеуказанные методы диагностики. Так, дерматоскопия аппаратом «Скиноскоп» применялись у 308 пациентов, газоразрядная визуализация – у 85, иммунологические исследования – у 122 пациентов, кроме того среди врачей поликлиник г.Алматы в 2005г прочитаны 37 лекций по современным методам диагностики, через 3 месяца совместно с сотрудниками кафедры онкологии проведена аттестация

врачей поликлиник на знание «симптомов тревоги» при подозрении на наличие меланомы кожи.

Результаты исследования.

- Состояние ранней диагностики меланомы кожи в 2004г было неудовлетворительным, так как у 39,2+6,8% пациентов диагноз установлена в III и IV стадии опухолевого процесса. Повышение онкологической настороженности врачей общей лечебной сети путем чтения регулярных лекций и обязательной последующей аттестацией на знание ранних симптомов меланомы кожи позволяет снизить уровень поздней диагностики в 2006 году с 39,2+6,8% до 20,5+6,7% ($P<0,05$).

- Применение дерматоскопии аппаратом «Скиноскоп» позволяет увеличить эффективность выявления внутрикожных метастазов (сателлитов) с 28,0+3,4% при визуальном осмотре до 75,0+4,1% ($P<0,001$) и правильно выбрать объем оперативного вмешательства.

- Использование газоразрядной визуализации (ГРВ) перед началом лечения меланомы кожи помогает определить субклинические метастазы во внутренние органы. Частота совпадений диагнозов ГРВ в последующих гистологических исследованиях составила 88,9%, а с рентгеновским исследованием – 71,4%.

- Уровень клеточного иммунитета является важным прогностическим фактором. При рецидиве кожи в 98,2 2,3% случаев доклинически определяемого рецидива отмечается снижение основных показателей Т-клеточного иммунитета, включая СД3, СД4, СД8 и СД4/СД8 более чем на 30% от исходного.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА КОЖИ.

Мирманова Г.Ж., Савхатов Д.Х.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Актуальность темы. Рак кожи остается заболеванием, проблема которого продолжает быть актуальной в связи с тенденцией роста его во всем мире. Ведущий метод лечения – хирургический. Следует отметить, что основным критерием операций является частота тромботических осложнений и некроза пересаженных тканей.

Цель: Оценить возможности ультразвуковой доплерографии до операции и пересаженных лоскутов в послеоперационном периоде. Изучить непосредственные результаты лечения больных раком кожи.

Материалы и методы: На базе КазНИИОиР на клиническом материале были проанализированы результаты лечения 50 больных раком кожи, находившихся на стационарном лечении с 2007 по 2010гг. Эхоскопическое исследование проводилось на базе отделения ультразвуковой диагностики Казахского НИИ онкологии и радиологии.

Обследование осуществлялось с использованием основных стандартных режимов сканирования: режимы цветового и энергетического доплеровского картирования, спектральное доплеровское исследование. Предварительная подготовка пациентов к исследованию не проводилась. В ходе диагностического процесса последовательно изучались границы опухоли, её линейные размеры и объем, глубина инвазии, условная плотность ткани опухоли, взаимоотношение артерии и вены в составе сосудистой ножки, приоритет кровотока, а также показатели кровотока по обнаруженным сосудам. Не менее важной задачей был контроль над кровоснабжением и жизнеспособностью лоскута в послеоперационном периоде. В нашем исследовании ультразвуковая диагностика трансплантированного лоскута во всех вышеописанных режимах проводилась через 24, 48 и 72 часа после операции.

Результаты исследования. При ультразвуковом исследовании предполагаемой донорской зоны, у 37 пациентов

преобладал артериальный кровоток. Вероятность микротромбозов сосудов не определялась. Степень дисперсности при ультразвуковой амплитудной гистографии не превышала 4,9 ЕД. У 13 больных наблюдалась низкая – до 1/3 – степень васкуляризации предполагаемого трансплантата, степень дисперсности была снижена до 3,8 – 3,9 ЕД. По всей видимости, эти показатели были снижены в связи с нарушением сосудистого кровотока в лоскуте, что, косвенным образом, свидетельствовало о возможных проблемах с его приживлением и соответствующим кровоснабжением в будущем.

При энергетической доплерографии на первые сутки после операции положительная реваскуляризация отмечалась у 44 пациентов. Кровоток сосудов регистрировался четко. Степень дисперсности – в пределах 4,6 – 4,8. У 6 больных использование данной тактики позволило выявить в лоскуте нарушения кровоснабжения. После принятых соответствующих мер, при мониторинге отмечалось восстановление кровотока. Осложнения на 2-3-е сутки наблюдались у 11 больных. Из них: в 2-х случаях – тромбоз сосудистой ножки (в одном случае удалось возобновить кровоток); в 7 – некроз лоскута, у одного больного с раком нижней губы наблюдалось кровотечение и еще у одного – лимфостаз. Во всех остальных наблюдениях ультразвуковая доплер-флоуметрия не выявила каких-либо закономерностей в изменении скоростных параметров. Дальнейшее заживление раны протекало без осложнений. Удовлетворительные непосредственные результаты составили 78%.

Вывод: Применение комплексной программы ультразвуковой диагностики до и после пересадки кожного лоскута для замещения послеоперационного дефекта позволяет оценить состояние трансплантата, прогнозировать возможность приживления и скорректировать, в случае необходимости, программу лечения, тем самым, добиваясь высоких непосредственных результатов.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ГОРТАНИ

Набиев А.К., Орманов Н.К., Мухидинова И.Н.

Областной онкологический диспансер, г. Шымкент, Казахстан

Рак гортани (РГ) является наиболее часто встречающейся онкопатологией ЛОР-органов. Заболеваемость РГ составляет 0,8-5% среди всех злокачественных опухолей, по ЮКО выявляются 25-30 новых случаев РГ. Широко применяемая радикальная операция при РГ, то есть ларингэктомия (ЛЭ), может обеспечить хороший прогноз в плане излечения. Но многие больные отказываются от такого лечения, потому что ЛЭ является калечащей операцией, которая приводит к пожизненной трахеостомии и лишению гортани как органа, т.е. такой человек не только становится инвалидом на всю оставшуюся жизнь, но и не может быть реабилитирован социально. Все вышеизложенное показывает, что проблема лечения больных РГ остается актуальной и в настоящее время.

Целью нашей работы явилось изучить результаты комбинированного лечения больных РГ по данным Южно-Казахстанского областного онкологического диспансера.

Материал и методы. В ООД ЮКО за период 2006-2009гг. пролечено 98 больных РГ. Нами в сравнительном аспекте проанализированы результаты лечения 45 больных РГ III стадии в двух группах, где в I группе 20 больным (20,4%) проведена дистанционная гамма терапия (ДГТ) по радикальной программе (РОД 2 Гр до СОД 60 Гр в режиме с двух встречных полей), а во II группе 25 больным (25,5%) производилась радикальная операция - ЛЭ. Большинство наблюдений обеих групп составили в возрасте 51-70 лет. В исследуемых группах преобладали больные со смешанной формой роста опухоли (соответственно 49,0% и 52,2%). По степени распространения метастазов у большинства больных обеих групп метастазы

отсутствовали (Т3N0M0).

Результаты и их обсуждение. После проведенной лучевой терапии было примерно одинаковое количество больных в обеих группах (соответственно 40% и 36%). Больных с частичной регрессией опухоли в I группе было немного больше (50%), чем во II группе (44%). Без эффекта оставались 10% больных I группы и 16% больных II группы. У всех больных II группы с полной регрессией опухоли через 1,5-2 года развивался рецидив, в связи с чем им, а также больным с частичной и без регрессии опухоли выполнялась ЛЭ. После ЛЭ питание больного восстанавливали через рот, а дыхание через трахеостому. Основным недостатком данной операции является утрата голосовой функции, восстановление которой с использованием логопедических методик неодинаково успешна.

Анализ полученных данных по срокам появления рецидивов и метастазов показал, что после ДГТ рецидивы и метастазы чаще развивались в сроки 1-3 года (соответственно 25% и 15%), причем они проявлялись уже в 1 год после начала лечения в 5% и 10% случаев, достигая максимума к 3 году и уменьшаясь к 5 годам до 5%. В группе больных, получивших комбинированное лечение с выполнением операции - ЛЭ, наибольшая численность больных с рецидивами и метастазами отмечена в течение первого года после начала лечения (соответственно 4% и 12%); в сроки 1-3 лет и 3-5 лет в равных количествах развивались только метастазы (по 4%), рецидивов не было.

5-летняя выживаемость в группе больных с ДГТ была также ниже (40,8%), чем в группе больных с ДГТ+ЛЭ (67,3%). При сравнении выживаемости больных этих групп данные статистически достоверны ($P < 0,05$). В этот период в I группе умерших не было, а во II группе умерло 2 (4,3%) больных.

Выводы. Таким образом, комбинированное лечение с включением ЛЭ позволило сократить в 2,7 раз развитие рецидивов метастазов на протяжении 5 лет после начала лечения, увеличить 3-х и 5-летнюю выживаемость больных по сравнению с чисто ДГТ, сократить общую смертность с 59,1% до 32,6%. Полученные данные показывают явное преимущество комбинированного метода лечения ДГТ+ЛЭ над чисто ДГТ. Однако, реабилитация больных РГ III стадии, потерявших орган после калечащей операции - ЛЭ, представляется очень трудной и до конца нерешенной проблемой. Поэтому больные часто категорически отказываются от данной операции.

ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДАМИ ИММУНОГИСТОХИМИИ И IN SITU ГИБРИДИЗАЦИИ

Пироженов О.Л.

ГККП «Онкологический диспансер», г. Астана

Одной из важнейших задач современной онкологии является адекватное лечение рака молочной железы, направленное на достижение максимального эффекта при минимальных токсических воздействиях. До сих пор выбор адекватного лечения основывался на учете степени местно-регионарного распространения опухоли (система TNM), уровня экспрессии рецепторов к стероидным гормонам и репродуктивном статусе (или, чаще, возрасте) больных. Современная диагностика опухолей включает не только верификацию гистологического варианта и степени дифференцировки, но и оценку прогноза течения заболевания, а также вероятность ответа на проводимую терапию. Определение прогностических факторов в онкологии, главным образом, зависит от иммуногистохимического статуса опухоли (морфофункциональной характеристики новообразования). Основными иммуногистохимическими маркерами, отражающими функциональное состояние опухолевых клеток при раке молочной железы, являются пролиферативная активность, экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона и экспрес-

сия онкопротеина HER2/neu (c-erbB-2). По данным O'Maller F.P. et al (2001) гиперэкспрессия HER2/neu обнаружена в 20–30% инвазивного протокового рака молочной железы, а в случаях неинвазивного рака эта величина достигает 90%. Гиперэкспрессия HER2 указывает на усиленное деление опухолевых клеток, повышение кровоснабжения опухоли, высокий риск развития метастазирования и резистентность к проводимой химиотерапии. Знание состояния гена HER2/neu и уровня экспрессии белка HER2/neu имеет важное значение для определения прогноза у больных инвазивным раком молочной железы и для отбора пациентов с наличием гиперэкспрессии HER2/neu и/или амплификации гена HER2/neu для дальнейшего лечения. Все большее значение приобретают точные, прямые и стандартные методы определения наличия гиперэкспрессии и/или амплификации HER2/neu. По данным Завалишина Л.Э. и др. (2006) в настоящее время существует несколько методов выявления гиперэкспрессии HER2/neu и/или амплификации гена HER2/neu: иммуногистохимический (ИГХ), гибридизация *in situ* (флюоресцентная и хромогенная), полимеразная цепная реакция. Однако на практике доминирующее положение занимает ИГХ-метод определения HER2-статуса рака молочной железы. При неопределенном иммуногистохимическом HER2-статусе (2+) требуется исследование, выявляющее наличие или отсутствие амплификации. Такими методами являются флюоресцентная *in situ* гибридизация (FISH) и хромогенная *in situ* гибридизация гена (CISH). Метод FISH является более чувствительным, так как позволяет напрямую оценивать наличие (или отсутствие) амплификации, но и гораздо более дорогостоящим, чем ИГХ. Метод CISH позволяет выявлять амплификацию гена HER2 под световым микроскопом и учитывать морфологическую картину ткани. Недостатками методики является ее новизна и наличие «мертвой зоны» при оценке результатов исследований, так же как и при ИГХ-исследовании. Оба метода выполняются на срезах с того же образца (блока), на котором проводилось ИГХ-исследование. Конкордантность методов FISH с использованием двухцветных зондов (на участки центромеры 17-й хромосомы и гена HER2) и CISH с использованием монокромного зонда, комплементарного только участку HER2, составляет 85%.

Следовательно, для окончательной диагностики наличия амплификации гена HER2 целесообразно использовать метод FISH, так как получаемые с его помощью результаты более точно отражают истинный HER2-статус пациентки, что крайне важно для назначения таргетной терапии. Метод CISH позволяет с высокой вероятностью выделять группу опухолей с высокой амплификацией и может использоваться в отделениях патологической анатомии, не имеющих оборудования для флюоресцентного исследования. Образцы опухолей с низкой амплификацией гена должны в обязательном порядке повторно исследоваться с помощью метода FISH.

РАК ПОЧКИ, ОСЛОЖНЕННЫЙ ТРОМБОЗОМ КРУПНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ.

Онгарбаев Б.Т., Малгельдиев Н.Н.
КазНИИОиР, отделение онкоурологии.

В мире ежегодно регистрируется 189,1 тыс. новых случаев рака почки (РП), что составляет 2,2% злокачественных новообразований у мужчин и 1,5% у женщин. Каждый год от этого заболевания погибает 91,1 тыс. пациентов [1]. В Республике Казахстан по данным 2008 года общая заболеваемость раком почки среди населения составляет 833 случая на 100 тысяч человек. На протяжении последних 5-ти лет показатель заболеваемости колеблется в пределах 5,0-5,8 на 100 тыс населения.

Материалы и методы. В отделении онкоурологии Казахского НИИ онкологии и радиологии в периоды с 2007 по 2009 год получили лечение 157 больных раком почки различных стадий.

Из общего количества пациентов у 16 больных имело место наличие опухолевого тромбоза почечной вены и нижней полой вены, что составляет 10,2% случаев. Первичный опухолевый очаг локализовался в правой почке у больных с тромбозом значительно чаще (у 12 больных – 75%), левой почки – 4 больных (25%). Средний возраст оперированных больных 54,1 года, максимальный возраст 84 года, минимальный возраст 35 лет.

В таблице-1 представлены данные о пролеченных больных раком почки в отделении онкоурологии с 2007 года

Таблица-1. Больные раком почки находившиеся на лечении в отделении онкоурологии КазНИИОиР в период 2007-2009 года

	всего	I ст	II ст	III ст	IV ст	опухолевый тромбоз	% с III - IV ст
2009	55	6	14	30	5	8 (14,5%)	63,6%
2007-2008	102	19	21	43	19	8 (7,8%)	60,8 %
ВСЕГО	157	25	35	73	24	16 (10,2%)	61,8 %

Во всех 16 случаях было выполнено радикальное хирургическое вмешательство - нефрэктомия с тромбэктомией. В 6 случаях тромб располагался на уровне почечных вен, в 1 случае – в вене надпочечника, в 6 случаях произведена тромбэктомия из НПВ при субпеченочном расположении тромба, в 3 случаях - при ретропеченочном расположении тромба. В 1 случае у больного имелся опухолевый тромб распространяющийся с левой почки в ретропеченочный отдел НПВ, а ниже уровня отхождения почечных вен имелся сформированный кровяной тромб. Во время операции после проведения тромбэктомии опухолевого тромба из НПВ, удаление кровяного сформированного тромба не производилось, в связи с высоким риском тромбоэмболических осложнений. Учитывая наличие сформированного коллатерального кровотока больному произведена перевязка нижней полой вены ниже уровня отхождения почечных сосудов.

Выводы. Хотя венозная инвазия ухудшает выживаемость больных раком почки, радикально выполненная операция может дать шанс больному на продление жизни и выздоровление независимо от протяженности опухолевого тромба. С появлением эффективных методов лекарственного воздействия выделение групп различного прогноза может оказаться полезным для решения вопроса о назначении адъювантного лечения.

ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ

Нургалиев Н.С.

КазНИИОиР, отделение онкоурологии

Введение. Одной из наиболее сложных проблем, после проведенных радикальных цистэктомий является выбор метода деривации мочи. Такие операции обеспечивают относительно удовлетворительное качество жизни пациентам, однако, сопровождаются довольно значительным количеством ранних и поздних осложнений. Летальность, связанную с осложнениями в раннем послеоперационном периоде зачастую удается снизить выработкой оптимальной тактики лечения, согласно распространенности процесса, общего состояния больного и приобретенным опытом хирургов. Это в свою очередь согласуется с данными разных авторов, занимающихся данной проблемой.

Комплексная профилактика и лечение поздних послеоперационных осложнений после любых методов деривации мочи остается актуальной проблемой для онкоурологов и хирургов. Проблема лечения больных с кишечной пластикой мочевого пузыря объясняется тяжелым течением инфекци-

онных процессов, расстройствами водно-электролитного баланса, риском развития гиперхлоремического метаболического ацидоза, диареи, снижением иммунореактивности организма, остеопороза, камнеобразования.

Материал и методы. В нашем отделении в период 2005-2009 гг (включительно) произведено 110 радикальных цистэктомий. По выбору методов дренирования мочи после проведенных 110 радикальных цистэктомий в 3 случаях применена методика «сухой» уростомы, в 10 случаях – двусторонняя уретерокутанеостомия, 27 операций с созданием илеумкондуита по Бриккеру, в 18 наблюдениях нами применена методика ортотопического резервуара по Штудеру и 52 операции по методике Хаутмана.

Около 30% больных (32 пациента) находятся под наблюдением в нашем институте, периодически согласно срокам динамического наблюдения проходят весь перечень обследования. Нами выявлены следующие основные поздние осложнения.

Результаты. После уретерокутанеостомии практически у 100% пациентов развивается восходящий пиелонефрит, бактериурия. При этом более характерна вялотекущая форма пиелонефрита, без яркой клинической симптоматики, но стойкая, трудно поддающаяся противовоспалительной терапии и в динамике в сроки от 6 мес до 1,5-2 лет прогрессирует в ХПН с развитием всей характерной для него картины.

У пациентов с илеумкондуитом по Бриккера также наблюдается восходящий пиелонефрит, периодически с обострениями, но достаточно хорошо поддается противовоспалительной терапии. Кишечные расстройства не столь ярко выражены при соблюдении диеты. Наибольшее количество осложнений здесь обусловлено с погрешностями ухода за стомами, развитие различных местных воспалительных реакций в области стом.

Пациенты с ортотопическим мочевым пузырем составили наибольшую группу наблюдения (18 пациентов). Частота воспалительных осложнений с развитием восходящего пиелонефрита наблюдалось у 95%, примерно у 25% периодически ярко выраженные атаки пиелонефрита, что требовало назначения мощных антибактериальных препаратов. Кишечные расстройства в виде диареи, нарушение водно-электролитного баланса, картины метаболического ацидоза наблюдались примерно в 30%. Около 90% пациентов отмечают дискомфорт в виде недержания мочи по ночам, что требует использования прокладок (1-2 прокладки за ночь). Тем не менее, большинство пациентов удовлетворены наличием у них самостоятельного акта мочеиспускания.

Выводы. Выбор метода деривации мочи зависит от стадии рака мочевого пузыря (РМП), анатомо-физиологических особенностей и функционального состояния желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), верхних мочевых путей и почек. При любом из вышеперечисленных методов деривации мочи имеют место различные поздние осложнения. Наиболее предпочтительными являются операции с созданием ортотопического мочевого пузыря и илеумкондуита по Бриккера. Правильно выполненная операция и последующие профилактические мероприятия улучшают качество жизни данных пациентов.

МАРКЕРЫ КЛЕТОЧНОГО И ЦИКЛА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЕ

Полатова Д.Ш.

Республиканский Онкологический Научный Центр,
Узбекистан, Ташкент

Задача исследования. определение экспрессии p53 и bcl-2 в опухолевых клетках а также изучение спектра aberrаций хромосом в мононуклеарах периферической крови больных с остеогенной саркомой.

Материал и методы. Было проведено обследование цитогенетическим методом 22 пациентов в возрасте от 14 до 20 лет (13 юношей, 9 девушек). Экспрессию белков p53 и bcl-2 изучали с использованием моноклональных антител к p53 (клон ДО-7) «Дако» и к bcl-2 (NCL-bcl-2 -486) «Novocastra». До проведения исследования лечение пациенты не получали.

Результаты. Наличие aberrаций хромосом от 9,0 до 19,1% отмечено у всех больных. Цитогенетический анализ типов aberrаций хромосом показал наличие видимых делеций хромосомы 22 (22 p-) в 9 случаях (у 6 юношей и 3 девушек), у 2 больных были обнаружены множественные микрофрагменты, у остальных больных (6 юношей и 5 девушек) в кариотипе лимфоцитов стимулированных ФГА, обнаружены делеции 4, 13, 18 и X-хромосом, а также фрагменты различной величины и малые двойные хромосомы. Результаты иммуногистохимического анализа, особенностей экспрессии белков p53 и bcl-2 в опухолевых клетках, свидетельствуют о том, что положительная реакция определялась не во всех клетках, не у всех больных. Белковый продукт мутантного гена апоптоза p53 выявлен в ядрах опухолевых клеток у 15 больных (9 юношей и 6 девушек), в относительных случаях результаты иммуногистохимической реакции были отрицательными. Количество p-53 – положительных опухолевых клеток колебалось от 25 до 50% у 4/6 больных юношей и у всех девушек, а от 50 до 98% у остальных 4/7 юношей. Экспрессия, которая кодирует белок-экспрессор апоптоза, выявлен у 6 больных юношей и 6 девушек. Количество bcl-2-положительных клеток было высоким (до 90%) только у одной больной девушке, а в остальных случаях положительная реакция наблюдалась только в 50% клеток и ниже, при этом реакция на мутантный p53 (mtp53) ген имела отрицательный характер.

Выводы. Потеря хромосомного материала приводит к снижению экспрессии гена или даже к полной потере белкового продукта. Определение спектра молекулярно-генетических повреждений, характерных для остеогенной саркомы позволяет использовать их в качестве маркеров для диагностики и прогноза этого заболевания, а также выработки тактики лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Нургалиев Н.С., Онгарбаев Б.Т., Кенжебаев Б.Ж.
Казахский НИИ ОиР, отделение онкоурологии.

Рак предстательной железы (РПЖ) — одно из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у мужчин среднего и пожилого возраста. За период с конца 1970-х до начала 1990-х годов частота раковых заболеваний предстательной железы почти удвоилась [4]. Согласно последним данным, в 2000 г. в США зарегистрировано 180 400 новых случаев заболевания раком простаты и 31 900 больных скончались от этого заболевания, в Европе — 200 000 и 40 000 соответственно. В структуре онкологических заболеваний в ряде стран РПЖ выходит на 2—3-е место после рака легкого и желудка, а в США и Швеции — на 1-е место. Вместе с тем среди причин смерти мужчин от злокачественных новообразований РПЖ в настоящее время занимает 2-е место после рака легкого. Летальность на первом году жизни после установления диагноза составляет около 30%, что свидетельствует о крайне низкой выявляемости заболевания в начальных его стадиях. По данным канцеррегистра за 2008 год по Республике Казахстан заболеваемость раком предстательной железы составила 3,7 на 100 тыс. человек, смертность 2,1 на 100 тыс. человек. В 2008 году с впервые в жизни установленным диагнозом взято на учет 581 больных раком простаты. Контингент больных на 2008 год составлял 2198 человек. Удельный вес запущенных форм в 2008 году составил 17,7% (больные с IV стадией).

Материалы и методы: В онкоурологическом отделении Каз

НИИ Оир с 2008 по 2010 год было проведено 22 радикальных простатэктомии. Диагноз локализованного рака простаты был установлен на основании комплексного обследования включающего определение уровня ПСА, ПРИ, УЗИ и трансректальное УЗИ простаты с мультифокальной биопсией, скинтиграфию скелета и МРТ органов малого таза. Уровень колебания ПСА составлял от 8 до 22 нг/мл. Сумма баллов по шкале Глиссон составляла от 3 до 7 баллов. Оперативное вмешательство проводилось из стандартного доступа в объеме радикальной позадилобной простатэктомии.

Результаты лечения: длительность операции составляла от 150 до 240 мин. Кровопотеря составила от 500 до 1500 мл (средний объем около 700 мл). После операции по данным планового гистологического исследования у 3 больных выявлена экстракапсулярная инвазия опухоли предстательной железы – Т3а No Mo, у 1 пациента было выявлено врастание опухоли в семенные пузырьки – Т3NoMo, и 17 пациентов стадия Т2 No Mo. Положительный хирургический край выявлен в одном случае.

Все больные активизировались на 1-2 сутки после операции. У всех больных использовались наркотические анальгетики в течении 2 дней. Уретральный катетер удалялся на 12 сутки после операции. У двух пациентов в раннем послеоперационном периоде отмечалась несостоятельность уретрального анастомоза, в одном случае несостоятельность устранена консервативно после длительного до 20 дней удержания уретрального катетера. В одном случае потребовалось повторное хирургическое вмешательство. У остальных пациентов осложнений не наблюдалось. Сроки наблюдения за больными составляют от 3 до 12 месяцев.

Выводы: В данном наблюдении представлен первый опыт проведения радикальных простатэктомий в нашей клинике. Для увеличения количества радикальных операций необходимо проведение тщательного отбора пациентов, улучшение ранней диагностики рака предстательной железы в общей лечебной сети и внедрение программы скрининга рака предстательной железы в целом по Республике Казахстан.

ОБЫР АУРУЫН АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ТИІМДІЛІГІ

Сандыбаев М.Н., Зейнелова Л.Т., Жұмықбаева Н.К., Елемесов Н.Н.

Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері

Академик Н.Н.Петровтың (1947) пікірі бойынша обырдың себептері туралы біз көп білеміз, обырға қарсы күрес мәселесін алдын алу релсіне қою мүмкіндік қана емес, қажеттілік. Бірақ, тұрғындар арасында жүргізілетін обырға қарсы ағартушылық жұмыстар қазақстандағы алдын алу (профилактикалық) жұмыстарды жүзеге асыратын бірден – бір бағыт болып табылады.

Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері мамандары Семей қаласы Мемлекеттік медициналық университеті онкология кафедрасымен бірлесе отырып, диспансердің сыртқы қызметіне қатысты обырға қарсы күресті ұйымдастыру жүйесін жасады.

Зерттеу мақсаты. Семей өңірінде 2008 -2009 жыл аралығы кезеңдегі обырға қарсы күрестің тиімділігіне зерттеу жүргізу.

Материалдары мен әдістері. Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансеріндегі 2008-2009 жыл аралығы кезеңіндегі деректер бойынша қатерлі ісіктерді ерте анықтау және асқынудың статистикалық көрсеткіштеріне салыстырмалы түрде талдау жүргізілді. 2005-2009 жылдар аралығында онкология диспансерінің қызметкерлерімен 79 мақала, 98 теледидардан және радиодан қатерлі ісіктерді алдын-алу мақсаты жөнінде 30 баяндама жасалды.

Қорытынды. Семей қаласының Өңірлік онкологиялық диспансері мамандары Семей қаласы Мемлекеттік медициналық университеті онкология кафедрасымен

бірлесе отырып, диспансердің сыртқы қызметіне қатысты обырға қарсы күресті ұйымдастыру жүйесін жасады. Сонымен, статистикалық талдау деректері негізінде мынадай қорытынды жасауға болады, онкологиялық диспансер мамандары жүргізіп жатқан мазмұны мен түрі жағынан әртүрлі ағартушылық жұмыстар Семей аймағындағы қатерлі ісіктердің ерте анықтауды жақсартуға, онкологиялық аурулардың асқыну жағдайларын төмендетуге және қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың өміршеңдігін ұзартуға қол жеткізуге мүмкіндік туғызды.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ САРКОМ КОСТЕЙ ТАЗА

*Серикбаев Г.А., Тулеуова Д.А., Косаев А.К., Савхатов Д.Х.
КазНИИОиР, г. Алматы*

Первичные злокачественные опухоли костей – группа ЗН, развивающихся из тканей скелета. Первичные ЗН костей наблюдаются редко. В отличие от большинства других распространенных ЗН, злокачественные опухоли костей чаще возникают у лиц молодого возраста (в среднем 28-32 года). Чаще поражаются длинные трубчатые кости и кости таза.

Цель работы: выработка оптимального объема хирургического вмешательства при опухолях тазовой кости.

В отделении опухолей костей и мягких тканей в период с 2000 по 2010 гг. хирургическое лечение проведено 48 пациентам. У всех больных была 111-1У стадия заболевания. У 38 (79,2%) выявлена хондросаркома, у 2 (4,2%) – злокачественная фиброзная гистиоцитома, у 8 (16,6%) – гигантоклеточная опухоль.

Объем хирургического вмешательства был различен и зависел от распространенности опухолевого процесса:

- резекция подвздошной кости проведена 8 (16,6%) пациентам;
- резекция седалищной и лонной кости - 6 (12,5%);
- резекция лонной кости - 2 (4,1%);
- резекция тазовой кости с сохранением н/конечности в 5 (10,4%) случаях;
- межподвздошно-брюшная ампутация у 27 (56,2%) больных.

Послеоперационной летальности не было. У 3 (6,2%) пациентов наблюдался частичный некроз заднего лоскута. После некрэктомии заживление происходило вторичным натяжением. Различные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдались у 4 (8,3%) – у лиц старше 60 лет.

После резекции подвздошной и лонной костей, через 2-3 месяца больные самостоятельно ходили без посторонней помощи.

Внутренняя резекция таза, т.е. полное удаление подвздошной, седалищной и лонных костей вместе с головкой бедренной кости, была показана при опухолях образующих безымянную линию, но без распространения на прилегающие мягкие ткани. Через 2-3 месяца больные передвигались с помощью костылей с частичной опорой на конечность. Через 9-12 месяцев больной полностью опирался на конечность и передвигался с помощью трости или ходунков. Отмечено укорочение конечности, в среднем на 5см, при этом движения в коленном и голеностопном суставах полностью сохранены.

Выводы:

1. Объем оперативного вмешательства при опухолях тазовой кости зависит от локализации опухоли, степени распространенности процесса.

2. Внутренняя резекция тазовой кости является операцией выбора, и может выполняться при нераспространенном опухолевом процессе.

3. При правильно спланированной тактике (объема резекции, предоперационной подготовки, подготовленности хирурга) можно значительно уменьшить послеоперационные осложнения.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Серикбаев Г.А., Тулеуова Д.А., Косаев А.К., Савхатов Д.Х.,
Примкулова Р.З.
КазНИИОуР, г. Алматы

Саркомы мягких тканей являются относительно редким заболеванием. От всех онкологических заболеваний составляет 2%, и 1% в структуре смертности. Наиболее встречаются фибросаркомы, злокачественные фиброзные гистиоцитомы, липосаркомы, лейомиосаркомы, синовиальные саркомы.

Факторами, ассоциированными с неблагоприятным прогнозом больных саркомами мягких тканей являются пожилой возраст (старше 60 лет), распространенность опухоли (более 5см), степень ее злокачественности.

Саркомы мягких тканей – злокачественные, агрессивно текущие опухоли, склонные к развитию отдаленных метастазов и локальных рецидивов. Возникновение рецидивов зависит от объема хирургического вмешательства. После иссечения опухоли рецидивы возникают у 80-90% больных, а после широкого иссечения – только у 10-20%. Поэтому, не-радикальное удаление опухоли является одним из факторов неблагоприятного прогноза заболевания и требует скорейшего широкого иссечения опухоли.

Цель работы: выработка оптимального объема хирургического вмешательства при злокачественных опухолях мягких тканей.

За период с 2005 по 2009 годы через отделение опухолей костей и мягких тканей прошло 132 первичных больных со злокачественной опухолью мягких тканей. Гистотип опухоли был различен, таблица 1.

Назология	Кол- %	Стадия / %	
		III	IV
Фибросаркома	26 / 19,7	24 / 92,3	2 / 7,7
Дерматофибросаркома	20 / 15,1	20 / 100,0	-
Синовиальная саркома	26 / 19,7	25 / 96,1	1 / 4,9
Злокачественная фиброзная гистиоцитома	25 / 18,9	22 / 88,0	3 / 12,0
Липосаркома	19 / 14,4	19 / 100,0	-
Рабдомиосаркома	16 / 12,1	15 / 93,7	1 / 6,3
Всего	132	125 / 94,7	7 / 5,3

Всем больным первым этапом проведено хирургическое лечение:

- Удаление опухоли с резекцией мышц, ребер, перикарда, диафрагмы с пластикой дефекта грудной стенки 12 (9,1);
- Широкое удаление опухоли (фулярное удаление), с пластикой дефекта и без 95 (71,9);
- Широкое удаление опухоли с резекцией участка артерии, вены с пластикой сосудистым эндопротезом 2(1,5);
- Межподвздошно-брюшная ампутация 4 (3,0);
- Межлопаточно-грудная ампутация 6 (4,5);
- Экзартикуляция суставов (тазобедренный, плечевой) 5 (3,8);
- Ампутация(н/ в/конечности) 8 (6,1)

Низкий процент осложнений достигнут путем тщательной предоперационной подготовкой, коррекцией сопутствующей патологии, выбора оптимального объема хирургического вмешательства.

Объем хирургического вмешательства зависел от стадии заболевания, морфологического строения опухоли, распространенности опухолевого процесса.

СЦИНТИГРАФИЯ СКЕЛЕТА И РАДИОИММУННЫЕ АНАЛИЗЫ ПРИ МЕТАСТАЗАХ БЕЗ ВЫЯВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА

Тажединов И.Т., Хан О.Г., Алпеисова Ш.Т.,
Серикбаев Г.А., Тулеуова Д.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы

Цель исследования – улучшение диагностики патологических изменений в костях у онкологических больных.

Материал и методы: Сцинтиграфия скелета на гамма-камере Philips Forte (Германия) с 99mTc-технофор проводилась 27 пациентам с метастазами без выявленного первичного очага. Для метки технофора («Радиопрепарат», Узбекистан) использован «Натрий пертехнетат 99mTc, раствор для инъекции» из переносного гель-генератора, разработанного ИЯФ НЯЦ РК.

Результаты исследования. У 5 мужчин выявлены метастазы в костях таза, позвоночника, ребер в виде гиперфиксации остеотропного РФП. У этих больных уровень ПСА, определенный методом РИА, был высоким (10,0 нг/мл и выше) и составил 71,5±10,1 нг/мл. У трех женщин выявлены очаги в костях с интенсивным накоплением 99mTc-технофора и опухолевый маркер СА 15-3 был высоким (40,0 МЕ/мл и выше) 101,7±14,3 МЕ/мл.

У одного пациента с выявлением изменений в костях по результатам гистологии биоптата установлен диагноз лимфогранулематоз.

Таким образом, радионуклидные исследования скелета больных с метастазами, без выявленного первичного очага с технофором, меченным «Натрий пертехнетат 99mTc - раствор для инъекции» из переносного гель-генератора, разработанного ИЯФ НЯЦ РК, позволяют диагностировать наличие патологических изменений в костях, характерных для некоторых опухолей с метастазами в скелет. При этом рекомендуется определить в сыворотке крови специфический антиген предстательной железы ПСА у мужчин, у женщин – СА 15-3, для диагностики опухолей молочной железы.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ ПИЩЕВОДНОГО СОУСТЬЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА.

Букенов А.М., Рахманова Б. А., Мадыкенов Р. О.
Кафедра онкологии, лучевой терапии с курсами общей
хирургии, травматологии и ортопедии ФНПР КГМУ.
Карагандинский областной онкодиспансер.

Причины возникновения несостоятельности швов пищевода различны. Одни [Бондарь Г.В., Байдалин Ю.Д., 1971] хирурги считают основной причиной чрезмерную мобилизацию пищевода, другие [Ганул Л.В., Шевчук А.С., 1979] – снижение репаративной способности ткани пищевода, в связи с гнилостными процессами, развивающимися в пищеводе выше места обтурации. Не менее важным считают уровень резекции пищевода [Кулаевская В.Г., 1980, Странадко Е.Ф., 1980], резекция пищевода на расстоянии близком к опухоли может привести к несостоятельности швов пищевода.

По мнению Русанова А. А. [1973] главной причиной возникновения несостоятельности пищевода являются технические погрешности, допущенные при формировании анастомоза, т.е. недостаточная квалификация хирурга. Поэтому изучение частоты несостоятельности швов пищевода в зависимости от способа наложения анастомоза является одной из актуальных задач клинической онкологии.

Цель исследования – уменьшить частоту несостоятель-

ности швов пищеводного соустья при хирургическом лечении рака желудка.

Материалы и методы.

Анализируются истории болезни 287 больных, находившихся на обследовании и лечении с диагнозом: Рак проксимального отдела и тела желудка за период с 1990-2004г.г. Послеоперационная летальность на 287 операций составила $17,1 \pm 2,2\%$ (умерло 49).

Независимо от оперативного доступа и объема операций ведущей причиной летальности явилась несостоятельность пищеводного соустья $44,8 \pm 5,6\%$ (35 из 287 операций) среди всех осложнений. Летальность при чресплевральном и чрезбрюшинном доступе составила соответственно $23,5 \pm 3,6\%$ (32 из 136 операций) и $11,3 \pm 2,6\%$ (17 на 151 операцию), статистически разница существенна ($p < 0,05$).

Обсуждение результатов.

Послеоперационная летальность от недостаточности швов пищеводного соустья значительно ниже при использовании анастомоза по способу Сапожкова - Юдина – $13,3 \pm 6,0\%$ (умерло 6), по сравнению с летальностью при использовании способа Гиляровича - Грэхема – $27,3 \pm 7,7\%$ (умерло 9), разница статистически существенна ($p < 0,05$). Значительного снижения летальности не было отмечено при использовании инвагинационного анастомоза с расширяющим швом Блохина, которая составила $24,4 \pm 6,4\%$, разница статистически не достоверна ($p > 0,05$) по сравнению с выше названными способами (из-за небольшого количества наблюдений). Нами разработан способ формирования погружного пищеводного соустья (авт. свидетельство № 45123, авторы Нам Э. Н., Буkenov А. М.). Послеоперационная летальность от несостоятельности пищеводного соустья сведена до минимума за счет внедрения усовершенствованного погружного анастомоза, при котором не наблюдалось данного осложнения. При муфтообразном анастомозе по Г. В. Бондарю отмечено в $5,6 \pm 2,4\%$ (5 осложнений на 90 операций) случаев несостоятельности пищеводного соустья, а среди всех осложнений она составила $33,3 \pm 12,6\%$ (5 случаев на 15 осложнений). Из пяти больных с несостоятельностью пищеводного соустья при муфтообразном анастомозе погибли $3,3 \pm 1,9\%$ (умерло 3) пациента.

Сравнительный анализ частоты несостоятельности пищеводного соустья и ее летальности убеждает нас в правомерности выбора погружного анастомоза при хирургическом лечении рака желудка.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННОЙ ГАСТРЭКТОМИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА

Султаналиев Т.А., Джумабеков А.Т., Жанталинова Н.А., Жораев Т.С.

АГИУВ, кафедра хирургии, Алматы, НЦНМ, Астана РК

Цель. Улучшение результатов расширенной гастрэктомии при распространенном раке желудка (РРЖ).

Введение. Исход хирургического лечения распространенного рака желудка зависит от многих факторов: стадии и гистологического типа опухоли, регионарного и отдаленного метастазирования, уровня поражения лимфоузлов. Основным методом лечения РРЖ является гастрэктомия [Давыдов М.И. и др., 1998; 2002; Черноусов А.Ф. и др. 2000]. Этот вид вмешательства в последние годы возросла до 70% [Жерлов Г.К. и др., 1998; Клименков А.А. и др., 1998]. Неудачные исходы после гастрэктомии чаще всего обусловлены несостоятельностью швов анастомоза. Но в последние годы отмечается снижение летальности до 5-7% [Давыдов М.И. и др., 2002; Земляной А.Г. и др., 1994; Черноусов А.Ф. и др., 2000].

Материал и методы. Представлены результаты хирургического лечения 91 больного в период 1990-2010 г.г. с РРЖ, которым была выполнена гастрэктомия. Из общего числа

больных мужчины составили 79,1%, женщин – 20,9% в возрасте от 35 до 72 лет.

Преобладали больные с проксимальной локализацией опухоли (35,2%) и тела желудка (34,1%), в антральном отделе – 24,2%, поражение двух отделов желудка отмечено у 6 (6,6%) пациентов. По стадиям характеризовались: Т3 – у 68 (74,7%), Т4 – у 23 (25,3%).

По степени дифференцировки опухоли высокодифференцированная аденокарцинома (G1) выявлена в 38 (41,7%) случаях, умеренно-дифференцированная (G2) – в 21 (23,1%), низкодифференцированная (G3) – в 32 (35,2%).

Среди сопутствующих заболеваний преобладала патология сердечно-сосудистой (46,7%) и дыхательной (23,4%) системы.

Результаты. Расширенная гастрэктомия с лимфодиссекцией в объеме D2 выполнена у 50,5%, D3 – у 49,5% больных. Во всех случаях проксимального рака желудка и локализации опухоли в теле, а также при поражении нескольких отделов выполнена спленэктомия. Из общего числа оперированных пациентов (91) в 19 (20,9%) случаях ввиду прорастания опухоли в близлежащие органы и структуры выполнены комбинированные операции: резекция печени, поперечнободочной кишки, хвоста и тела поджелудочной железы. Гастрэктомия завершена в 7 (7,7%) случаях наложением пищеводно-дуоденального анастомоза (ПДА) и в остальных 84 (92,3%) наблюдениях выполнен пищеводно-кишечный анастомоз (ПКА) по М.И. Давыдову. У 11 (12,1%) больных рак желудка осложнилось кровотечением и при этом 1 пациента оперировали на высоте кровотечения. Симультантные операции выполнены у 11 (12,1%) больных, при этом у 10 – холецистэктомия и у 1 больного – резекция аневризмы брюшного отдела аорты. В этой группе осложнений не наблюдалось.

В раннем послеоперационном периоде у 5 (5,5%) больных развилась несостоятельность швов анастомоза при этом у 1 пациента с наложенным ПДА, что привело к развитию перитонита и летальному исходу. У остальных 4 пациентов несостоятельность швов носила ограниченный характер и улавливалось оставленным контрольным дренажом, что не потребовало повторного вмешательства. Исход в этих случаях был благоприятный. Внеабдоминальные осложнения наблюдались в 19 случаях, что составило 20,9%, в основном послеоперационные пневмонии (10), экссудативный плеврит (7) и в 2 случаях – инфаркт миокарда с летальным исходом. Общая послеоперационная летальность составила 3,3%.

Выводы. Преимущества методики наложения ПКА по М.И. Давыдову при распространенном раке желудка заключается в надежности, в плане развития несостоятельности швов анастомоза. Таким образом, применение способа ПКА по М.И. Давыдову после гастрэктомии способствует улучшению непосредственных результатов лечения рака желудка.

ОБ ИСХОДНОЙ ПОДГОТОВКЕ ХИРУРГОВ К ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ.

Олжаев С.Т., Тельгозин Е.Т.,

Байдилбеков С.А., Зайнидинов Р.Р.

АО «Медицинский университет Астана», г. Астана.

«Алматинский региональный онкологический диспансер»

Актуальность. В повседневной деятельности врачей-хирургов часто возникает необходимость диагностики злокачественных новообразований, распространенность которых с каждым годом увеличивается среди различных контингентов и возрастных групп населения.

Цель. Выявить исходную готовность врачей-хирургов к диагностике злокачественных новообразований, имеет большое практическое значение.

Материал и методы. Проведено социологическое исследование среди врачей-хирургов некоторых регионов Казахстана. Умение правильно поставить диагноз и провести

необходимое лечение злокачественных новообразований.

Результаты. По раку желудка знания в полном объеме продемонстрировали 60,0% респондентов. В эту группу вошли врачи города Алматы – 7,7%, Павлодарской, Алматинской и Южно-Казахстанской областей, соответственно, 23,1%, 13,8%, 15,4%. Неуверенные умения показали 32,3% врачей: города Алматы (10,8%), Алматинской области (6,2%), Южно-Казахстанской и Атырауской (7,7%). Отсутствие этих знаний выявлено у 3,1% респондентов города Алматы. Затруднились ответить 4,6% врачей города Алматы (1,5%) и Алматинской области (3,1%).

Диагностику и лечение рака прямой кишки уверенно могут осуществить 64,6% респондентов. Среди них врачи города Алматы – 7,7%, Павлодарской области – 16,9%, Алматинской – 18,3%, Южно-Казахстанской – 21,5%. Недостаточный уровень квалификации установлен у 27,7% специалистов (город Алматы – 10,8%, Павлодарской, Алматинской, Южно-Казахстанской и Атырауской, соответственно, 4,6%, 3,1%, 1,5% и 7,7%). 3,1% опрошенных города Алматы такими знаниями не владеют. Затруднились ответить на данный вопрос 4,6% опрошенных (по 1,5% врачей города Алматы, Павлодарской и Алматинской областей).

Что касается рака молочной железы, то при этом заболевании достаточно компетентными были 58,5% опрошенных. В их числе врачи города Алматы – 7,7%, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей (18,5%), Алматинской – 13,8%. Не в полном объеме владеют знаниями 33,8% респондентов, в том числе из города Алматы (9,2%), Павлодарской и Южно-Казахстанской областей (по 4,6%), Алматинской и Атырауской (по 7,7%). Не выявлены такие знания у 4,6% врачей города Алматы и затруднились ответить на этот вопрос 3,1% врачи Алматы и Алматинской области – по 1,5%).

Выводы. Проведенные исследования показывают разный уровень исходной готовности врачей-хирургов к диагностике и лечению злокачественных новообразований. Эти результаты диктуют необходимость проведения среди врачей-хирургов систематических и целенаправленных учебных мероприятий, а также самоподготовки на рабочем месте по вопросам ранней, дифференциальной диагностики и лечения злокачественных новообразований, которые обеспечат лучшее качество плановой хирургической помощи населению.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПУХОЛЕВОГО АНГИОГЕНЕЗА И ВАСКУЛЯРНОЙ ИНВАЗИИ ПРИ РАКЕ ТЕЛА МАТКИ

*Абдулаханова Р.Р., Кожаметов Б.Ш.,
Тлеугабилова Г.А., Есентаева С.Е.
Алматинский государственный институт
совершенствования врачей*

Актуальность. В литературе имеются сообщения о том, что плотность сосудов как мера опухолевого ангиогенеза, имеет важное прогностическое значение для больных раком тела матки (Каки Т. et al, 2000). Авторы обнаружили, что количественная плотность сосудов важна в прогнозе метастазов и выживаемости больных. Плотность микрососудов коррелирует с гистологическим типом опухоли, инвазией в сосуды, в лимфатическую стенку. Больные с большим количеством сосудов (более 60) имели худший прогноз и выживаемость.

Цель работы. Определить влияние опухолевого ангиогенеза на эффективность лечения больных местнораспространенным раком тела матки.

Материалы и методы. В основу работы положены материалы 67 больных раком эндометрия I стадии, прооперированных в Казахском НИИ онкологии и радиологии. Диагноз верифицирован гистологически в 100% случаев. Возраст больных колебался от 30 до 60 лет и старше. Степень васку-

ляризации оценивали по трехбалльной системе:

1. выраженная -- более 10 сосудов в поле зрения;
2. умеренная - от 5 до 10 сосудов в поле зрения;
3. слабая - менее 5 сосудов в поле зрения.

Коэффициент относительного риска (ОР) рассчитывали по формуле, предложенной В.В.Двойриным и В.А.Кашеевым (1980):

$OP = a.c/b.d$, где а и с - числа больных в двух группах, подверженных действию изучаемого фактора, b и d - количество умерших в данных группах. Балльная оценка отдельных признаков производилась на основе расчетов показателей относительного риска по четырехбалльной таблице Стюкениса М.К.(1984).

Результаты и выводы. Результаты исследования позволили сделать заключение, что чаще встречалась умеренная степень инвазии, в 41,8±6,0% случаев, и гораздо реже слабая - в 25,4±5,3% случаев.

При минимальной величине рака выраженная васкуляризация опухоли была обнаружена в (27,3±0,5)% случаев, при распространении опухоли была до 2/3 полости матки - в (45,5±15,0)%, а при поражении всей полости матки - в (18,8±9,8)%. Это позволило заключить, что степень распространения рака в полости матки не связана с выраженностью васкуляризации его стромы.

При сопоставлении выраженности васкуляризации опухоли и степени ее инвазии установлено, что хорошо васкуляризированные опухоли независимо от степени ее инвазии встречались у каждой 3-й больной. Вместе с тем, слабо васкуляризированные опухоли обнаруживались у (45,5±15,0)% при отсутствии инвазии в миометрий. При глубокой инвазии их процент в 2 раза меньше - (25,0±12,5)%, но разница статистически незначима. Иными словами, степень васкуляризации опухоли не влияет на степень ее инвазии в миометрий.

При анализе состояния васкуляризации различных типов рака эндометрия выявлено, что высокая степень васкуляризации характерна для половины низкодифференцированных аденокарцином, примерно такое же количество железисто-плоскоклеточного рака и 100% - серозно-папиллярных раков.

Относительный риск умереть зависит от степени васкуляризации опухоли, подсчитанный на основе теста logrank, при выраженной васкуляризации составляет 1,6, что в 2,5 выше по сравнению со слабой и умеренной васкуляризацией (0,63).

Таким образом, при прогностически неблагоприятных морфологических формах рака (низкодифференцированная аденокарцинома, серозно-папиллярный и железисто-плоскоклеточный раки) эндометрия выраженная васкуляризация стромы наблюдалась довольно часто (50-100%), хотя отмечается низкая корреляция между степенью опухолевого ангиогенеза и эффективностью лечения.

ЭЗОФАГЕАЛЬНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА

*Жураев Ш.Ш., Шайхиев Е.У., Байтилеуов Т.А.,
Садыков Н.К., Шокебаев А.А., Маметова Т.А.
Национальный Научный Центр Хирургии им. А.Н.
Сызганова, г. Алматы*

По данным Европейской организации противораковых институтов (ОЕЦИ), рак пищевода занимает восьмое место среди всех онкологических заболеваний в Мире. Радикальная хирургическая резекция опухоли, на момент обращения пациентов в стационар, возможна менее чем в половине случаев, вследствие местной распространенности опухолевого процесса либо обширного метастазирования. По этой причине, в лечении пациентов с опухолевой обструкцией пищевода на первый план выходят паллиативные методы.

На сегодняшний день, во многих развитых странах Мира

«золотым» стандартом паллиативного лечения больных с неоперабельными формами рака пищевода признан метод эзофагеального стентирования. Данная технология имеет ряд преимуществ: саморасширяющиеся проволочные стенты можно устанавливать даже при весьма выраженных стриктурах; в силу своих механических свойств, они оказывают постоянное дилатирующее действие на суженный участок пищевода; из-за незначительной толщины и эластичности стенок стентов, возможность их закупорки пищей ничтожна; стенты, покрытые биологически инертными пленками, способны идеально герметизировать просвет пищевода. Все эти качества делают саморасширяющиеся стенты незаменимыми для устранения дисфагии при обтурации просвета пищевода опухолью.

Целью нашей работы явилось внедрить метод эзофагеального стентирования в клиническую практику ННЦХ им. А.Н. Сызганова для устранения синдрома дисфагии онкологического генеза.

В Национальном научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова метод эзофагеального стентирования внедрен в практику с 2009 года. За это время, произведена установка 20 эзофагеальных стентов Boubella-E, производства компании «Ella-CS» (Чехия). Специальная конструкция данных стентов практически исключает их миграцию, а, наличие антирефлюксного клапана позволяет предупредить пищеводный рефлюкс. Установка стентов проводилась под рентгенологическим и эндоскопическим контролем, после предварительного бужирования пищевода. При этом, непосредственный технический успех был достигнут в 100% случаев. Серьезных осложнений при проведении стентирования в наших наблюдениях не было. К незначительным можно причислить кровотечение из опухоли малой интенсивности (6 случаев). У всех 20 пациентов была восстановлена возможность к естественному употреблению пищи, что значительно улучшило качество жизни данных больных.

РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ И ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кулишов В.А.

Областной онкологический диспансер, г. Караганда

Актуальность: В Республике Казахстан рак молочной железы возглавляет рейтинг злокачественных опухолей у женщин (17,7%), то есть ежегодно в Казахстане более 2,5 тыс. женщин заболевают этим видом рака. Высокая заболеваемость и выраженная гетерогенность рака молочной железы определяют актуальность реабилитации при этой опухоли.

Реконструкция молочной железы при раке весьма серьезная проблема, позволяющая успешно решать психосоциальную и трудовую реабилитацию больных.

Цель работы: совершенствование реконструктивно-пластических операций у больных раком молочной железы в комплексе с лучевой и химиогормонотерапией, обеспечивающих высокие показатели безрецидивной пятилетней выживаемости, а также ранней реабилитации.

Материалы и методы: Работа основана на анализе результатов лечения 1078 больных, находящихся в отделении общей онкологии «Карагандинского Областного Онкологического диспансера» с 1986 по 2009 гг. с диагнозом: Рак молочной железы. Возраст пациенток был различным. Самой юной было 19 лет и пожилой 78 лет, до 30 лет – 14 (1,4), от 31-40 лет – 115 (11,3), от 41-50 лет – 473 (46,3), от 51-60 лет – 345 (33,8), от 61-70 лет – 50 (4,9), > 70 лет – 24 (2,3). Как видно более высокая заболеваемость была у пациенток до 50 лет (59,8%) – 599, старше 50 лет – 419 (41,2%), средний возраст составил $49,1 \pm 1,3$ случая.

По степени распространенности опухолевого процесса распределение оказалось следующим: I ст. (T1 N0 M0) – 242 (23,7%), T2 – 436 (42,8%), T3 – 338 (33,1%), T4 – 2 (0,2%).

Размеры опухоли колебались от 0,5 до 15 см, но в большинстве случаев (83,8%) составляла от 0,5 – 5 см. Среди гистологических форм наиболее часто встречался дольковый рак в 28,3%. Хирургическое лечение получили – 257 (25,2±1,4%), комбинированное – 471 (46,3±1,5%), комплексное – 293 (28,8±1,4%). Функционально-щадящие операции (Пейти-Диссона, Маддена) – 653 (64,1±8,0%). Органосохраняющие операции (Радикальная резекция молочной железы) – 194 (19,1±1,2%). Реконструктивно-восстановительные маммопластики (первичные и отсроченные) – 171 (16,7±1,2%), из них первичная маммопластика кожно-мышечным лоскутом широчайшей мышцы спины (КМЛ-ШМС) и эндопротезированием с кожносохраняющей мастэктомией выполнена у 27 (15,8%), первичная маммопластика КМЛШМС и эндопротезированием с Радикальной мастэктомией (Пейти, Маддену) – 62 (36,3%). Первичная маммопластика ТРАМ-лоскутом и кожносохраняющей мастэктомией – 6 (3,5%). Первичная маммопластика ТРАМ-лоскутом и радикальная мастэктомия – 54 (31,6%). Отсроченная маммопластика КМЛШМС с эндопротезированием – 22 (12,8%). Отсроченная маммопластика ТРАМ-лоскутом – 3 (1,7%).

В группе функционально-щадящих ранние и поздние осложнения преобладали после операции Пейти, составляя соответственно – 110 (10,8±0,9%) и 104 (10,2±0,9%).

Одногодичная и трехлетняя выживаемость составляет 98,2±0,5% и 78,5±0,6%. Пятилетняя выживаемость пациентов равнялась 65,9±1,8%.

В группе больных, которым выполнены органосохраняющие операции осложнения, составили – 21 (2,1±0,4%). Одногодичная выживаемость составила 100%, трехлетняя 98%, пятилетняя 70%, безрецидивная трехлетняя выживаемость составила 95%, пятилетняя 65%.

В группе больных с реконструктивно-восстановительными маммопластическими ранние осложнения отмечены в 13 (7,6±2,0%) случаях и поздние осложнения у 16 больных, т.е. 9,4±2,2%. Трехлетняя выживаемость составила 72,5±4%, пяти- и десятилетняя выживаемости составили соответственно 64,3±4,5% и 44,4±3,8%.

Таким образом, отдаленные результаты лечения рака молочной железы зависят в основном от степени распространенности опухолевого процесса, а на качество жизни пациенток влияет объем и характер выполненных операций (щадящая мастэктомия, органосохраняющая операция или реконструктивная маммопластика).

ОТДАЛЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ФЕНОТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Малышев Н.В.¹, Тургунов М.Б.¹, Омарова И.М.²,

Кулишов В.А.², Перминов В.С.², Уйсин А.Х.²

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан¹, КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан²

Актуальность – использование молекулярной классификации рака молочной железы позволяет индивидуализировать назначение системного лечения и улучшить результаты общей и безрецидивной выживаемости.

Цель исследования – выявление зависимости времени жизни больных раком молочной железы от морфологического фенотипа опухоли.

Материалы и методы исследования. В данное исследование были включены 313 пациенток раком молочной железы, получавших специальное лечение в Карагандинском областном онкологическом диспансере в 2006 году. Экспрессия ER, PR и Her2/neu определялась с помощью иммуногистохимиче-

ского анализа в соответствии с национальными и международными рекомендациями 2006 года. Опухоль классифицировалась, как ER и/или PR положительная при окрашивании более 10% опухолевых клеток. Оценка экспрессии Her2/neu проводилась по шкале Нерсер-Test: 0-1+ - отрицательная экспрессия, 2-3+ - положительная экспрессия.

Все больные разделены согласно классификации Perou C. M. et al. (2000) и Sorlie T. et al. (2001) на 4 основные группы в зависимости от фенотипа опухоли, основанного на изучении трех иммуногистохимических параметров ER, PR, Her-2/neu.

Базальноподобный тип опухоли (ER-PR-Her-2/neu-) имели 37 больных (1 группа), позитивный тип (ER-PR-Her-2/neu+) – 41 пациентка (2 группа), люминальный A тип опухоли (ER+PR+Her-2/neu-) имели 173 больных (3 группа) и люминальный B тип опухоли (ER+PR+Her-2/neu+) – 62 пациентки (4 группа). Распределение больных по стадиям рака во всех группах было в процентном отношении гомогенным. Используя компьютерную программу «Statistica 5.5» больным всех групп определены средние значения времени жизни и безрецидивного периода, проведено сравнение по Т-критерию Стьюдента и χ^2 . Определена 3-летняя безрецидивная и общая выживаемость больных по таблицам дожития.

Полученные результаты и обсуждение

ИГХ фенотип	Фенотип по Perou	Ср. время без рецидива, мес.*	Ср. время жизни, мес.*	3-летняя безрецидивная выживаемость, %	3-летняя общая выживаемость, %
ER-PR-Her-2/neu-	Базальный	28.5±1.2	31.3±0.9	67.6±4.6	74.3±4.3
ER-PR-Her-2/neu+	Her2/neu+ фенотип	24.5±1.6	28.8±1.3	51.5±6.1	63.2±5.8
ER+PR+Her-2/neu-	Luminal A	31.7±0.9	34.3±0.6	79.0±4.0	90.5±2.9
ER+PR+Her-2/neu+	Luminal B	29.4±1.8	33.4±1.0	68.6±7.8	82.6±6.4

* - время диспансерного наблюдения - 3 года

Безрецидивная выживаемость статистически значимо отличалась у групп 1 и 2 ($p<0.05$), 1 и 3 ($p=0.006$), 2 и 3 ($p=0.00004$), 2 и 4 ($p=0.02$).

Различия по общей выживаемости были достоверны между группами 1 и 2 ($p=0.046$), 1 и 3 ($p=0.04$), 2 и 3 ($p=0.00009$), 2 и 4 ($p=0.05$).

Заключение. Таким образом, полученные результаты показывают, что наличие базального фенотипа и сверхэкспрессия Her2/neu оказывают статистически значимое отрицательное воздействие на общую и безрецидивную выживаемость. Наличие люминального A фенотипа коррелировало с наилучшей выживаемостью.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ ПРИ ОПУХОЛЯХ ОРОФАРЕНГИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.

У.С. Мамедов¹, М.А. Гафур-Ахунов².

Республика Узбекистан. Бухарский областной онкологический диспансер¹. Республиканский Онкологический Научный Центр².

Цель: Изучить результаты шейной лимфадиссекции регионарных метастазов шеи с символами N2-3 в комплексном лечении при злокачественных опухолях головы и шеи.

Материалы и методы: В отделении опухолей головы и шеи Бухарского областного онкологического диспансера в период с 2007-2009 года 41 больным с местно-распространенными регионарными метастазами на шее было выполнено различные объемы шейной лимфадиссекции с удалением первичной опухоли. По распространенности первичной опухоли и поражение регионарных метастазов установлено, что T1-4N2M0- 30 больных и T2-4N3M0- 11 больных. Всем больным было проведено предоперационная лучевая терапия на зону регионарного метастазирования и первичной опухоли СОД 40 Гр. и полихимиотерапия по схеме Цисплатин 100 мг. м2+ Фторурацил 1000 мг. 1-4 дни. После проведенного лечения из

них 16 больным произведена операция Крайля и 25 больным фасциально-фуллярное иссечение клетчатки шеи.

Результаты: В сроке наблюдения от 3 до 12 месяцев у 14 больных после проведенного оперативного вмешательства обнаружены рецидивы метастазов. У 8 больных в сроке наблюдения выявлены регионарные метастазы в шейные лимфатические узлы на противоположной стороне поражения. Состояние метастазов оценивалось как N1-2. Этим больным были произведены стандартные лимфаденэктомии.

Выводы: Таким образом, частота рецидивов регионарных метастазов шеи после хирургического лечения за период от 1 года и 3 лет составило 34,1%. Предоперационная химиолучевая терапия не может улучшить показатели выживаемости больных. Для улучшения показателей хирургического метода лечения регионарных метастазов опухолей головы и шеи с символами N2-3 требует новых подходов и модификаций хирургического метода лечения.

УШИВАНИЕ ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ СОБСТВЕННЫМИ ТКАНЯМИ С РАЗДЕЛЬНЫМ АКТИВНЫМ ДРЕНИРОВАНИЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ ПО MADDEN

Танжарыков Е.С.

Городской онкологический диспансер, Алматы

Важной проблемой хирургической онкоматологии является возникновение ранних и поздних осложнений после радикальных мастэктомий (РМЭ). Так,

лимфорея (ЛР) развивается у всех пациентов, которым была проведена РМЭ, впоследствии приводя к развитию воспалительных изменений в области послеоперационной раны, грубых рубцовых изменений в области лимфаденэктомии, постмастэктомического синдрома (ПМЭС).

Цель работы: разработка новой хирургической методики эффективной профилактики ЛР и ПМЭС после РМЭ.

Материал и методы: Основой работы явился анализ 149 больных раком молочной железы (РМЖ) отделения маммологии городского онкологического диспансера, средний возраст которых составил 58 лет. Контрольную группу составили 85 пациенток, которым выполнена РМЭ по Madden, основную – 64 больных, которым была использована новая хирургическая методика – ушивание подмышечной области собственными тканями с раздельным активным дренированием подмышечной впадины и области передней грудной клетки. Всем больным проводилось измерение длительности и количества выделяемой по дренажам и эвакуируемой пункционно лимфы, оценка развития воспалительных изменений в области послеоперационной раны, болевого синдрома и ПМЭС.

Результаты: В контрольной группе после РМЭ по Madden средний объем (срV) ЛР составил 1653 мл при среднем количестве дней – эвакуаций лимфы (КДЭЛ) – 21 день. После РМЭ по Madden с ушиванием подмышечной области собственными тканями с раздельным активным дренированием послеоперационной раны срV = 980 мл при КДЭЛ = 13. В контрольной группе ранние раневые осложнения (воспалительные изменения в области послеоперационной раны) после РМЭ по Madden были выявлены у 7 (8%) больных, постмастэктомический отек I-II степени развился у 10 (12%), болевой синдром – у 19 (22%). В основной группе ранние раневые осложнения после РМЭ по Madden отмечены у 3 больных (4,7%), постмастэктомический отек I-II степени – у 5 (7,8%), болевой синдром – у 16 (25%) пациенток.

Выводы: Новая разработанная методика ушивания подмышечной области собственными тканями с раздельным активным дренированием подмышечной впадины и области

передней грудной клетки показала свою эффективность в профилактике длительной и обильной послеоперационной ЛР и развития ПМЭС у больных РМЖ. Использование новой методики при РМЭ позволило сократить объем и длительность ЛР на 40,7% и 8 дней соответственно, уменьшить раневые осложнения на 3,3%, частоту развития постмастэктомического отека I-II степени на 4,2%. Отмечено увеличение (на 3%) болевого синдрома в основной группе по сравнению с контрольной группой, однако болевой синдром в основной группе был кратковременным и на качество жизни больных в дальнейшем не влиял. Положительные результаты применения новой хирургической методики позволяют рекомендовать ее к широкому применению в хирургических стационарах онкологического профиля.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ.

Баймаханов Б.Б., Сейсембаев М.А., Наржанов Б.А., Сахипов М.М., Токсанбаев Д.С., Чорманов А.Т., Миржакыпов А.Т., Баймаханов Ж.Б.

ННЦХ им. А.Н. Сызганова, отделение хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы

Резекция печени остается операцией выбора среди многочисленных хирургических подходов в ведении категории пациентов с различными опухолями печени. Центральным вопросом, определяющим исход оперативного лечения, при резекциях печени, в особенности обширных и предельно обширных, является проблема снижения интраоперационной кровопотери, послеоперационных геморрагических осложнений.

Цель: изучение некоторых принципов кровосбережения при выполнении резекционных вмешательств на печени у больных с опухолевыми и другими очаговыми заболеваниями печени.

Материал и методы: За период с 2004 по 2010гг выполнено 110 резекционных вмешательств на печени по поводу различных ОПП. Размеры очагов варьировали от 4 до 30см в диаметре. Пациенты в возрасте от 2 до 74 лет находились на лечении в отделении хирургии печени, желчных путей, поджелудочной железы ННЦХ им. А.Н. Сызганова.

Использование современного специфического для резекций печени оснащения использовалось у всех больных. В частности, процесс «бескровного» разделения паренхимы печени производили с помощью ультразвукового скальпеля (UltraCision Harmonic Scalpel). В обработке сосудистых структур применяли клипп-аппликаторы с наложением танталовых клипс. Желаемый коагуляционный эффект по резекционной поверхности печени достигался применением потока аргоновой коагуляции и адгезией фибрин-коллагеновой субстанции «ТахоКомб». С целью профилактики больших кровопотерь операции сопровождалась применением приема Прингла (пережатие гепатодуоденальной связки). Восполнение кровопотери при значительных кровотечениях (2 случая) производилось с помощью кровосберегающего оборудования «Секвестр -1000».

Результаты: С применением современных специфических технологий благодаря отработанной технике выделения элементов глиссоновых и кавальных структур в группе больных с анатомическими обширными резекциями без применения приема Прингла удалось достоверно снизить общую операционную кровопотерю с 711 до 375мл.

Вывод: По мере накопления опыта технического исполнения резекционных вмешательств, при условии наличия оснащения операционной специфическим оборудованием и средствами гемостаза выполнение анатомических обширных резекций печени без афферентной сосудистой изоляции представляется тактикой выбора.

ЭВИСЦЕРАЦИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА КАК ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМЫ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ.

Тилляшайхов М.Н., Абдурахмонов Д.К., Шукруллаев Ш.А., Абдикаримов М.Г., Вахобов О.У., Гринберг В.В., Болтаев М.И.
Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз, Ташкент.

Материалы и методы исследования. Проанализировано 56 больных раком шейки матки в стадии Т4И0-1М0, с прорастанием в мочевой пузырь и с метастазами в регионарные лимфоузлы. Гистологически у всех больных верифицирован плоскоклеточный неороговевающий рак. Основную группу составили 36 больных (64,3%), из них у 12 больных имело наличие пузырно-влагалищного свища (33,3%) и им всем была выполнена передняя эвисцерация органов малого таза с различными методами деривации мочи с 2006 по 2010 годы в урологическом отделении РОНЦ. В 14 случаях выполнена передняя эвисцерация с созданием искусственного мочевого пузыря из восходящей толстой кишки, с аппендикостомией (38,9%). Троем больным за счет уретерогидронефроза (нефункционирующая почка по данным экскреторной урографии) выполнена передняя эвисцерация с односторонней нефрэктомией (8,3%) и уретерокутанеостомией. Десяти больным выполнена эвисцерация с двусторонней уретерокутанеостомией (27,8%). Девяти больным выполнена эвисцерация с созданием мочевого резервуара по Брикеру (25%). Контрольную группу составили 20 (35,7%) больных, ранее получавшие химио и/или лучевую терапию и выписанные на симптоматическую терапию. Из них у 12 имело место явление двустороннего гидронефроза (60%), у 6 наличие одностороннего (30%) гидронефроза и этим больным проводили одно или двухстороннюю перкутанную нефростомию для улучшения качества жизни.

Результаты: В основной группе в раннем послеоперационном периоде одна больная умерла на 12-ые сутки от тромбоза легочной артерии (2,8%). У двух больных основной группы имело место послеоперационная эвентерация передней стенки брюшины, что потребовало хирургической коррекции (5,6%). У одной больной через пять месяцев после операции констатирована спаечная кишечная непроходимость, что также потребовало хирургического вмешательства (2,8%). Трехлетняя выживаемость в контрольной группе составило 10% (2 больных), а в основной группе 86,1% (31 больных).

Выводы: Эвисцерация органов малого таза при осложненном раке шейки матки с созданием мочевого резервуара характеризуется удовлетворительными ближайшими и отдаленными результатами. В результате проведенных нами комплексных лечений у данной категории больных значительно продлилась жизнь (трехлетняя выживаемость 86,1%).

ПРИМЕНЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БОЛЬНЫМ С ОПУХОЛЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА.

Тилляшайхов М.Н., Абдурахмонов Д.К., Эргашев О.Н., Султонов Б.Б.

Республиканский онкологический научный центр, Ташкент.

Задачи исследования: оценить роль симптоматических операций больным с опухолями органов малого таза, прорастающие в соседние органы.

Материалы исследования. Проанализированы 25 историй болезней больных с опухолями органов малого таза, в стадии Т4И0М0, ранее получавших химио и/или лучевую терапию. Возраст больных колебался от 26 до 70 лет. Из них: 13 больных страдали раком шейки матки (52%), 4 больных раком прямой кишки (16%), 8 больных раком мочевого пузыря (32%), с прорастанием в соседние органы. Возраст больных

колебался от 24 до 72 лет (средний возраст 48 лет). Всем больным была предложена экзистенциальная операция малого таза с различными вариантами деривации мочи, от которой они отказались. В этот период у 22 больных (88%) имело место повышенный уровень мочевины и креатинина в крови (> 8.5 ммоль/л и > 0.115 ммоль/л), у 14 больных (56%) боль в поясничных областях и у 20 анорексия (80%). У 16 больных имела суправезикальная обструкция, (64%), а у 7 инфравезикальная обструкция (28%).

Результаты: После проведения чрезкожной нефростомии и чрезкожной цистостомии выше указанным больным - у 24 мочевины снизилась до уровня нормальных показателей (96%).

Таким образом: у больных с местно-распространенными формами опухолей малого таза, несмотря на имеющиеся осложнения со стороны мочевыделительной системы с нарушением уродинамики, после паллиативных операций выполненных с целью ликвидации явлений уретерогидронефроза и хронической задержки мочеиспускания, улучшилось качество жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОСТНОГО ЦЕМЕНТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Тожибоев А.А., Гафур-Ахунов М.А., Абдикаримов Х.Г.
РОНЦ МЗ РУз, г. Ташкент

Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности хирургического лечения гигантоклеточной опухоли трубчатых костей с использованием медицинского костного цемента.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 89 больных, с диагнозом гигантоклеточной опухоли трубчатых костей, которым при хирургическом лечении использовали медицинский костный цемент. Мужчин – 35 (39,3%), женщин – 54 (59,7%). Возраст больных колебался от 14 до 60 лет. В 28 (31,5%) случаях опухоль локализовалась в бедренной, в 34 (38,2%) – большеберцовой, в 6 (6,7%) – плечевой, в 1 (1,1%) – локтевой, в 7 (7,9%) – лучевой, в 13 (14,6%) – фаланги пальцев. Во всех случаях диагноз верифицирован гистологическим исследованием. У 14 (15,7%) выявлен злокачественный и у 75 (84,3%) – доброкачественный вариант гигантоклеточной опухоли. Рентгенологически у 51 больного (57,4%) выявлена ячеисто-трабекулярная, у 19 (21,3%) – остеолитическая и у 19 (21,3%) – смешанная форма опухоли. Размер поражения кости составил от 2 до 12 см. У 75 больных поражение было от 1/3 до 1/2 полуокружности кости. Все больные распределены на 3 группы. 1-группа - экскохлеация и цементопластика - 48 больных, 2-я группа - экскохлеация, криовоздействия и цементопластика – 27 больных, 3-я группа - экскохлеация, аутопластика и цементопластика - 14 больных.

Результаты. Больные прослежены от 6 месяцев до 5 лет. Как показали результаты анализа в первой группе больных из 48 больных у 5 (10,4%), во 2-группе из 27 больных у 1 (3,7%) и в 3-ей группе из 14 больных у 2 (14,3%) выявлен рецидив опухоли. Сроки появления рецидивов составили от 6 до 21 месяцев. В связи с рецидивом опухоли у 3 (3,4%) больных произведены калечащие операции. У 2 (2,2%) больных отмечен патологический перелом на уровне цементопластики. Из 89 больных у 79 (88,7%) получены хорошие функциональные результаты.

Заключение. Результаты проведенного исследования показывают, что использование медицинского костного цемента при гигантоклеточных опухолях трубчатых костей, является эффективным методом хирургического лечения больных опухолями костей. Этот вид хирургического лечения менее сложен в исполнении, позволяет замещать большие дефекты костной ткани и экономически доступен большинству онкологических больных.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ НИЗКОЛОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПОСЛЕ СФИНКТЕРОСБЕРЕГАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Хожаев А.А., Кайдаров Б.К., Балтаев Н.А., Адиев М.М., Баймухаметов К.К., Шапаева У.К., Тасбулатов З.О.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Городской онкологический диспансер, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Проблема улучшения качества жизни (КЖ) больных раком прямой кишки (РПК) продолжает оставаться в центре внимания онкологов, что связано с высокой степенью инвалидизации этих пациентов. Это обусловлено анатомо-функциональными нарушениями, неизбежно следующими вследствие оперативных вмешательств.

Цель работы: определение основных показателей КЖ у больных РПК после низких сфинктеросберегающих операций.

Материал и методы. В исследование включено 58 больных раком среднеампулярного отдела прямой кишки II-III стадии, находившихся на лечении в Городском онкологическом диспансере г. Алматы в 2008-2009 гг. Из них 37 больных, которым выполнена низкая передняя резекция прямой кишки (НПРПК) с тотальной мезоректумэктомией, составили основную группу, 21 пациент, которому произведена брюшно-анальная резекция прямой кишки (БАРПК), – контрольную. Инструментом оценки КЖ больных РПК после проведения его языковой и культурной адаптации был модульный опросник Европейской организации исследования и лечения рака – EORTC QLQ-C30 (version 3) с модулем EORTC QLQ-CR29, содержащий 59 вопросов и состоящий из 5 функциональных шкал, 3 шкал симптоматики, шкалы общего КЖ, 6 одиночных пунктов, а также 29 вопросов, составляющих специфический модуль EORTC QLQ-CR29.

Результаты. Анализ результатов исследования в основной группе по отношению к контрольной группе показал, что статистически значимые различия ($p < 0,05$) по среднему баллу шкал опросника EORTC QLQ-C30, модуль EORTC QLQ-CR29 были выявлены по функциональным шкалам PF (физическое функционирование), RF (ролевое функционирование), EF (эмоциональное функционирование), SF (социальное функционирование) и модульной шкале, отражающей специфические проблемы. Показатели частоты локо-регионарных рецидивов и безрецидивной выживаемости в сравниваемых группах не имела достоверных отличий ($p > 0,05$).

Выводы. Комплексная оценка КЖ больных низколокализованным РПК показала, что в аспекте КЖ больных в послеоперационном периоде НПРПК с тотальной мезоректумэктомией является более предпочтительной операцией по сравнению с БАРПК.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ

Хожаев А.А., Кайдаров Б.К., Балтаев Н.А., Адиев М.М., Баймухаметов К.К.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Городской онкологический диспансер, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Несмотря на разработку сшивающих аппаратов и совершенствование хирургической техники, значительному числу больных колоректальным раком (КРР) на сегодняшний день формируется искусственный абдоминальный задний проход, что обусловлено как распространённостью, так и осложнениями самого опухолевого процесса. Восстановление целостности кишечного тракта является основным и определяющим этапом в комплексе реабилитационных мероприятий у этих пациентов.

Цель работы: улучшение качества жизни (КЖ) стомиро-

ванных больных КРР.

Материал и методы. В исследование включено 48 больных КРР II-III стадий заболевания, находившихся на лечении в Городском онкологическом диспансере г. Алматы в 2008-2009 г.г. и которым ранее в плановом или экстренном порядке были выполнены об-структивные резекции толстой кишки с формированием концевой абдоминальной колостомы с культей отключенной кишки: а) в левом боковом канале – 9, б) в малом тазу – 23, в) под тазовой брюшиной («короткая культи» прямой кишки) – 16 больных. Из них 13 больным выполнены реконструктивно-восстановительные операции с использованием механических аппаратных швов, а 35 больным – ручных двух- и однорядных швов. Несостоятельность межкишечного анастомоза составила 2,1%. КЖ оперированных пациентов изучалось с помощью опросника Европейской организации исследования и лечения рака – EORTC QLQ-C30 (version 3), состоящего из 5 функциональных шкал, 3 шкал симптоматики, шкалы общего КЖ и 6 одиночных пунктов.

Результаты. Сравнительная оценка показателей КЖ больных КРР до восстановительной операции и во всех точках обследования после ликвидации колостомы показал, что статистически значимые различия ($p < 0,05$) по среднему баллу шкал опросника EORTC QLQ-C30 были выявлены по шкале общего КЖ (QL), функциональным шкалам: физическое функционирование (PF), ролевое функционирование (RF), эмоциональное функционирование (EF), социальное функционирование (SF) и шкале, отражающей финансовые затруднения (FI). Коэффициент «трудовой реабилитации» составил $85,4 \pm 5,5\%$.

Выводы. Выполнение реконструктивно-восстановительных операций, как хирургического этапа медицинской реабилитации у стомированных больных КРР, позволяет значительно улучшить их КЖ и подавляющему числу пациентов вернуться к труду.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КАК ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАКЕ КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Эгамбердиев Д.М., Струцкий Л.П., Джуроев Ф.М.

*Онкологический научный центр Узбекистана,
Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент*

Актуальность: Рак желудка в республике Узбекистан, как и во многих государствах, прочно занимает 1 место в структуре онкопатологии. Ежегодно первично регистрируют около 1800 больных с диагнозом рак желудка. Помимо общей мировой тенденции снижения рака антрального отдела желудка, в республике существуют и национальные особенности, где более 60 больным устанавливается рак проксимального отдела желудка с переходом на н/3 пищевода или рак кардиоэзофагеального отдела.

Цель: Улучшить результаты лечения и качество жизни больных нерезектабельным раком кардиоэзофагеальной зоны, осложненной дисфагией III-IV стадии.

Материалы и методы: С целью восстановления проходимости пищи по пищеводу в клинике РОНЦ совместно с СЦХ МЗ РУз разработана методика поэтапной эндоскопической электрокоагуляции опухоли пищевода с реканализацией и эндопротезированием. С этой целью после обычной премедикации больным проводится эзофагоскопия и с помощью электрода проведенного через биопсийное отверстие проводится коагуляция опухоли. Чтобы открыть проходимость понадобится 3-4 сеанса с интервалом 2-3 дня. После восстановления проходимости и реканализации по конфигурации кардиоэзофагеальной зоны изготавливается соответствующий эндопротез из искусственного материала с учетом протяженности по 2 см выше и ниже процесса, и устанавливаются с помощью эндоскопического аппарата. Через час после установки эндопротеза больным разрешается принимать пищу. Исследование проводилось у 36 больных

раком кардиоэзофагеальной зоны, осложненной дисфагией III-IV стадии. Мужчин – 32, женщин – 24.

Результаты: Из 56 больных, у 1 больного отмечались сильные боли после установки эндопротеза, что вынудило нас убрать его на 3 сутки. Других осложнений, связанных с эндопротезированием не наблюдалось. Изучение непосредственных результатов через 3 недели и в более отдаленные сроки показали, что у 3 больных в просвете эндопротеза застревал комок твердой пищи, который устранялся после эндоскопической санации. У 55 (98,2%) больных из 56, результаты эндопротезирования по объективным и субъективным данным оценивались на хорошо и отлично, у 1 больного неудовлетворительно.

Вывод: Поэтапная термоэлектрокоагуляция при нерезектабельном раке кардиоэзофагеальной зоны, осложненной дисфагией III-IV стадии, является методом выбора, которая быстро устраняет явления дисфагии и улучшает качество жизни больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Юсупов Б.Ю., Шукуров З.И., Абдурахимов О.Н.

Республиканский онкологический научный центр МЗ РУз

Местно-распространенное поражение с прорастанием верхних дыхательных и пищеварительных путей при злокачественных опухолях щитовидной железы является сложной проблемой онкохирургии.

Цель: улучшение результатов лечения местнораспространенного рака щитовидной железы.

Материалы и методы. С 2003 по 2009 год под наблюдением находилось 28 больных в возрасте от 18 до 72 лет. Из 28 больных у 12 (42%) отмечалось явление стеноза верхних дыхательных путей 1-2 ст. и у 6 (21,4%) пациентов дисфагия различной степени. После комплексного обследования до операции установлено прорастание опухоли щитовидной железы в глотку у 3-х (10,7%) пациентов. Прорастание опухоли в трахею у 5(17,8%) пациентов.

16(57%) пациентам проведена химиолучевая терапия с предоперационной целью и через три недели произведены расширенные комбинированные операции. У 12(42,8%) пациентов по жизненным показаниям первым этапом выполнена операция.

Лимфодиссекция, тиреоидэктомия с резекцией стенки гортаноглотки выполнена 5(17,8%) больным, с резекцией стенки трахеи у 16(57%) пациентам, 7(25%) пациентам резекция трахеи и гортани. Из 23 пациентов, которым выполнена резекция верхних дыхательных путей у 19(82,6%) сформирован трахеостом или ларинготрахеостом. Одномоментная пластика стенки глотки выполнена у всех 5 пациентов. Одномоментная пластика верхних дыхательных путей выполнена 4-м пациентам.

Вывод: выполнение радикальных расширенно-комбинированных операций с резекцией пораженных соседних органов улучшает качество жизни и выживаемость пациентов.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

Юсупов Б.Ю. Хатамов Ш.Н.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз

Несмотря на достигнутые успехи современной онкохирургии проблема хирургического лечения новообразований основания черепа остается мало изученным.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 7 больных с опухолями основания

черепе оперированных в отделении опухолей головы и шеи РОНЦ г.Ташкент. Из 7 больных, было 3 мужчин, 4 женщин, в возрасте от 19 до 45 лет. Гистологически были верифицированы у 3 больных ангиофиброма, у 2-плоскоклеточный рак и у 2-саркома. Во всех случаях хирургический доступ произведен через верхнечелюстную пазуху. В 5 случаях опухоль удалена радикально, в 2 — произведена циторедуктивная операция. Интраоперационная кровопотеря в 2 случаях достигал до 900мл, гемостаз произведен использованием медицинского цемента. Послеоперационный период у 4 больных протекал гладко, у 2-в послеоперационном периоде наблюдалось массивная ликворея. Ликворею в 1 случае не удалось купировать.

Заключение. Таким образом удаление опухолей основания черепа трансмаксиллярным доступом утяжеляет радикальное удаление опухоли и требует использования различных модификаций комбинированных доступов.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ.

*Юсупов Б.Ю., Абдурахимов О.Н., Полвонов А.Ч.
РОНЦ МЗ РУз. Ташкент, Узбекистан*

Цель исследования. Оценить результаты паротидэктомии и паротидэктомии с одновременной пластикой ретромандибулярной зоны лоскутом из поверхностной фасции и мышцы шеи (m.Sternocleidomastoideus и m.Platyzma) при плеоморфной аденоме околоушной слюнной железы.

Материалы и методы. В исследование включены 40 больных (1 группа) которым произведена паротидэктомия и 23 больных (2 группа) которым произведена паротидэктомия с одновременной пластикой ретромандибулярной зоны лоскутом из поверхностной фасции и мышц шеи (m.Sternocleidomastoideus и m.Platyzma). У всех больных морфологически верифицирована плеоморфная аденома околоушной слюнной железы. Возраст больных составлял от 5 до 62 лет.

Результаты: В 1 группе послеоперационный период у 11 (27,5%) больных осложнился синдромом Льюси-Фрея (гипергидроз в околоушной области, покраснения, гиперэстезия кожи, боль во время еды), а также парез лицевого нерва наблюдался в периоде от 2 до 6 мес. У больных 2 группы вышеуказанный синдром не наблюдался. Парез лицевого нерва наблюдался в течении 2-4 мес.

Выводы. Оптимальным объемом операции при плеоморфной аденоме околоушной слюнной железы является паротидэктомия с одновременной пластикой ретромандибулярной зоны лоскутом из поверхностной фасции и мышцы шеи.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

*Якубова М.Б., Байназарова А.А., Югай К.В.
Казахский Национальный медицинский университет
им. Асфендиярова, г. Алматы, Южно-Казахстанский
областной онкологический диспансер, г. Шымкент*

Рак шейки матки (РШМ) является одной из наиболее распространенных опухолей у женщин.

В настоящее время рентгеноэндоваскулярные вмешательства являются важной составляющей в терапии больных с местнораспространенным раком шейки матки и локорегионарными рецидивами заболевания в случаях кровотечения и болевого синдрома. Регионарная химиотерапия является компонентом комбинированного лечения больных с локализованными стадиями заболевания в качестве адъювантной или неоадъювантной терапии.

Целью настоящей работы явилось изучить непосредственные результаты лечения больных с РШМ с применением

методики химиоэмболизации.

Материал и методы. Начиная с июля 2008г. нами на базе областного онкологического диспансера внедрена методика одномоментной болюсной химиоинфузии селективно во внутренние подвздошные артерии (ВПА) с последующей эмболизацией маточных артерий у больных раком шейки матки. Лечение подверглись 22 пациенток в возрасте от 33 до 48 лет. У всех больных была IIa-IIb стадия процесса (T2N0M0 — T2bN0M0). В устья ВПА вводили болюсно химиопрепараты со скоростью 2мл/с. В основном применяли схему FAP (Фторурацил 1гр/м2, Адриобластин 60мг/м2, Цисплатин 80мг/м2). Далее селективно катетеризировали маточную артерию на стороне исследования (слева) и производили эмболизацию гемостатической губкой. После выполнения процедуры эмболизации перемещали в аорту и выполняли катетеризацию второй (правой) ВПА и после инфузии химиопрепаратов эмболизировали маточную артерию. Если необходима одномоментная катетеризация обеих ВПА, производили пункцию и установку катетеров с обеих сторон контра- или ипсилатеральным методом. Из 12 больных повторную процедуру провели 13 больными.

Результаты и их обсуждение. Анализ непосредственных результатов лечения показал эффективность методики у всех 22 больных (100%). У 8 больных было отмечено остановка кровотечения из опухоли шейки матки на следующие сутки после процедуры. У 9 больных отмечено купирование болевого синдрома внизу живота. При контрольном осмотре через 1 месяц у всех больных была отмечена частичная регрессия опухоли с уменьшением опухолевого узла по данным контрольного УЗИ на 40-60%. 10 больных успешно прооперированы (радикальная расширенная гистерэктомия), остальным пациенткам проведен курс лучевой терапии по радикальной программе. Анализ осложнений показал, что в основном осложнения были связаны с проведенной химиотерапией. У 15 больных отмечена тошнота и рвота, у 3 лейкопения 2-3 степени, у 2 анемия 2 степени, которые купировались консервативной терапией. Осложнений связанных с эмболизацией нами не отмечено.

Выводы.

В настоящее время большинством исследователей доказана целесообразность широкого практического применения регионарной химиоинфузии с эмболизацией маточных артерий в лечении больных раком шейки матки. В связи с этим вопрос о ее применении следует рассматривать как один из эффективных методов комбинированного и комплексного лечения больных раком шейки матки. Артериальная эмболизация является малотравматичным и эффективным способом остановки кровотечения из опухоли шейки матки, а также создает дополнительную ишемизацию опухоли, что повышает эффективность непосредственных результатов лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ ПРИ ОПУХОЛЯХ ОРОФАРЕНГИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.

*Мамедов У.С.¹, Гафур-Ахунов М.А.².
Республика Узбекистан. Бухарский областной
онкологический диспансер¹. Республиканский
Онкологический Научный Центр².*

Цель: Изучить результаты шейной лимфадиссекции регионарных метастазов шеи с символами N2-3 в комплексном лечении при злокачественных опухолях головы и шеи.

Материалы и методы: В отделении опухолей головы и шеи Бухарского областного онкологического диспансера в период с 2007-2009 года 41 больным с местно-распространенными регионарными метастазами на шее было выполнено различные объемы шейной лимфадиссекции с удалением первичной опухоли. По распространенности первичной опухоли и поражение регионарных метастазов установлено, что T1-

4N2M0- 30 больных и T2-4N3M0- 11 больных. Всем больным было проведено предоперационная лучевая терапия на зону регионарного метастазирования и первичной опухоли СОД 40 Гр. и полихимиотерапия по схеме Цисплатин 100 мг. м2+ Фторурацил 1000 мг. 1-4 дни. После проведенного лечения из них 16 больным произведена операция Крайля и 25 больным фасциально-фулярное иссечение клетчатки шеи.

Результаты: В сроке наблюдения от 3 до 12 месяцев у 14 больных после проведенного оперативного вмешательства обнаружены рецидивы метастазов. У 8 больных в сроке наблюдения выявлены регионарные метастазы в шейные лим-

фатические узлы на противоположной стороне поражения. Состояние метастазов оценивалось как N1-2. Этим больным были произведены стандартные лимфаденэктомии.

Выводы: Таким образом, частота рецидивов регионарных метастазов шеи после хирургического лечения за период от 1 года и 3 лет составило 34,1%. Предоперационная химиолучевая терапия не может улучшить показатели выживаемости больных. Для улучшения показателей хирургического метода лечения регионарных метастазов опухолей головы и шеи с символами N2-3 требует новых подходов и модификаций хирургического метода лечения.